

상담의 기본개념 / 1주차 1차시

1. 상담의 정의와 상담의 3요소

1) 상담의 정의

- 치료자(또는 상담자)와의 안전한 관계에서 내담자가 과거에 부정했던 경험을 다시 통합하여 새로운 자기로 변화하는 과정'(Rogers, 1952, p.70)
- 개인적 발달의 방향으로 현명한 선택이 이루어지도록 촉진하는 것'(Tayler, 1969, p.13)
- 내담자의 자기 이해, 의사결정 및 문제해결이 이루어지도록 상담자가 전문적으로 도와주는 과정'(Pietrofesa, Leonard, & Van House, 1978, p.6)
- 심리치료는 두 사람(두 사람 이상이 될 수도 있지만) 사이의 상호작용으로 이루어짐. 그중의 한 명인 환자 또는 내담자는 도움을 받을 수 있다고 생각되는 문제를 해결하기 위해서 치료받고자 함. 나머지 한 사람은 필요한 치료적 도움을 제공할 수 있도록 전문적인 훈련을 받고 필요한 자원을 가지고 있는 치료자. 이러한 두 사람 사이의 상호작용은 제스처, 동작, 표정, 감정표현을 통해서도 이루어지지만 주로 언어를 통해서 이루어짐. 따라서 치료자와 내담자 간의 언어적인 상호작용을 통해서 치료자가 내담자로 하여금 어려움을 극복하도록 도와주는 것(Garfield, 1995, p.5)

2) 상담의 3요소

(1) 내담자

- 스스로 해결할 수 없는 심리적 문제나 장애를 지니고 전문적 도움을 요청하는 사람
- 임상 장면에서는 환자라고 지칭되기도 함
- 도움받기를 원하는 심리적 문제는 그 내용과 심각한 정도에 있어 매우 다양
 - 예) 인간관계 갈등, 열등감, 학업 부진, 직장 부적응, 우울증, 불안장애, 망상, 환각 등
 - 사례 1)

명문대학의 대학원생인 H양이 수면제 수습 알을 먹고 동네 뒷산에서 자살을 시도했다. 마침 새벽에 산을 오르던 등산객에게 발견되어 생명은 건지게 되었지만, H양은 자살할 생각을 버리지 않았다.

한 학기 전에 졸업논문을 준비하던 H양은 발표한 논문계획안이 부실하다는 이유로 기각되는 경험을 했다. 성장 과정에서 한 번도 학업의 실패를 경험하지 못했던 H양에게 이 사건은 커다란 충격이었다. 이후 자기 자신에 대한 회의와 더불어 비관적인 생각에 빠져들게 되었으며, 논문에 실패한 자신을 다른 사람들이 무시하는 것처럼 느껴졌다.

이처럼 복잡한 심경 속에서 다시 졸업논문을 준비하면서 많은 어려움을 겪게 된 H양은

자신감을 잃게 되었다. 자신은 결코 졸업하지 못할 것이라는 비관적인 생각과 그동안 자신이 우수한 사람이라는 커다란 착각 속에서 살아왔다는 자괴감에 빠져들게 되었다. 이렇게 무능한 자신이 졸업도 하지 못하고 취업도 하지 못한 채, '백수'가 되어 무기력한 삶을 살아가게 될 것이 두려웠다.

더구나 그동안 어려운 가정환경 속에서도 자신을 뒷바라지하며 고생해오신 부모님에게 실망과 부담만 안겨줄 것을 생각하니 견딜 수가 없었다. 이러한 비관적인 생각에 휩싸인 H양은 자살을 통해 모든 고통에서 벗어날 생각을 하고 있다(현대심리치료와 상담이론에서 발췌, 권석만 저).

- 사례 2)

초등학교 1학년 아동인 J군의 부모는 요즘 걱정이 많다. J군을 초등학교에 입학시키고 나서 J군의 문제로 자주 학교에 불러갔다. 평소 부산하고 장난이 심하긴 해도 총명하던 J군이 초등학교에 가고 나서 여러 가지 문제를 일으키고 있기 때문이다.

담임교사의 말에 따르면, 수업 시간에도 주의를 집중하지 못할 뿐만 아니라 자리에 가만히 앉아 있지 못하고 떠들며 옆에 앉은 아이를 건드리고 때리는 행동을 하여 수업을 진행할 수 없다는 것이다.

부모의 간곡한 부탁으로 담임교사가 J군에게 특별한 배려를 하며 수업을 진행해보았지만, 전혀 개선되는 조짐이 나타나지 않았다.

부모가 야단을 치기도 하고 달래보기도 했지만, J군의 행동은 변하지 않아 최근에는 특수학교로 전학을 고려하고 있다(현대심리치료와 상담이론에서 발췌, 권석만 저).

(2) 상담자

- 내담자에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 전문적인 지식과 능력을 갖춘 전문가
- 내담자의 심리적 문제를 깊이 있게 이해하고 치료할 수 있는 전문적 지식과 기술 지님
- 심리치료의 이론적 지식뿐만 아니라 전문적 기술에 대한 교육과 훈련 필요

① 상담자의 동기와 자질

- 타인을 돕고자 하는 이타적인 동기
- 상담자의 약 70%가 자신의 심리적 문제를 이해하고 스스로 치유하기 위해 이 분야 선택
- Korchin(1975) 인간에 대한 애정과 인간의 고통에 대한 깊은 관심, 자기통제 능력, 친밀하고 신뢰로운 인간관계 형성 능력, 언어적 표현능력, 대인관계 예민성, 보통 상 수준 이상의 지능, 다양한 문화적 배경과 지식, 도덕성과 윤리의식

② 심리치료자의 교육과 훈련

- 심리적 문제나 장애를 정확하고 체계적으로 이해할 수 있는 전문적 지식 필요
- 내담자가 호소하는 심리적 문제의 구체적 내용과 심각한 정도, 심리적 문제가 내담자의 삶에 미치는 영향, 나아가 심리적 문제의 원인 등을 체계적으로 파악할 수 있는 전문적 안목과 능력

- 내담자의 심리적 문제를 긍정적인 방향으로 변화시킬 수 있는 치료적 기술과 능력
- 이론적 교육과 실제적 훈련
- 국내 관련 자격증

발급기관	자격증
한국심리학회 산하 한국상담심리학회	상담심리사 1급, 2급
한국상담학회	전문상담사 1급, 2급
보건복지부	청소년상담사 1급, 2급, 3급
보건복지부	정신건강임상심리사 1급, 2급
한국심리학회 산하 한국임상심리학회	임상심리전문가
한국산업인력공단	임상심리사 1급, 2급

(3) 상호작용

- 심리치료는 상담자(치료자)와 내담자가 치료적 관계를 형성하고 치료 목표를 이루기 위해 주로 언어를 매개로 한 상호작용으로 진행
- 상담자는 내담자가 원하는 치료 목표를 이루기 위해 최선을 다할 것이라는 명시적 또는 암묵적 계약을 통해 치료관계 형성
- 심리치료가 이루어지는 기간과 만남의 횟수는 내담자가 호소하는 문제의 내용과 심각도 치료 목표, 치료자의 접근방법, 내담자의 현실적 여건 등에 따라 달라짐
- 일반적으로 단기 치료는 20회 이내 또는 6개월 이내의 면담, 중기 치료는 7~12개월, 장기치료는 1년 이상 수년간에 걸쳐 이루어짐
- 심리치료는 초기, 중기, 종결 기로 구분
 - 초기 : 치료자가 내담자를 처음 만나 면담하는 최초면접을 포함한 3~4회기 이내의 면접 회기
 - 중기 : 치료 목표의 달성을 위해 본격적인 치료적 활동이 이루어짐. 이 단계에서 치료자와 내담자 사이에 변화무쌍한 많은 일들이 발생. 치료자는 내담자에 대한 이해를 더욱 심화시키면서 내담자의 변화를 위해 다양한 기법을 적용하고 그 효과를 평가하며 자신의 치료계획을 실행하거나 수정하는 과정 거침
 - 종결 : 치료목표가 상당한 부분 달성되어 치료를 마무리하는 과정

2. 상담과 생활지도, 심리치료와의 비교

1) 상담과 생활지도, 심리치료와의 비교

- 심리치료와 심리상담의 구분 모호
- 이에 인간의 고통과 불행을 완화하고 나아가 심리적 성장을 촉진하는 전문적 활동은 모두

심리치료 또는 상담으로 지칭

종 류	내 용
생활지도	교육적, 사회적, 도덕적, 직업적 영역 등의 계획적 지도 활동
상담	교육적, 상황적 문제해결과 의식과정의 자각을 촉진
심리치료	재구성적, 심층 분석적 문제해결과 무의식적 동기의 통찰에 역점을 둠

2) 전문적 상담 VS. 일반적 상담

- 관련 이론적 지식 및 전문적 훈련 vs. 개인적 경험과 주관적 판단
- 호소 문제 기저 이해 vs. 증상만 이해
- 변화를 위한 구체적 절차와 방법 제시 가능 vs. 한정적 방법 제안
- 규칙성 여부
- 구체적 목표와 의도된 반응
- 자기 이익만을 추구

3. 상담에서 무엇이 이루어지는가?

1) 상담의 목표

(1) 내담자가 호소하는 심리적 문제의 해결이나 증상의 완화

- 상담의 내방 원인이었던 문제의 해소
- 문제를 다루는 방법 및 능력 향상

(2) 내담자의 심리·사회적 적응을 돕는 적응 능력 기술의 향상

- 내담자의 생각, 느낌, 행동의 변화를 통해 적응 능력 기술을 향상함
- 구체적인 대처방안, 문제해결 탐색 등을 통해 문제 상황에 효과적으로 대처하고 해결하는 방법을 학습
- 상담자의 공감과 지지를 통한 심리적 지원을 통해 스트레스 경감. 이러한 상태는 현재의 어려움과 문제에 대처할 수 있는 심리적 에너지를 향상함
- 관계 속에서 반복된 문제를 인식하고 다른 방식으로 반응하고 대처함으로써 새로운 관계 경험을 촉진

2) 상담을 통한 변화

(1) 긍정적 변화

- 내담자의 주 호소가 해소되고 해결됨으로써 적응적으로 변화
- 문제 해소에 의한 심리적 불편감 감소
- 성장 및 성숙

(2) 생각, 느낌, 행동 등에서 변화가 이루어짐

- 내담자의 어려움을 촉발, 유지, 심화시키는 심리적 요인과 과정을 인식
- 이러한 인식을 통해 생각, 느낌이 변화하고 이러한 변화는 행동의 변화로 이어짐. 행동의 변화는 생각과 느낌을 또다시 변화시킨다는 점에서 선순환 촉발
 - 예) '모든 사람은 나를 싫어해' => 나를 싫어하는 사람들도 있지만 나를 좋아하는 사람들도 있어 => 불안 감소 => 사람들에게 다가가는 행동 => 나를 좋아하는 사람들이 생겼어 => 나를 싫어하는 사람들도 있지만 나를 좋아하는 사람들도 있어. 확실해 => 불안 감소 => 사람들에게 다가가는 행동

(3) 변화는 상담이 종결된 후에도 지속

- 상담에서 발생한 변화는 상담이 종결된 후에도 지속되어 내담자의 성격과 삶을 변화시킴
- 상담에서 발생한 변화가 내담자에게 좋은 변화로 인식될 경우, 변화의 필요성이 증대되어 자발적인 노력이 가능하게 됨

(4) 새로운 뉴런 생성과 뉴런 간의 연결망 변화

- 뇌가 새로운 뉴런을 재생산할 수 있고, 평생 새로운 뉴런과 연결되면서 스스로 재조직화할 수 있다는 것을 '신경가소성'이라고 함
- 신경가소성은 사람들의 삶을 특징짓는 경험과 새로운 경험, 상황에 대한 반응으로 뉴런이 만들어내는 뉴런 내 화학적 적응의 결과로 발생. 최근 연구 결과에 따르면 신경가소성은 사람들이 일상적으로 악기 연습하는 것과 같은 반복적인 행동을 할 때, 풍부한 환경 자극에 노출될 때, 상담처럼 신선하고 지지적이며 도전적인 활동에 노출될 때 증가

(5) 내담자의 심리적 성장 및 성숙

- 자신에 대한 자각과 이해 수준을 높여 수동적이거나 충동적인 반응을 줄임
- 자신의 다양한 모습을 진솔하게 바라보고 받아들이므로써 과도한 자의식, 자기 비난을 줄이고 전인으로써 자신을 수용
- 자신의 욕구를 인식하고 조율하고 충족함으로써 책임감 있는 삶의 태도 증진
- 다른 사람에 대한 이해와 수용 수준 증진

3) 과정이 필요한 상담

- 상담 성과는 대개 여러 번의 만남을 포함하는 일련의 '과정'을 통해 이루어짐
- 단회상담도 있지만 문제해결 및 발전적인 변화가 있으려면 적어도 7, 8회 이상의 상담이 필요하다는 것이 여러 연구를 통해 입증
- 반복은 신경가소성에 매우 중요한 역할. 뇌에서 학습이나 기억을 형성하는 과정에서 반복적인 자극이 필요. 반복적인 자극은 뇌의 신경회로를 강화해주는데, 이는 뉴런 간의 시냅스를 강화. 따라서 반복적인 학습과 훈련을 통해 뇌 구조의 변화와 강화된 신경회로를 형성할 수 있음. 상담에서의 과정은 이러한 반복을 가능하게 함

4. 상담이론의 의미와 필요성, 평가기준

1) 심리치료 이론의 의미와 필요성

- 심리치료에 대한 지침서
 - 성격 발달에 대한 이해 : 인간의 심리발달과정을 이해하고 각 발달단계의 특징을 이해
 - 주 호소 문제에 대한 이해 : 현재의 심리적 어려움을 촉발, 유지, 심화시키는 심리 내적, 사회적, 대인 관계적 요인을 이해
 - 잠재력 이해 : 내담자의 회복 잠재력과 강점을 이해
 - 상담과 치료의 과정 이해 : 심리적 문제를 해소하고 완화하기 위한 효과적인 개입 방법, 과정에 대한 이해

2) 상담이론의 평가기준

- 내담자의 심리적 문제와 치료원리에 대한 체계적 설명 : 인간의 심리구조와 발달과정을 설명하는 성격 이론, 심리적 문제나 장애가 발생하는 원인과 유지되는 과정을 설명하는 정신병리 이론, 이러한 심리적 장애를 변화시킬 수 있는 치료원리에 대한 이론, 그리고 치료원리를 실제 사례에 적용하게 되는 치료기법을 구체적으로 제시
- 내담자의 문제와 치료원리를 명료하고 정교하게 설명 : 같은 현상을 설명하는 경우, 여러 가지 복잡하고 모호한 개념을 동원하기보다 소수의 명료한 개념으로 설명하는 이론이 우월
- 과학적인 연구 결과에 근거 : 실제적인 경험적 세계에서 확인할 수 있는 검증 가능성을 지니고 있을 필요. 이를 위해 경험적 확인이 가능하도록 개념이 명료해야 함
- 치료 효과 : 내담자의 문제해결과 증상 완화에 효과적이어야 함
- 최소한의 치료적 노력으로 최대한의 효과 : 시간, 비용을 고려해야 할 필요

1. 내담자가 느끼는 불안

1) 상담자가 나를 이해할(혹은 도울 수 있을까?)

(1) 관련한 내담자의 불안

- 내담자는 상담에 오기 전 스스로 문제를 해결하려고 노력하거나 가족이나 친구들에게 자신의 고민을 이미 이야기했을 가능성
- 아무에게도 고민을 털어놓지 못했을 가능성
- 내적 자원이 모두 고갈되었을 때 상담에 찾아오는 경우가 대다수

전에 저와 같은 문제를 다뤄 보신 적이 있나요?

혹시 실례지만 선생님 결혼하셨나요?

선생님은 성소수자에 대해 어떻게 생각하세요?

선생님은 종교가 있으신가요?

(2) 필요한 상담자의 반응

- 전문지식, 경력 등을 늘어놓지 않기
- 자신의 신상을 구구절절 말하지 않기
- 내담자의 마음을 헤아리기

2) 상담에서 얘기한 것이 밖으로 새어가지는 않을까?

- 상담에서 가장 중요한 기본 사항 중의 하나 '비밀보장'
- 하지만 비밀보장의 예외사항
 - 내담자가 자살/자해할 위험성이 충분할 때
 - 내담자가 다른 사람을 살해하거나 혹은 상해를 입힐 가능성이 있을 때
 - 내담자 주변에서 다양한 형태의 학대(아동학대, 노인학대 등)가 진행 중임을 알게 되었을 때

(1) 관련한 내담자의 불안

상담 선생님이 다른 사람에게 내 얘기를 하지는 않을까?

정말 비밀이 보장될까?

녹음한 것이 유출되지는 않을까?

다른 사람들이 내가 상담받는 것을 알면 어떡하지?

(2) 필요한 상담자의 반응

- 다른 내담자의 사례를 이야기하거나 이전 상담 경험에 관해 이야기하지 않기
- 사례지도감독자나 사례 회의의 경우를 제외하고 어떤 경우에도 내담자에 대해 얘기하지 않기
- 상담실 밖에서 내담자를 만날 때, 어떻게 하기를 원하는지 내담자에게 확인
- 집단상담의 경우 수시로, 그리고 종결하기 전에 비밀보장의 준수 의무에 대해 반복적으로 강조할 필요
- 각 학회의 윤리규정 준수하기
 - (사) 한국상담심리학회의 윤리규정

5. 정보의 보호 및 관리

가. 사생활과 비밀보호

1. 상담심리사는 상담과정에서 알게 된 내담자의 민감 정보를 다룰 때 특별히 주의해야하고, 상담과 관련된 모든 정보의 관리에 있어 개인정보 보호와 관련된 법을 준수해야 한다.
2. 상담심리사는 사생활과 비밀유지에 대한 내담자의 권리를 최대한 존중해야 할 의무가 있다.
3. 내담자의 사생활 보호에 대한 권리는 존중되어야 하나, 때로 내담자나 내담자가 위임한 법정 대리인의 요청에 의해 제한될 수 있다.
4. 내담자의 사생활 보호가 제한되는 경우라 하더라도, 상담심리사는 내담자의 사생활 침해를 최소화하기 위해 노력해야 하고, 문서 및 구두 보고 시 사생활에 관한 정보를 포 함시켜야 할 경우 그 목적과 밀접한 관련이 있는 정보만을 포함시킨다.
5. 상담심리사는 강의, 저술, 동료자문, 대중매체 인터뷰, 사적 대화 등의 상황에서 내담자의 신원확인이 가능한 정보나 비밀 정보를 공개하지 않는다.
6. 상담심리사는 상담 기관에 소속된 모든 구성원과 관계자들에게도 내담자의 사생활과 비밀이 보호되도록 주지시켜야 한다.

나. 기록

1. 상담기관이나 상담심리사는 상담의 기록 보관 및 폐기에 관한 규정을 마련하고 준수해야 한다.
2. 상담심리사는 법, 규정 혹은 제도적 절차에 따라, 상담기록을 일정기간 보관한다. 보관 기간이 경과된 기록은 파기해야 한다.
3. 공공기관이나 교육기관 등은 각 기관에서 정한 기록 보관 연한을 따르고, 이에 해당하지 않는 경우에는 3년 이내 보관을 원칙으로 한다.
4. 상담심리사는 상담의 녹음 및 기록에 관해 내담자의 동의를 구한다.
5. 상담심리사는 면접기록, 심리검사자료, 편지, 녹음 파일, 동영상, 기타 기록 등 상담과 관련된 기록들이 내담자를 위해 보존된다는 것을 인식하며, 상담기록의 안전과 비밀 보호에 책임을 진다.
6. 상담심리사는 내담자가 합당한 선에서 기록물에 대한 열람을 요청할 경우, 열람할

수 있도록 한다. 단, 상담심리사는 기록물에 대한 열람이 내담자에게 해악을 끼친다고 사료될 경우 내담자의 기록 열람을 제한한다.

7. 상담심리사는 내담자의 기록 열람에 대한 요청을 문서화하며, 기록의 열람을 제한할 경우 그 이유를 명기한다.
8. 복수의 내담자의 경우, 상담심리사는 각 개별 내담자에게 직접 해당되는 부분만을 공개하며, 다른 내담자의 정보에 관련된 부분은 노출되지 않도록 한다.
9. 상담심리사는 기록과 자료에 대한 비밀보호가 자신의 죽음, 능력상실, 자격박탈 등의 경우에도 보호될 수 있도록 미리 계획을 세운다.
10. 상담심리사는 상담과 관련된 기록을 보관하고 처리하는데 있어서 비밀을 보호해야 하며, 이를 타인에게 공개할 때에는 내담자의 직접적인 동의를 받아야 한다.

다. 비밀보호의 한계

1. 내담자의 생명이나 타인 및 사회의 안전을 위협하는 경우, 내담자의 동의 없이도 내담자에 대한 정보를 관련 전문인이나 사회에 알릴 수 있다.
2. 내담자가 감염성이 있는 치명적인 질병이 있다는 확실한 정보를 가졌을 때, 상담심리사는 그 질병에 위험한 수준으로 노출되어 있는 제 삼자(내담자와 관계 맺고 있는)에게 그러한 정보를 공개할 수 있다. 상담심리사는 제삼자에게 이러한 정보를 공개하기 전에, 내담자가 자신의 질병에 대해서 그 사람에게 알렸는지, 아니면 스스로 알릴 의도가 있는지를 확인한다.
3. 법원이 내담자의 동의 없이 상담심리사에게 상담관련 정보를 요구할 경우, 상담심리사는 내담자의 권익이 침해되지 않도록 법원과 조율하여야 한다.
4. 상담심리사는 내담자 정보를 공개할 경우, 정보 공개 사실을 내담자에게 알려야 한다. 정보공개가 불가피할 경우라도 최소한의 정보만을 공개한다.
5. 여러 전문가로 구성된 팀이 개입하는 상담의 경우, 상담심리사는 팀의 존재와 구성을 내담자에게 알린다.
6. 비밀보호의 예외 및 한계에 관한 타당성이 의심될 때에 상담심리사는 동료 전문가 및 학회의 자문을 구한다.

3) 상담자에게 너무 의존하게 되는 것은 아닐까?

- 상담에서 내담자가 상담자에게 정서적으로 의존하는 것 자연스러움
- 가까운 가족이나 친구도 자신을 잘 이해하지 못했는데 처음 만난 상담자가 자신의 고민과 아픔을 잘 이해한다는 믿음이 들면 상담자에게 의존하게 됨
- 상담이 진행됨에 따라 이러한 의존에서 벗어나 내담자는 자율성을 갖게 되고 상담을 종결할 무렵에는 자발적이고 적극적으로 자신의 문제를 해결할 수 있는 주체로 성장
- 대인관계에서 어려움을 경험한 내담자들의 경우, 누군가에게 의존하게 되는 것을 원하면서 동시에 이렇게 의존하게 되면 자신을 잃어버리고 결국엔 버림을 받을지 모른다는 두려움 가짐

(1) 관련한 내담자의 불안

이렇게 상담에 의존하게 되면, 난 스스로 내 문제를 해결할 수 없게 될 거야.

상담선생님한테 나아지는 모습을 보여야 할 텐데.

힘들 때마다 상담받을 수는 없잖아.

상담선생님이 나한테 실망하면 어떡하지

(2) 필요한 상담자의 반응

- 내담자의 불안을 수용하고, 상담자에게 의존하고 싶은 마음을 견지
- 무조건적 긍정적 존중
- 종결을 위해 종결 계획 시간을 두고 설립할 필요
- 의존 대 의존하지 않기가 아니라, 어떤 때는 의존하고 어떤 경우에는 의존하지 않는 것이 좋은지 분별하는 것의 중요성 전달

4) 상담에서 원하지 않는 상황이 발생하면 어떡하지?

- 자신이 타인에게 어떻게 보이는지 민감할 경우, 대인관계에서 수치심을 자주 느낄 경우 나타날 수 있는 불안
- 자기 행동에 대한 통제감을 중요하게 생각할 때에도 발생

(1) 관련한 내담자의 불안

상담자에게 창피한 모습을 보이면 어떻게 하지?

내가 말하고 싶지 않은 내용을 이야기하도록 강요받으면 어떡하지?

내가 들리고 싶지 않은 부분을 상담자가 알게 되면 어떡하지?

(2) 필요한 상담자의 반응

- 모든 것을 있는 그대로 다 이야기할 필요가 없다는 것을 전달
- 자신만의 속도와 자발성을 바탕으로 이야기하고 싶은 데까지 이야기하면 된다는 메시지 전달

2. 초보 상담자가 직면한 문제

1) 내담자가 다시 안 오면 어떻게 하지?

- 상담자가 상담 과정에서 자신의 수행에 지나치게 예민해지지 않기 위해서는 일정한 시간이 필요
- 과정을 받아들이기 필요
- 교과서에 제시된 상담 개입전략이 실제 상담 장면에서 그대로 적용될 수 있을 거라는 기대는 지우는 것이 필요. 현실적인 기대 필요
- 내담자가 상담자를 싫어할 수 있음을 수용. 때에 따라 상담자가 내담자의 핵심 문제를 다루려고 하면 내담자가 자동적으로 저항과 방어적인 태도를 보임. 이러한 부정적인 피드백을 상담자

자신의 능력 부족으로 여겨버리면 내담자의 문제를 객관적으로 그리고 더 심화해서 다룰 기회를 놓칠 수 있음

2) 슈퍼비전을 받을 때 잘못된 부분은 숨기고 싶다!

- 슈퍼비전은 상담수련생이 자신의 상담사례를 내담자의 동의를 얻은 후 녹음 혹은 녹화하고 녹취록(축어록) 혹은 비디오테이프를 사례지도감독자(수퍼바이저)와 함께 검토, 논의하는 방식으로 이루어짐
- 수퍼바이저의 부정적인 피드백에 대한 부담감으로 잘 못 한 부분은 제외하고 잘한 부분만 보고
- 슈퍼비전은 상담을 잘하고 못하고 평가하는 것이 주된 목적이 아님을 이해할 필요
- 내담자를 더 잘 이해하고 보다 효과적인 상담 개입을 위한 방안을 모색하는 것이 목적

3) 상담자의 과도한 자기 개방

- 많은 경우 초심상담자는 내담자에게 “나도 그런 경험이 있다. 따라서 내가 당신의 경험을 이해한다.”라는 말을 전달함으로써 친밀감이 형성된다고 생각하는 경향. 이런 접근은 내담자의 자기 내면세계를 탐색하는 시간을 뺏을 수 있음. 상담자의 개인 경험이 내담자의 경험과 일치할 수 있을까?
- 상담자의 자기 개방은 상담 과정을 통제하는 데 대해 자신이 없기 때문일 수 있음. 어떤 상담자는 자신이 불안할 때마다 자기 얘기를 하면서 이러한 불안을 은폐하는 경향
- 상담자가 자기 개방을 하면서 은연중에 내담자에게 자기 개방을 강요하는 경우가 있음. 이러면 내담자가 부담을 느끼게 되고 상담자의 바람과는 반대로 내담자가 대화를 자꾸 회피하는 부작용 발생. 솔직하게 얘기한다는 것의 의미가 모든 것을 다 얘기해야 한다는 것으로 변질하게 되면 내담자는 부담을 느낄 수 있음

4) 상담에 없는 제삼자의 얘기에 초점을 맞추는 문제

상 1 : 어떤 얘기를 하고 싶으세요?

내 1 : 제 애인은 늘 자기중심적이에요. 자기는 밥 한번 안 사면서 늘 제가 밥을 살 때까지 기다려요. 한 번 밥 사는 것을 못 봤어요. 제 지갑이 자기 지갑인 줄 안다고요.

상 2 : 너무하네요. 애인이 또 어떻게 이기적으로 행동했나요?

내 2 : 지난번에는 생일에 손편지를 안 써줬다고 신경질을 내더라고요. 나름 신경을 써서 평소에 가지고 싶다는 선물도 사주고 좋은 음식점도 데려간 건데.

상 3 : 흥미롭네요. 애인이 또 어떻게 했나요?

상 1 : 어떤 얘기를 하고 싶으세요?

내 1 : 제 애인은 늘 자기중심적이에요. 자기는 밥 한번 안 사면서 늘 제가 밥을 살 때까지 기다려요. 한 번 밥 사는 것을 못 봤어요. 제 지갑이 자기 지갑인 줄 안다고요.

상 2 : 애인이 데이트할 때 일방적으로 00 씨에게만 돈을 내게 해서 불공평하다고 느끼시는 거죠. 00씨가 이런 불편감이 있다는 걸 애인은 알고 계실까요?

내 2 : 잘 모를 거예요. 부모님이 주신 용돈이랑 알바해서 버는 돈으로 생활하는 거라 저도 넉넉하지는 않은데. 만날 때마다 저만 돈을 내니 부담스러워요.

상 3 : 그러시겠어요. 00씨도 학교 다니고 생활하며 드는 돈이 있을 텐데. 그런데 애인은 00씨가 불편한 걸 왜 모르시는 걸까요? 혹시 표현해보신 적 없으세요?

5) 질문을 남발하며 불안 감추기

- 초심상담자는 모든 정보를 정확히 알아야 내담자의 문제를 해결해 줄 수 있다는 전제
- 적절한 반응을 할 자신이 없으므로 계속 질문을 함으로써 내담자가 대답으로 상담 시간을 보내고 있는 경우

6) 침묵에 대한 두려움

- 초심상담자일수록 자기 능력이 부족해 상담 과정이 매끄럽지 않다는 생각에 위축
- 내담자가 말하고 싶어 하지 않는데 상담자가 강요하면 내담자에게 폐를 끼칠 수 있다는 생각에 침묵 후에 계속 이야기하도록 독려하는 것에 부담
- 침묵에 대해 화제 전환. 이러면 내담자의 내면적 경험이 심화하지 못하고 분절

7) 내담자와 사적인 관계에 빠진다면?

- 상담자는 내담자와 다중관계, 성적 관계를 맺지 말아야 함
- 내담자와 개인적인 관계에 빠지지 않기 위해, 내담자가 선물을 사서 왔을 때 가능하면 받지 않는 것이 바람직. 내담자와 신체적 접촉하는 것 지양할 필요
- (사)한국상담심리학회 윤리규정

8) 상담의 목표와 과제를 내담자와 논의하지 않는 문제

- 초심상담자들은 상담목표를 너무 애매하고 추상적으로 설정
- 상담자 혼자 상담목표 설정
- 상담료 지불 시기 및 방식, 상담 취소 기한, 당일 노쇼, 상담 시간에 대한 규정 등과 관련한 구조화의 어려움

4. 상담관계

가. 다중 관계

1. 상담심리사는 객관성과 전문적인 판단에 영향을 미칠 수 있는 다중 관계는 피해야

한다. 가까운 친구나 친인척, 지인 등 사적인 관계가 있는 사람을 내담자로 받아들이면 다중관계가 되므로, 다른 전문가에게 의뢰하여 도움을 준다. 의도하지 않게 다중 관계가 시작된 경우에도 적절한 조치를 취해야 한다.

2. 상담심리사는 상담할 때에 내담자와 상담 이외의 다른 관계가 있다면, 특히 자신이 내담자의 상사이거나 지도교수 혹은 평가를 해야 하는 입장에 놓인 경우라면 그 내담 자를 다른 전문가에게 의뢰한다.
3. 상담심리사는 내담자와 상담실 밖에서 연애관계나 기타 사적인 관계(소셜미디어나 다른 매체를 통한 관계 포함)를 맺거나 유지하지 않는다.
4. 상담심리사는 내담자와의 관계에서 상담료 이외의 어떠한 금전적, 물질적 거래를 해서는 안 된다.
5. 상담심리사는 내담자의 선물로 인해 발생할 수 있는 문제를 숙고해야 한다. 선물의 수령 여부를 결정함에 있어서 상담 관계에 미치는 영향, 선물의 의미, 내담자와 상담자의 동기, 현행법 위반 여부 등을 신중하게 고려해야 한다.

나. 성적 관계

1. 상담심리사는 내담자 및 내담자의 보호자, 친척 또는 중요한 타인에게 자신의 지위를 이용하여 성희롱 또는 성추행을 포함한 성적 접촉을 해서는 안 된다.
2. 상담심리사는 내담자 및 내담자의 보호자, 친척, 또는 중요한 타인과 성적 관계를 가져서는 안 된다.
3. 상담심리사는 이전에 연애 관계 또는 성적인 관계를 가졌던 사람을 내담자로 받아들이지 않는다.
4. 상담심리사는 상담관계가 종결된 이후 적어도 3년 동안은 내담자와 성적 관계를 맺지 않아야 한다. 그 후에라도 가능하면 내담자와 성적인 관계는 갖지 않는다.

9) 문제를 이해하기 전에 해결해 주려는 요구

- 내담자의 마음을 이해하기에 앞서 문제를 빨리 해결하려는 시도
- 선택은 내담자의 몫으로 내담자가 자신의 욕구와 두려움을 충분히 탐색할 기회를 얻는 것이 중요

정신분석적 치료 I / 2주차 1차시

1. 정신분석에서의 인간관

1) 심리적 결정론

- 인간의 모든 행동은 원인 없이 일어나지 않는다는 가정
- 아무리 사소하고 이해하기 어려운 행동이라 하더라도 우연히 일어나지 않으며 심리적 원인에 의해 결정
- 모든 심리적 현상은 그에 선행하는 어떤 것에 의해 결정

2) 무의식

- 인간의 심리적 세계에는 개인에게 자각되지 않는 무의식적 정신현상이 존재
- 인간의 행동은 의식적 요인보다 무의식적 요인에 의해 더 많은 영향
- 행동의 원인을 밝히기 어려운 이유는 무의식적 요인에 의해 결정되기 때문
- 정신분석은 인간 행동에 영향을 미치는 무의식적 과정을 탐구하는 것

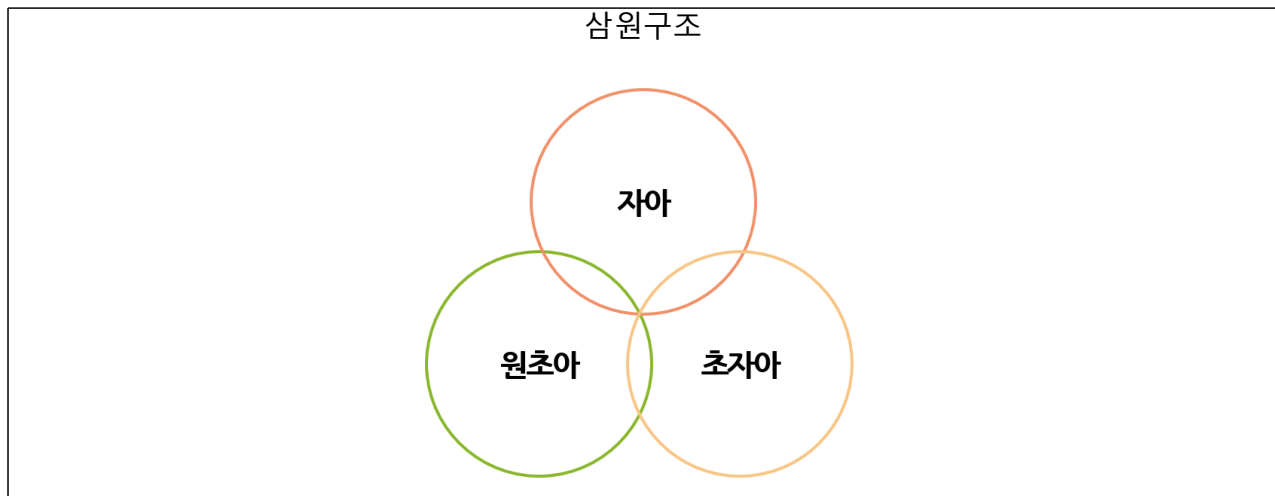
3) 성적 추동

- 인간의 가장 기본적인 욕구이며 무의식의 주된 내용을 구성한다는 가정
- 성적 욕구는 사회의 도덕적 기준에 어긋나기 때문에 억압되어 무의식 속에 자리 잡게 되지만 인간의 행동에 지대한 영향을 미침
- 프로이트는 성적 욕구와 더불어 공격적 욕구를 인간의 기본적인 욕구로 여김

4) 어린 시절의 중요성

- 어린 시절의 경험, 특히 부모와의 상호작용 경험이 성격 형성의 기초
- 성인의 행동은 어린 시절의 경험을 통해 형성된 무의식적인 성격 구조가 발현된 것
- 개인의 행동을 이해하기 위해서는 어린 시절의 경험과 기억을 잘 탐색해야 할 필요

2. 정신분석에서의 성격구조



1) 원초아(id)

- 충동적 행동을 유발하는 원초적 욕구와 이를 충족시키려는 심리적 과정
- 현실적 요건을 고려하지 않고 즉각적으로 욕구를 충족시키려는 쾌락 원리에 따라 작동
- 자기중심적이고 비현실적이며 비논리적인 원시적 사고 과정을 나타냄
- 초기의 기초적인 심리적 과정이라는 의미에서 일차 과정이라고 부름
- 어린 유아는 이러한 원초아의 상태에서 삶이 시작. 성적 에너지인 리비도는 욕구를 충족시켜 줄 대상에게 지향되어 투여되는데 이러한 과정을 부착이라고 함
- 어린 유아는 엄마와의 상호작용 속에서 욕구의 충족이 지연되거나 좌절되는 경험. 이러한 과정에서 유아는 환경의 현실에 적응하는 심리적 기능 발달. 욕구 충족을 지연하며 현실을 고려하고 미래를 예상하여 행동을 선택하는 심리적 기능 발달. 이것이 자아

2) 자아(ego)

- 생후 6~8개월부터 발달하기 시작하여 2~3세가 되어야 자아의 기능 수행
- 자아는 현실 여건을 고려하여 판단하고 욕구 충족을 지연하며 행동 통제
- 현실원리에 따라 작동
- 감각과 운동, 지각, 추론 판단, 기억, 언어 등의 인지적 기능을 비롯하여 감정조절, 만족지연, 좌절인내와 같은 다양한 적응적 기능 담당
- 현실적이고 합리적이며 이성적인 사고 과정을 나타내는데, 이를 이차과정이라고 명명

3) 초자아(superego)

- 5~6세에 형성되어 10~12세에 제대로 기능
- 부모는 자녀를 양육하며 사회의 도덕과 윤리 규범에 따라 아이의 행동에 대해 칭찬 또는 처벌. 이런 경험을 반복하며 아이는 부모의 칭찬과 처벌에 일정한 규칙이 있음을 알게 되고 이를 자신의 심리적 세계 속에 내재화

- 아동은 초자아를 통해 자기 행동을 스스로 통제함으로써 부모의 처벌과 그에 대한 불안을 회피
- 도덕원리에 따라 기능

3. 정신분석에서의 의식과 무의식



1) 의식 수준

- 항상 자각하고 있는 지각, 사고, 정서 경험을 포함
- 이러한 의식적 경험은 인간의 정신세계에 있어 극히 일부분에 해당

2) 전의식 수준

- 평소에는 의식하지 못하지만 약간의 노력을 기울이면 쉽게 의식으로 떠올릴 수 있는 기억과 경험을 의미
- 전의식은 무의식의 내용을 의식으로 연결하는 교량 역할

3) 무의식 수준

- 자각하려는 노력에도 불구하고 쉽게 의식되지 않는 다양한 심리적 경험을 포함
- 수용되기 어려운 성적 욕구, 폭력적 동기, 부도덕한 충동, 비합리적 소망, 수치스러운 경험과 같이 의식에 떠오르면 위협적인 것으로 느껴지기 때문에 억압된 욕구, 감정, 기억의 보관소
- 마음의 지형학적 모델은 무의식의 중요성 강조
- 정신장애, 인간 행동 대부분이 무의식 속에 존재하는 심리적 요인에 의해 결정된다고 봄
- 정신분석 치료의 핵심은 무의식 속에 억압된 심리적 내용을 찾아 의식화하는 것

4. 자아방어기제

- 자아는 환경의 요구와 더불어 원초아와 초자아를 중재하는 성격의 중심 구조로서 이들을 잘 조절해야 하는 부담
- 자아의 기능이 약해지거나 다른 세력의 힘이 강해지면, 자아는 불안을 느끼게 됨
- 자아는 불안을 감소시키기 위해 방어기제 사용
 - 신경증적 불안 : 자아가 원초아의 세력을 조절하지 못함으로써 강렬한 욕망과 감정을 통제할 수 없을 것 같은 두려움
 - 도덕적 불안 : 초자아와의 갈등으로 인해 도덕적 규범이나 부모가 중요하게 여기는 가치를 위배하는 것에 대한 두려움

5. 성격 발달

1) 성적 추동 : 마음을 움직이는 원동력

- 추동은 정신분석 이론의 가장 핵심적인 개념으로 인간이 출생 초기부터 지닌 생물학적 욕구
 - 자기 보존적 추동 : 먹기, 숨쉬기, 마시기, 배설하기와 같은 행동을 유발
 - 종 보존적 추동 : 성적인 쾌락과 행동을 추구 => 일상에서 쉽게 충족되지 않을 뿐만 아니라 사회적으로 억압되는 성적인 추동을 무의식 세계의 주된 동력으로 간주. 이를 리비도라고 지칭
- 프로이트에 따르면, 인간이 나타내는 대부분의 행동은 근원적으로 성적인 추동에 의한 것 => 원초아 심리학, 리비도 심리학, 추동 심리학
- 프로이트는 성적인 욕구(리비도)와 함께 공격적인 욕구(타나토스)를 근원적 추동으로 제안
- 프로이트는 가장 근원적인 성적 추동이 유아의 성장 과정에서 어떻게 나타나는지를 밝히고자 함
- 프로이트가 말하는 성욕은 넓은 의미를 지니는 것으로서 타인과의 접촉을 통해 쾌락과 애정을 얻고자 하는 욕구를 의미
- 성욕의 궁극적인 목표는 성교행위를 통한 종의 보전이지만, 프로이트는 이와 관련하여 신체적 쾌락과 만족을 추구하려는 충동을 성욕이라고 넓게 정의

2) 심리성적발달 단계

(1) 구강기

- 출생~1년 반
- 엄마의 젖을 빨거나 먹는 것에 관심을 집중하며 입술과 혀, 목구멍을 통해 쾌감
- 유아는 입을 통해 엄마의 젖을 빨면서 외부 대상과 처음으로 관계 경험
- 입을 통해 엄마와 상호작용하며 만족감과 좌절감을 경험하며 외부 존재에 대한 기초적 인식 형성

- 이러한 경험들이 성격 형성에 영향
- 과도한 충족 : 의존적 자기중심적, 요구적
- 과도한 좌절 : 공격적 성격 형성, 빈정거림, 냉소, 논쟁적인 행동
- 적절한 충족 : 자신감, 관대, 외부 세계에 대한 신뢰감 형성

(2) 항문기

- 생후 1년 반~3년
- 쾌락을 추구하는 신체 부위가 항문으로 옮겨짐
- 배변을 참거나 배설하면서 긴장감과 배설의 쾌감을 경험
- 배변 훈련 시기 : 수치심과 불안 경험, 자율성과 자기 통제력 발달
- 과도한 충족 또는 좌절 : 완벽주의적, 청결과 질서에 집착하며 인색한 성격이 형성되거나 불결하고 분노를 잘 느낌
- 적절한 충족 : 독립적이고 자기주장적이며 협동적인 성격

(3) 남근기

- 만 3세~6세
- 쾌락 추구하는 부위가 성기로 바뀜
- 프로이트는 남근기가 성격 발달에 있어 매우 중요한 의미를 지닌다고 보았음
- 성기에 대한 아동의 관심이 이성 부모에게로 확산하면서, 아동은 이성 부모에게 유혹적인 행동을 보이며 애정을 독점하려고 노력하는 동시에 동성 부모를 경쟁자로 인식 => 오이디푸스 콤플렉스
- 부모와의 삼각관계 속에서 남자 아동은 거세불안 경험. 이러한 불안을 해소하기 위해 아버지와 동일시하며 남자의 성역할 학습
- 오이디푸스 콤플렉스의 원만한 해결 : 건강한 성정체감의 형성, 초자아와 자아의 발달, 삼각관계의 수용, 건강한 이성 관계를 맺을 수 있는 능력 발달
- 오이디푸스 콤플렉스 해결 실패 : 적응과 성격 형성의 문제 초래
 - 예: 권위적 인물에 과도한 두려움과 복종적 태도, 지나치게 경쟁적인 성격
- 엘렉트라 콤플렉스 : 여자아이

(4) 잠복기

- 만 6세~사춘기
- 학업과 친구에 관한 관심 증가
- 성적인 욕망의 표출이 뚜렷하게 나타나지 않음
- 학교생활, 친구 교제, 운동, 취미활동에 관심을 쏟음
- 자아가 성숙하고 초자아가 확립되는 시기, 현실적 성취와 원만한 대인관계를 위한 적응 능력 발달
- 과도한 좌절 : 열등감, 소극적, 회피적 성격특성

(5) 성기기

- 사춘기 또는 청소년기 이후의 시기

- 육체적 성숙, 성적인 측면에서 성인으로 발달
- 성 에너지가 이성에게 집중
- 연인관계를 통해 성 욕구를 충족시키고자 함
- 급격한 신체적 변화와 더불어 부모로부터의 심리적 독립과 자기 정체성의 확립이라는 과중한 발달과제
- 프로이트는 성기기를 통해 성격 형성이 완결된다고 보았음

3) 방어기제

방어기제	내용
억압	무조건 눌러 놓고 없는 척 의식에서 받아들이기 거북한 욕망, 충동, 생각을 무의식에 파묻어 버리는 것 가장 일반적인 방어기제이며 불안의 원천
부인	자기 감각이나 사고 또는 감정을 심하게 왜곡하거나 인식하지 못함으로써 고통스러운 현실을 부정
반동형성	받아들이기 어려운 심리상태와 반대되는 행동을 함으로써 불안을 회피
투사	용납할 수 없는 자신의 감정이나 욕구를 다른 사람의 것으로 돌리는 것
합리화	빈약한 성과나 실패와 같이 불쾌한 상황을 그럴듯한 이유로 정당화함으로써 불안을 회피
퇴행	이전의 발달단계로 되돌아감으로써 현재의 불안이나 책임감을 회피
동일시	다른 사람의 특징을 자기 것으로 여기며 불안과 같은 부정적 감정을 감소시킴
지성화	정서적인 주제를 이성적인 주제로 전환하여 추상적으로 다룸으로써 불안을 회피하는 것
승화	성적이거나 공격적인 욕구를 사회적으로 수용될 수 있는 건설적인 행동으로 변환
이타주의	남들이 본능적 욕구를 충족시킬 수 있도록 내가 나서서 건설적인 방법으로 꾸준히 도와주는 것

- 마음의 진실을 알려면 내가 무엇을 방어하고 있는지 알아야 함
- 방어기제 분석이 중요
- 프로이트 사후에 자아의 중요성을 강조하면서 자아의 기능을 정교하게 체계화하는 이론이 발전 => 자아 심리학

정신분석적 치료Ⅱ / 2주차 2차시

1. 정신분석의 치료기법과 절차

1) 정신병리의 일반적 원인

- 인간의 내면세계는 원초아, 자아, 초자아가 무의식 속에서 경험하는 역동적인 세계
- 심리적으로 건강한 사람은 자아가 잘 발달하여 주도권을 쥐고 원초아와 초자아의 요구를 적절하게 해소하면서 현실에 잘 적응
- 자아가 조정자의 기능을 잘하지 못하게 되면 무의식적인 갈등이 심화하고 심리적 증상이 초래
- 무의식적 갈등이 심화되는 이유
 - 성적이거나 공격적인 욕구의 과도한 억압으로 인해 원초아의 요구가 강력해지는 것
 - 초자아가 과도하게 경직된 윤리의식이나 완벽주의적인 가치를 요구하는 경우
 - 현실적인 문제의 해결을 위한 심리적 부담이나 스트레스로 인해 자아의 기능이 약해진 경우
- 불안을 느끼게 되면, 자아는 방어기제를 동원. 특정한 방어기제를 너무 자주 그리고 융통성 없이 부적절하게 사용하면 현실적응 저하. 나아가 정신장애 유발
- 특히 미숙한 방어기제에 과도하게 의존하게 되면 부적응이 심화하여 정신장애 유발
- 성숙도에 따른 분리

성숙도	방어기제
성숙한 방어	승화, 이타주의, 유머
신경증적 방어	억압, 반동형성, 대치, 합리화
미성숙한 방어	퇴행, 신체화, 동일시, 행동화
자기애적 방어	부정, 분리, 투사

- 프로이트는 인간은 과거에 경험하는 것을 반복하려는 집요한 경향이 있다고 보았으며, 이를 반복 강박이라고 명명

2) 특정한 정신장애의 원인

정신장애	원인
전환장애	- 운동기능의 마비나 감각기능의 상실과 같은 신경과적 증상과 유사한 신체적 문제 - 억압된 성적 욕구와 관련된 무의식적 갈등이 신체 증상으로 전환되어 나타나는 것 - 전환증상의 부위와 특성은 환자의 무의식적 갈등 내용과 상징적인 연관성 가짐
범불안장애	- 이유를 알 수 없는 걱정과 불안이 항상 지속되는 장애 - 억압된 원초아의 충동이 강해져 통제 곤란의 위협을 경험하는 자아가 느끼는 신경증적 불안
강박장애	- 지성화, 고립, 반동형성, 대치와 같은 방어기제가 작동한 것 - 수용하기 힘든 성적 욕구나 공격적 충동을 지적인 사고의 형태로 지성화하며 집착하는 동시에 관련된 감정들을 분리하여 고립(예: 청결에 대한 강박은 더러운 것으로 느끼는 성적 욕망에 대한 반동형성과 대치에 의한 것)
공포증	- 특정한 대상과 상황을 두려워하며 회피하는 증상으로서 무의식적인 공포가 외부의 대상으로 전이되거나 대치된 것
우울증	- 상실로 인한 분노를 자신에게 내향화 한 것

3) 치료의 목표와 원리

- 내담자의 성격 구조를 건강하게 변화시키는 것
- 내담자의 무의식적 갈등을 해결하고 건강한 성격을 함양함으로써 증상은 자연스럽게 해소
- 무의식을 의식화 : 정신분석 치료의 핵심 원리
- 자아의 기능을 강화함으로써 충동적이고 비합리적인 원초아를 효과적으로 제어
- 정신분석 치료를 성공적으로 마친 내담자는 자신의 증상에 대한 무의식적 의미를 이해하고 다른 사람과의 관계 패턴에 대한 통찰을 얻게 되며 부적절한 방어기제의 사용을 자제하게 됨

4) 치료기법

- 치료자는 내담자가 자신의 무의식적 갈등과 관련된 정보를 많이 내어놓을 수 있도록 유도
- 치료자는 중립적인 태도를 보이는 것이 중요
- 내담자의 반응에 대해 '고르게 주의를 기울이는 것'이 중요

(1) 자유연상

- 내담자가 편안하게 누운 상태에서 아무런 억제나 논리적 판단 없이 마음에 떠오르는 생각을 그대로 솔직하게 이야기하는 방법
- 치료자는 내담자의 이야기를 경청하며 내용뿐만 아니라 감정, 목소리, 침묵 등과 같은 다양한 반응을 유심히 관찰
- 때로는 특정 주제에 대해 자유연상을 하도록 권하기도 함
- 내담자는 자유연상 과정에서 자신의 무의식에 대한 자각이 증진
- 치료자는 자유연상 내용을 다른 자료들과 통합하여 내담자의 무의식적 갈등을 이해하고 해석하는 데 활용

(2) 꿈 분석

- 꿈에 나타난 주제나 내용들을 자세히 분석함으로써 무의식의 갈등을 발견하는 방법
- 프로이트는 "꿈은 무의식에 이르는 왕도"라고 말함

- 수면 상태에서는 의식적 억제가 약화되기 때문에 억압되었던 무의식 내용들이 의식에 떠오름

(3) 전이 분석

- 전이 : 내담자가 과거에 중요한 타인에게 느꼈던 감정이나 환상을 무의식적으로 치료자에게 나타내는 것
- 전이 분석은 내담자가 치료과정에서 치료자에게 나타내는 전이 현상을 분석하는 것으로 정신분석의 핵심적 요소 중 하나
- 치료자가 중립적인 태도를 취하는 이유는 내담자의 전이를 유도하기 위한 것
- 전이 분석을 통해 내담자의 무의식적 갈등과 방어기제가 자각
- 역전이 : 치료자가 내담자에게 보이는 전이 현상. 치료자의 역전이는 내담자의 반응을 왜곡하여 받아들이게 해서 최소화할 필요. 하지만 현대 정신분석에서는 역전이를 치료에 활용하는 것이 더 중요하다는 주장

(4) 저항 분석

- 내담자가 치료과정에서 나타내는 비협조적이고 저항적인 행동의 의미 분석
- 내담자의 저항은 치료를 방해할 뿐만 아니라 내담자의 무의식적 갈등을 반영하는 것
- 저항 분석을 통해 내담자의 무의식적 의도와 갈등을 살펴볼 수 있으며 내담자에게 저항의 무의식적 의미를 깨닫게 할 수 있음

(5) 해석

- 내담자는 치료과정에서 스스로 자신의 무의식적 갈등에 대한 통찰을 얻음
- 그러나 모든 내담자가 스스로 통찰에 이르는 것이 아니며 통찰의 내용과 수준에 한계
- 치료자는 내담자가 스스로 이해하기 어려운 무의식적 갈등에 대해 해석
- 내담자에 의해 수용되지 않는 해석은 무의미하여서 저항과 방어를 잘 다루며 신중할 필요
- 일반적으로, 해석할 내용에 대해 내담자가 어렵פות한 인식을 하고 있을 때 해석을 해주는 것이 바람직
- 해석의 효과는 치료자가 제시하는 해석의 정확성보다 내담자가 받아들일 수 있는 수용상태에 따라 더 커짐

(6) 훈습

- 훈습 : 무의식적 갈등이 어떻게 현실 생활에서 나타나고 있으며 그에 대한 깨달음을 어떻게 적응적 행동으로 실천할 수 있는지를 검토하며 변화하는 점진적 과정
- 내담자가 자신의 무의식적 갈등을 깨닫게 되면 그러한 갈등에 휘둘리지 않으면서 행동에 변화가 나타남
- 오랜 훈습의 과정에서 내담자는 점차 미숙한 방어와 증상들을 포기하게 되고 충동을 새로운 적응적 방식으로 충족시킴

5) 절차에 따른 치료의 실제

(1) 치료의 초기

- 내담자가 정신분석적 치료에 적합한 사람인지 평가 : 시간, 노력, 치료비, 자아의 기능 수준

- 치료에 필요한 계약 수립 : 치료 목표 설정, 치료 시간, 치료비, 불참 시 지불 문제, 결석 처리, 비밀보장 등

(2) 치료의 중기

- 저항과 전이 발생
- 치료자는 내담자의 저항을 인식하고 저항의 이면에 억압된 무의식적 동기를 파악하는 것이 중요
- 내담자는 치료자의 의도를 자주 오해하며 부적절한 감정을 표출하거나 지나치게 접근하거나 회피적인 태도를 취함. 어린 시절에 중요한 역할을 했던 사람에게 느꼈던 감정과 갈등이 치료자에게 반복되어 나타남
- 저항과 전이와 관련된 무의식적 의미를 이해하면서 내담자는 자신의 무의식적 갈등에 대한 통찰을 얻게 됨
- 통찰만으로는 내담자의 생활방식이 적응적으로 변화되지 않는 경우가 많음. 치료자는 내담자와 함께 무의식적 갈등이 현실 생활에 미치는 영향을 검토하고 통찰에 근거하여 새로운 적응행동을 실천하도록 격려
- 이러한 훈습 과정을 통해 내담자는 서서히 증상을 해소하고 건강한 생활방식 습득

(3) 치료의 종결기

- 다음의 기준에 따라 종결 결정
 - > 심각한 갈등의 해결과 자아 기능의 향상
 - > 병리적 방어기제 사용의 감소
 - > 성격 구조의 중요한 긍정적 변화
 - > 증상의 상당한 호전 또는 증상을 스스로 극복할 수 있는 능력이 생겼다는 증거의 존재
- 갈등이 완전히 사라졌을 때가 치료의 종결 시점이 아님
- 내담자가 자신의 무의식적 갈등을 이해하고 그것에 휘둘리지 않으면서 적응적인 생활을 해나가는 방법과 능력을 향상하는 것이 중요
- 치료자 종결된 후에도 치료자는 간헐적인 면담을 통해 내담자의 현실 적응과 자기분석을 도울 수 있음

2. 자아 심리학

- 프로이트가 말년에 중시했던 자아의 기능을 정교하게 설명하고 자아의 자율적 기능을 강조
- 자아 심리학은 자아를 원초아의 파생물로 보기보다 독립적으로 발달한 것으로 보며 자아의 자율적 기능을 강조
- 고전적 정신분석은 자아가 원초아로부터 파생된 것으로 가정하지만, 자아 심리학은 기억, 지각, 운동 협응과 같은 독립적인 자아 기능이 수행한다고 주장
- 고전적 정신분석은 자아의 주된 기능이 원초적 본능과 사회적 규범 간의 갈등을 중재하는 것이라고 여기지만, 자아 심리학에서는 자아가 이러한 갈등과 무관한 다양한 기능을 한다고 주장
- 자아의 병리적 발달과정뿐만 아니라 정상적인 발달과정에도 깊은 관심을 지니며 개인이 현실에 적응해가는 과정을 중시
- 자아분석과 방어분석을 통해 치료

3. 대상관계 이론

- 초기 아동기에 성격 구조가 발달하는 과정을 중시
- 남근기 이전의 어린 유아가 어머니와의 관계에서 겪게 되는 내면적 경험과 갈등에 초점
- 어린 시절의 갈등 경험은 자기 표상과 대상 표상 형성에 영향을 줄 뿐만 아니라 성인기의 대인관계에 강력한 영향
- 대상은 어머니를 비롯하여 개인이 관계를 맺게 되는 타자를 총칭
- 개인과 중요한 타인 또는 중요한 애정 대상과의 관계를 대상관계

4. 자기심리학

- 자기를 가장 중요한 심리적 구조
- 자기애는 인간이 발달하는 과정에서 정상적으로 나타나는 것으로서 타인에 대한 애정에 우선
- 유아는 부모와 상호작용하면서 자기감을 발달시키는데, 아이의 욕구나 감정에 대한 부모의 공감 반응은 통합된 자기를 발달시키는 데 매우 중요
- 대부분의 심리적 장애는 자기 구조의 결함에 기인하며 이러한 결함은 유아기에 엄마로부터 충분한 공감과 보살핌을 받지 못한 것과 관련
- 유아는 부모의 애정과 보살핌을 받는 정상적인 발달과정에서 웅대한 자기상을 형성
- 통합적이고 건강한 자기감의 발달을 위해 자기대상이 필요함
- 자기대상은 자기의 일부로 여기는 타인을 의미하는데, 아이에게는 부모가 중요한 자기대상
- 부모는 아이의 욕구와 표현을 수용하고 공감해주는 거울의 역할을 통해 아이가 건강한 자기감을 발달시키도록 도움

- 아이에 대한 부모의 공감 부족은 모든 정신병리의 뿌리

5. 정신분석의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 체계적 이론과 구체적인 치료 방법을 겸비한 인류사 최초의 심리치료
- 심리치료의 모태

2) 한계 및 비판

- 비과학적 이론
- 보편성에 대한 의문
- 개인 내부에 존재하는 성격 구조 간의 역동적 갈등에 초점
- 장기간의 치료 기간, 치료 효과 검증의 어려움

아들러 학파의 심리치료 / 3주차 1차시

1. 아들러 학파 치료의 이해

1) 인간관

- 인간은 사회적 맥락 속에서 나름대로 인생 목표를 추구하는 창조적인 존재
- 프로이트는 인간을 결정론적이고 생물학적 관점에서 바라보지만, 아들러는 목적론적이고 사회심리학적인 관점에서 인간을 이해하고자 함
- 인간은 사회적 관계 속에서 자신이 선택한 목표와 가치를 추구하는 존재
- 인간은 유전과 환경에 영향을 받지만, 자신의 모든 경험은 개인적이고 주관적인 방식으로 해석하는 힘을 가진 존재
- 인간의 모든 행동은 목적성을 지님

(1) 인간 행동의 가장 기본적인 목적은 열등감 극복

- 열등감을 극복하고 완전성을 추구하는 동기는 선천적
- 열등감은 모든 사람이 경험하는 보편적인 것으로서 창조적인 삶을 이끌어나가는 원동력
- 인간은 열등감을 보상하기 위해 우월성, 완전성, 그리고 숙련을 통한 유능감을 추구하며 더욱 발전된 자기 모습을 지향
- 어린 시절에 경험한 자신만의 열등감을 보상하기 위해 미래의 가상적 목표, 즉 가상의 자기상을 만듦. 이러한 목표는 개인의 인생을 이끄는 마음속의 중심 목표

(2) 현실에 대한 주관적 인식을 강조하며 무의식보다 의식을 중시

- 인간은 유전과 환경에 의해 영향을 받는 모든 경험을 개인적이고 주관적인 방식으로 해석하는 창조적인 힘을 지님
- 그러한 해석을 통해 개인은 자기, 타인, 세상에 대한 신념을 구성하고 삶에 대한 태도와 생활양식을 발달시킴. 개인을 이해하기 위해서 그가 지닌 주관적인 인식의 틀과 세상을 지각하는 개별적인 방식을 이해하는 것이 중요

(3) 인간은 사회적 존재

- 개인은 사회와 동떨어진 존재로 살아갈 수 없음. 인간은 다른 사람들과 유대감을 맺으려는 소속의 욕구를 지닐 뿐만 아니라 자신이 중요하게 여기는 가치를 사회 속에서 실현하려는 욕구를 지님
- 인간은 기본적으로 공동체 의식, 즉 사회적 관심을 지닌 존재
- 아들러는 타인 또는 사회와의 연결감 속에서 타인의 행복을 위해 이바지하려는 사회적 관심을 정신건강의 핵심적 요인으로 여김

(4) 통합적으로 움직이는 존재

- 프로이트처럼 원초아, 자아, 초자아라는 내적 요인의 갈등으로 이해하기보다 자신의 목표를 향해 통일성 있게 나아가는 통합적인 존재로 이해

- 아德勒는 개인의 분리불가능성(indivisible)을 중시한다는 점에서 자신의 이론을 '개인(individual)'심리학이라고 명명. 영어단어인 'individual'은 더 이상 분리할 수 없다는 의미의 'indivisible'에서 기원

2) 주요개념

(1) 가상적인 최종목표

- 아德勒는 인간의 삶을 목적론적인 관점에서 이해하고자 함
- 결정론을 전적으로 부인하거나 무시하지는 않았지만, 목적론을 더욱 중요시
- 인간은 누구나 자신의 인생에서 실현하고자 하는 궁극적인 목표를 지니는데, 아德勒는 이를 가상적인 최종목표라고 지칭
- 허구적인 이상은 인생에 의욕과 생동감을 불어넣을 뿐만 아니라 행동을 유발하는 기반으로 작용
- 가상적인 최종목표는 아동기에 형성. 이 시기에 그러한 목표가 구체적으로 인식되는 것은 아니지만 아동의 행동 방향성을 결정
- 이러한 목표는 개인 자신이 자각하지 못하는 무의식 수준에서 작용할 수 있음
- 인간은 누구나 나름대로 최종목표를 지니고 있지만, 대부분은 그것을 명료하게 자각하지 못함
- 최종목표는 개인의 열등감을 보상하는 기능

(2) 열등감 극복과 우월감 추구

- 아德勒는 열등감이 성격 형성에 중요하다고 믿음
- 열등감은 모든 정신병리의 일차적 원인
- 그러나 열등감을 부정적인 것으로만 여기지 않았으며 긍정적인 측면을 강조
- 열등감은 매우 보편적이고 정상적인 현상으로서 그것을 극복하고 보상하려는 노력을 통해 자기 성장과 발전의 원동력이 됨
- 개인이 자신을 지나치게 열등하다고 평가할 뿐만 아니라 그러한 열등감을 다른 사람이 인식하지 못하도록 숨기며 삶의 도전을 회피한다면, 열등 콤플렉스가 되어 성장과 적응 능력을 훼손함

(3) 생활양식

- 인간은 누구나 나름대로 독특한 신념과 행동 방식을 지님 => 생활양식
- 생활양식은 개인이 자신과 타인 그리고 세상에 대해 지니는 나름대로 신념 체계뿐만 아니라 일상적인 생활을 이끌어가는 감정과 행동 방식
- 개인의 모든 태도와 소망을 반영하는 것으로 열등감을 극복하고 최종목표를 성취하기 위해 추구하는 고유한 방식
- 생활양식은 개인의 모든 행동이 일관성 있게 조화를 이루도록 함
- 생활양식은 어린 시절의 가족 경험으로 발달
- 부모를 비롯한 가족 구성원과의 상호작용을 비롯하여 형제자매관계가 생활양식의 발달에 큰 영향을 미침

- 심리치료에서 생활양식의 분석은 내담자의 장기목표와 동기를 이해하는 데 필수적인 과정
- 내담자가 삶에서 겪은 도전과 역경을 극복하기 위해 창조적으로 발달시켜온 신념 체계와 행동 패턴을 이해할 수 있음

(4) 사회적 관심

- 정신건강의 주요한 지표
- 성공적인 삶과 건강한 성격의 기준은 개인이 자기 삶과 생활과제에 접근하는 방식 속에 얼마나 사회적 관심을 포함하고 있는지
- 세 가지 발달적 측면
- ① 타고난 기질 : 다른 사람과의 관계를 추구하고 협동하는 기질적 측면을 의미하며 선천적인 개인차를 나타냄
- ② 개인적 능력 : 타인을 이해하고 공감하며 협동과 이바지를 할 수 있는 사회적 능력. 이러한 능력은 교육과 훈련을 통해 함양
- ③ 일반적 태도 : 다른 사람과의 협동을 소중하게 여기고 사회적 이익을 위해 헌신하려는 의지
- 두 가지 차원
- ① 사회적 환경과 조화를 이루기 위해 타협하고 협동하려는 노력
- ② 사회적 이익과 발전을 위해 자신을 희생하고 이바지하려는 노력

(5) 출생순서와 가족구조

- 가족 내에서 아이의 서열적 위치는 자신과 세상에 대한 관점과 생활양식을 발달시키는 데 중요한 역할
- 아들러는 출생순서가 개인의 행동양식에 미치는 영향력을 강조했으나 그것이 결정적인 것은 아님. 다만 가족 내의 형제 서열에 따라 아이가 겪을 수 있는 특별한 경험의 가능성을 제시
- 아들러는 개인의 발달에 큰 영향을 미치는 사회적 맥락으로서 부모, 형제자매, 중요한 타인들을 포함
- 출생서열에 따라 나타나는 전형적인 특징들이 존재하지만, 이러한 특성은 고정 불변적인 것이 아니라는 점을 주의
 - 첫째 아이 : 부모로부터 많은 관심을 받으며 응석받이로 자람. 그러나 동생이 태어나면 왕좌에서 물러나는 듯한 박탈감. 아이는 착한 행동을 함으로써 우월한 지위를 되찾으려고 노력. 첫째 아이는 책임감이 강함. 이러한 책임감으로 가정을 돌보는 일에 몰두하여 친구 관계나 사회생활 경시할 수 있음
 - 둘째 아이 : 태어날 때부터 이미 첫째 아이가 존재하기 때문에 부모의 사랑을 나누어 가져야 함. 더구나 항상 자신보다 앞서가는 첫째 아이가 있어서 압박감을 느끼는 동시에 경쟁적인 성향 보일 수 있음. 둘째 아이는 첫째 아이와 다른 영역의 능력을 개발시켜 인정받으려는 경향. 둘째 아이는 첫째 아이와 반대되는 성격 발달
 - 중간 아이 : 위와 아래로 형제나 자매를 두고 있어서 압박감. 자기 능력에 대한 확신을 갖지 못한 채 무력감을 느끼며 다른 형제와 자매들에게 의존적인 태도를 나타낼 수 있음. 그러나 친구를 사귀거나 사회적 관계를 맺는 일에서 강점을 보일 수 있으며 갈등이 많은 가족에서는

갈등 조정자나 평화유지군의 역할

- 막내 아이 : 가장 어린아이로서 가족의 관심을 듬뿍 받을 수 있는 위치에서 성장. 과잉보호 받을 수 있으며, 의존적이고 자기중심적이며 무책임한 아이로 성장할 수 있음. 때로는 가장 낮은 위치에 있어서 가족 구성원들로부터 제대로 대우받지 못하여 열등감과 무력감 느낌. 그러나 자유로움 속에서 자신의 길을 추구하며 매우 독특한 영역에서 탁월한 성취를 나타낼 수 있음
- 외동아이 : 어른들만 둘러싸인 환경에서 성장. 경쟁할 다른 아이들이 존재하지 않기 때문에 그들은 어른 수준의 성취를 이루기 위해 노력하며 높은 성취동기를 지님. 부모가 너무 유능할 경우, 아이는 부모와 경쟁하는 것이 불가능하다고 여겨 낙담하거나 그들이 유능함을 발휘할 수 있는 다른 영역을 찾을 수 있음. 외동아이는 다른 형제자매들과 협동하거나 분배하는 것을 배우지 못해 자기중심적인 행동을 나타낼 수 있음. 다른 사람들의 관심을 독차지하는 것을 즐기며 이러한 욕구가 좌절되면 과민반응 보일 수 있음

(6) 성격 유형론

- 아들러는 개인이 자신만의 고유한 패턴에 따라 기술되어야 한다고 믿었기 때문에 어떤 유형론도 제시하지 않음. 그러나 교육적 목적을 위해 타인과 관계를 맺는 개인의 태도를 네 가지 유형으로 나누어 제시
- 지배형, 의존형, 회피형, 사회적 공헌형

2. 아들러 학파 치료의 목표 및 원리

1) 정신병리 이론

- 아들러는 개인의 적응 수준을 정상과 비정상의 이분법적으로 분류하지 않고 연속선상에 있는 것으로 간주
- 개인을 정신 병리적 관점에서 보려 하지 않았을 뿐만 아니라 부적응 문제를 정신장애 범주로 분류하지 않음
- 따라서 정신병리에 대한 체계적인 설명과 이론 제시하지 않음
- 개인이 나타내는 부적응 문제와 증상이 그의 개인적인 삶에 있어 어떤 의미를 지니는지 이해하고자 함
- 대부분의 부적응적 증상은 자기 이해 부족에서 기인한다고 봄. 자신이 어떤 인생 목표를 지니고 있으며 어떤 생활양식을 통해 살아가고 있는지에 대한 인식 부족은 부적응적 증상을 유발할 수 있음
- 부적응적 행동의 주요 원인 열등감. 열등 콤플렉스를 지니거나 우월 콤플렉스를 지닌 경우
- 공동체 의식의 결핍이 정신병리 유발. 공동체 의식의 결핍으로 인한 부적절한 느낌과 긍정적인 인간관계를 형성하지 못하는 무능력으로 인해 발생
- 특정한 정신장애의 원인

정신장애	원인
불안장애	-용기를 잃은 상태에서 자신의 약점이 드러나는 것을 두려워하며 삶의 선택과 결정을 주저하거나 미루는 경향 -다른 사람이나 어려운 과제로부터 안전한 거리를 유지하고자 함
강박증	- 의사결정을 하지 못하고 미루면서 자신의 에너지를 삶의 기본과제 해결에 사용하는 대신 강박행동을 하는 데에 소진 - 시시각각 다가오는 시간은 자신들이 대처할 수 없는 삶의 문제에 직면하도록 강요하는 위험한 적
우울증	- 개인의 자존심을 보호하기 위한 것 - 일상생활의 부담을 과장하고, 도달할 수 없는 인생 목표를 추구하며, 그 목표를 성취하자, 못 한 것에 대해 타인이나 생활환경을 탓함 - 자신이 원하는 대로 하지 못한 것에 대한 분노를 지님 - 타인을 자신이 원하는 대로 조종하고 생활의 책임을 회피하기 위해 자신의 약점이 불평을 이용
중독	- 소심함, 고립에 대한 욕망, 과민함, 초조함 등으로 나타나는 열등감에 근거 - 약물 사용을 통한 기분전환의 갈망은 오만함이나 권력 추구와 같은 형태의 우월감 콤플렉스에서 비롯
범죄	- 공동체 감의 결여

2) 치료의 목표

- 내담자의 생활양식을 이해하고 부적응적인 목표와 신념을 파악하여 사회적 관심을 증가시키고 좀 더 적응적인 목표와 생활양식으로 변화시키는 것
- 치료자는 평등하고 존중적인 태도로 내담자와 협력적인 관계 형성하는 것이 중요
- 이러한 관계 속에서 내담자가 자신의 독특한 생활양식 이해하도록 도움
- 내담자가 생활 속에서 추구하는 목표를 탐색하고 그러한 목표를 추구하기 위해 어떻게 행동하는지 구체적으로 살펴봄
- 좌절 상태를 유인하는 잘못된 목표와 신념 그리고 행동 방식에 대해 도전하고 반박하며 수정하도록 도움

- (1) 내담자의 사회적 관심 증가
- (2) 내담자가 좌절감과 열등감을 극복하도록 도움
- (3) 내담자의 인생 목표와 생활방식 변화
- (4) 내담자의 잘못된 동기 변화
- (5) 내담자가 타인과 평등한 존재라는 인식을 갖도록 도움
- (6) 내담자가 사회에 이바지하는 구성원이 되도록 도움

3) 치료원리

- 통찰의 중요함을 강조
- 직면 : 잘못된 목표와 신념, 그리고 그것들과 연합된 감정과 행동 인식하는 것이 중요
- 심리 내적인 과정을 분석하기보다 내담자가 나타내는 대인관계 행동의 본질을 이해하고 긍정적인 변화가정을 촉진하는 것에 초점

3. 아들러 학파 치료기법의 적용

- 생활 양식분석
 - 가족 구도 : 가족 구성원이 가족 내에서 지니는 서열적, 심리적 위치
 - 가족 분위기 : 정서적 관계
 - 가족 가치 : 부모가 자녀들에게 기대하는 것
 - 성역할 지침
 - 아이의 역할 : 책임자, 보호자, 조정자, 실행자, 애완동물, 문제아, 버려진 아이 등
 - 초기 발달 경험
- 격려 : 다른 사람에게 용기를 북돋워 주는 치료자의 기본적인 태도이자 마음가짐
- 마치 ~인 것처럼 행동하기
- 수렁 피하기 : 흔히 빠지는 함정과 난처한 상황을 피하도록 돕는 기법
- 자신을 포착하기
- 단추 누르기
- 수프에 침 뱉기
- 즉시성
- 직면
- 과제부여

4. 아들러 학파 치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 인지치료, 실존치료, 가족치료, 현실치료에 영향을 끼침

2) 한계 및 비판

- 실증적 근거 부족
- 피상적
- 공동체 활동에 대한 참여와 책임감을 과도하게 강조함

분석심리학적 치료 / 3주차 2차시

1. 분석심리학 치료의 이해

1) 분석심리학은 융(Jung)에 의해 제시된 심층 심리이론이자 성격 이론

- 분석심리학은 융(Jung)에 의해 제시된 심층 심리이론이자 성격 이론
- 융은 스위스의 심리학자이자 정신과 의사
- 프로이트와 함께 정신분석 연구 활동에 참여했으나 프로이트가 성적인 욕구를 지나치게 강조하는 것에 반대하여 결별한 후 자신의 독자적인 이론체계를 제시하면서 분석심리학이라고 명명
- 융은 자신의 학문적 입장과 삶에 대한 태도를 표현

‘나의 생애는 무의식이 그 자신을 실현한 역사다. 무의식에 있는 모든 것은 사건이 되고 밖의 현상으로 나타나며, 인격 역시 그 무의식적인 조건에 따라 발견하고 스스로를 전제로서 체험하게 된다.

이러한 과정을 묘사함에 있어 나는 과학적인 언어를 사용할 수가 없다.

왜냐하면 나는 나 자신을 과학의 문제로 경험할 수 없기 때문이다.

내면적인 관점에서 본 우리의 존재, 즉 인간이 그 영원한 본질적인 성질에서 우리에게 보여주는 것은 오직 신화로서 묘사될 수 있다.

신화는 보다 개성적이며, 과학보다 더욱 정확하게 삶을 묘사한다.

과학은 평균개념을 가지고 작업을 하는데, 이것은 너무 일반적이어서 개인의 특유한 인생이 지니고 있는 주관적인 다양성을 올바르게 파악하기 어렵다(Jung & Jaffe, 1965).’

- 프로이트와 vs. 융

	프로이트	융
공통점	무의식을 의식화하는 과정이 인간의 성숙에 중요	무의식을 의식화하는 과정이 인간의 성숙에 중요
차이점	- 성욕구와 같이 미숙하고 비합리적인 것 - 증상은 과거에 경험한 상처의 결과 - 인간을 성욕과 같은 본능적 욕구에 의해 떠밀려가는 존재	- 개인의 삶에 방향을 제시하는 지혜로운 것 - 미래에 나아갈 방향을 보여주는 신호 - 무의식의 발현을 향해 나아가는 존재

2) 성격의 구조

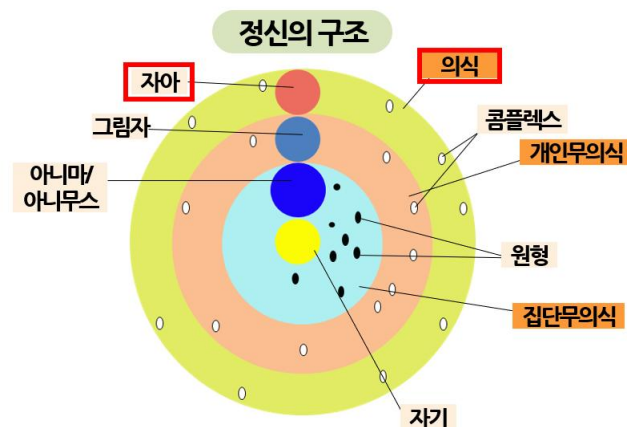
- 전체성 : 융이 제시하는 성격 이론의 핵심. 인간의 성격 전체를 ‘영혼(psyche)’이라고 명명
- 인간은 여러 부분의 집합이 아니라 하나의 통합적 전체
- 여러 체계로 분화되어 분열된 성격은 건강하지 못한 성격

- 자기(self)를 성격의 중심이자 전체로 봄

(1) 의식, 개인 무의식과 집단무의식

① 의식(consciousness)

- 개인이 유일하게 직접적으로 알 수 있는 부분
- 개인은 타인과 구별되는 자신만의 고유한 존재로 성장하는데, 융은 이러한 과정을 개성화(individuation)라고 함
- 개성화의 목표는 개인이 가능한 한 완전하게 자신의 전체성을 의식하는 것, 즉 '자기의식의 확대'
- 개성화는 무의식적 내용을 의식으로 가져옴으로써 이를 수 있음
- 의식의 중심에는 자아(ego)가 존재
- 자아는 개인의 정체성과 자기 가치감을 추구하며 자신과 타인과의 경계를 수립하여 구분하는 기능
- 자아는 의식에 대한 문지기 역할을 하며 지각, 사고, 기억 그리고 감정이 의식될지를 판단

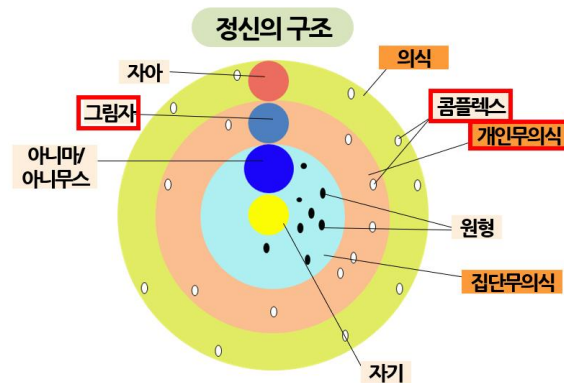


② 개인 무의식(personal unconsciousness)

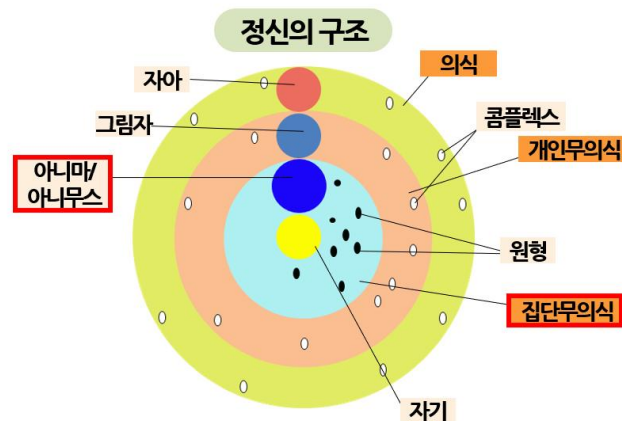
- 자아에 의해 인정받지 못한 경험, 사고, 감정, 지각, 기억을 의미
- 개인 무의식에 저장된 내용들은 중요하지 않거나 현재와 무관하다고 여겨질 수 있음. 또는 심리적 갈등, 미해결된 도덕적 문제, 정서적 불쾌감을 주는 생각들과 같이 여러 가지 이유로 억압
- 개인 무의식은 꿈을 만들어 내는 데 중요한 역할
- 개인 무의식의 고통스러운 사고, 기억, 감정들이 어떤 주제를 중심으로 뭉치고 연합되어 심리적 복합체를 이룬 것이 콤플렉스(complex)
- 콤플렉스를 의식화하는 것이 심리치료의 목표

③ 집단 무의식(collective unconsciousness)

- 다른 이론들과 가장 차별화되는 개념



- 집단무의식은 개인 무의식과 달리 특별한 개인의 경험과 인식 내용을 담고 있지 않음
- 집단무의식은 인간에게 전해져 내려온 보편적인 경향성으로서 신화적 모티브의 표상을 형성하는 것
- 모든 인간은 유사한 생리 구조를 지니고 있으며 비슷한 환경적 요소를 공유하기 때문에, 개인은 세상에 대한 보편적인 방식으로 생각하고 느끼고 반응할 수 있는 소질들을 가지게 됨
- 개인의 마음속에 존재하는 인류 보편적인 심리적 성향과 구조가 집단무의식
- 집단무의식을 구성하는 주된 내용은 본능과 원형
- 본능은 행동을 일으키는 충동을 의미하며, 원형은 경험을 지각하고 구성하는 방식



(2) 원형의 다섯 가지 유형

① 원형

- 원형은 내용을 지니지 않고 형태만을 지닌 심리적 반응
- 원형은 어떤 유형의 지각과 행동의 가능성을 나타냄
- 원형은 콤플렉스의 핵심을 이루며 원형이 중심이 되어 관련 있는 경험을 끌어당겨 콤플렉스를 형성
- 원형의 내용을 구성하는 것은 상징(symbols)
- 원형은 꿈, 환상, 환영, 신화, 동화, 예술 등에서 나타나는 상징을 통해 표현
- 상징은 정신의 표현이며, 인간성의 모든 면이 투영

- 영웅, 순교자, 전사, 위대한 어머니, 현명한 노인, 악마 사기꾼, 고통받는 소녀 등

② 페르조나

- 라틴어로 '가면'이라는 뜻. 개인이 다른 사람들에게 자신을 드러내는 방식
- 페르조나는 사람이 특정한 상황에서 자신의 감정, 사고, 행동을 조절해야 하는 것을 배우는 데 유용
- 그러나 페르조나를 너무 중요하게 여기면 개인은 진정한 자신으로부터 유리되어 형식적이고 피상적인 삶을 살게 될 그럴 뿐만 아니라 순수한 감정을 경험하기 어려워짐

③ 아니마와 아니무스

- 자신과 반대되는 성(性)의 특성
- 무의식 속에 지닌 이성의 속성
- 아니마는 남성에게 있으며 다정함이나 감성적 정서와 같은 여성적인 부분
- 아니무스는 여성에게 있어서 논리나 합리성과 같은 특징을 지니는 남성적인 부분
- 융은 조화로운 성격을 가질 수 있도록 남자는 아니마를, 여자는 아니무스를 무의식 속에서 끌어내야 한다고 주장

④ 그림자

- 개인이 자신의 성격이라고 의식적으로 인식하는 것과 반대되는 특성
- 의식되지 않은 자아의 분식
- 개인이 의식적으로 받아들이기 힘든 성적이고 동물적이며 공격적인 충동
- 프로이트가 말한 원초아와 유사
- 그림자는 잠재적으로 가장 위험하고 강력한 콤플렉스로서 자아가 이를 받아들여 화목하게 영혼 속에 편입시킬 수 있느냐의 여부가 심리적 건강에 매우 중요
- 그림자를 적절히 표현하는 것은 창조력, 활력, 영감의 원천
- 그림자를 과도하게 억압하면 자유로운 표현이 억제되어 진정한 자아로부터 괴리될 뿐만 아니라 불안과 긴장 상태에 빠짐
- 개인들에게 있어 치료의 목표는 그들의 그림자를 의식으로 가져와 표현하도록 돕는 것

⑤ 자기(self)

- 의식과 무의식을 포함한 성격 전체의 중심
- 자기는 성격을 구성하고 통합하는 에너지를 제공하는 일
- 자아가 의식의 중심이라면, 자기는 성격 전체의 중심이면서 동시에 성격 전체를 포함
- 개성화가 일어나지 않은 미숙한 사람들의 경우에는 자기가 무의식의 중심에 묻혀 있어서 다른 원형과 콤플렉스를 잘 인식하지 못함
- 개인이 성숙해지고 개성화함에 따라 자아와 자기의 관계가 밀착되어 모든 성격 구조에 대한 의식이 확대됨
- 융은 자기의 실현이 인간 삶의 궁극적 목표라고 봄
- 개인이 자신의 성격 기능을 완전히 발현할 때, 자기 원형에 접촉하여 무의식의 내용들을 의식으로 더 많이 가져올 수 있음

3) 성격의 유형과 발달

① 성격유형

- 내면적 세계 또는 외부적 세계에 관해 관심과 에너지를 투여하는 방향성에 따라 외향성과 내향성의 두 가지 태도 구분. 개인은 상황에 따라 외향적일 수도 내향적일 수도 있음. 대부분은 한쪽의 태도가 우세. 그러나 그것은 정도의 문제
- 성격을 구성하는 기능에는 사고, 감정, 감각, 직관의 네 가지. 사고는 사물을 이해하고자 하는 지적 기능으로 여러 관념을 연결시켜 문제를 해결하는 역할. 감정은 평가의 기능을 말하며 어떤 관념이 긍정적 감정 또는 부정적 감정을 일으키는지에 따라 그 관념을 받아들일지 결정. 사고와 감정은 모두 이성의 개입에 의한 판단행위가 개입되기 때문에 '합리적' 기능
- 감각은 감각기관의 자극으로 생기는 모든 의식적 경험 포함. 직관은 직접적으로 주어지는 경험이라는 점에서 감각과 비슷하지만, 감각은 자극의 근원이 분명하지만, 직관은 갑자기 나타나며 그 근원과 과정을 설명할 수 없음. 감각과 직관은 이성과 판단해야 하지 않기 때문에 '비합리적' 기능이라고 지칭
- 두 가지 태도와 네 가지의 기능을 조합하여 여덟 가지의 성격유형

② 성격 발달

아동기	- 출생에서 시작하여 사춘기 또는 성적 성숙기까지, 본능적 에너지에 의해 움직임 - 부모의 역할은 아동의 에너지의 방향을 잡아 주어 아동이 혼란스럽거나 무질서하게 되지 않도록 하는 것 - 이 단계 초기에 자아가 형성 - 자신을 일인칭으로 말하기 시작하며 학교에 입학하면서 부모의 세계, 즉 심리적 자궁에서 빠져나오기 시작
청년기	- 사춘기에 일어나는 생리적 변화로부터 시작 - 생리적 변화는 정신적 측면에서도 혁명적 변화를 유발, '정신적 탄생기' - 사회생활에 적응해 나가는 다양한 방법을 배움 - 이러한 적응방식을 잘 습득하게 되면 큰 어려움을 겪지 않지만, 아동기의 환상에 집착하여 현실을 인식하지 못하면 많은 어려움에 부딪히게 됨 - 이 단계에서 발생하는 정신적 문제는 성적 욕구에 의한 심리적 혼란과 밀접하게 관련
중년기	- 약 35세부터 40대 후반 - 용이 이 시기에 정신적 위기를 겪었으며, 자기 내면을 재검토하고 꿈과 창조적 작업을 통해 무의식을 탐색하였던 경험으로 각별한 관심을 보인 시기 - 지금까지 외부 세계에 대한 적응에 사용되었던 에너지가 새로운 정신적 가치로 방향을 돌리게 됨. 젊은 시절의 외향적이고 물질주의적인 관심에서 내향적이고 정신적인 영역으로 관심이 변화되거나 확대
노년기	- 무의식 세계에 더 깊은 관심 - 삶을 반성하고 지혜를 키우는 시기.

2. 분석심리학 치료의 목표 및 원리

1) 치료의 목표

- 분석적 심리치료의 과정과 목표는 개성화와 성격의 통합
- 무의식과 의식의 통합을 통해 자기를 충분히 실현하는 것
- 구체적인 치료 목표는 개인의 발달단계와 특수한 상황에 따라 달라짐

2) 치료의 원리

- 인생의 전반기를 살아가는 내담자의 치료는 현실 적응을 위한 구체적 목표를 성취하는데 초점이 모이지만, 인생의 후반기를 살아가는 내담자는 자기실현에 초점

3. 분석심리학 치료기법의 적용

1) 개인에 대한 이해를 중시

- 융은 정신병리 현상을 건강한 사람이 지니는 심리적 속성의 연장선에서 이해하고자 함
- 분석심리학에서는 정상과 이상, 건강과 장애에 대한 절대적 구분이 없으며 증상을 확인하여 기술하고 이름을 붙이는 일을 중요하게 여기지 않음
- 분석심리학에는 정신병리 이론이 존재하지 않음. 고통을 겪고 있는 환자 개개인에 대한 이해를 중요시 함
- 개인이 병적인 현상을 나타내는 이유는 자신의 무의식에 대한 무지로 인한 것
- 표출되어 올라오는 무의식의 의미를 깨닫지 못하거나 받아들이지 못하는 사람은 마음의 병을 얻게 됨

2) 신경증

- 신경증은 그 증상의 의미를 아직 발견하지 못한 마음의 고통
- 신경증 증상은 미래 지향적인 의미를 지니며, 신경증 치료의 핵심은 바로 이러한 증상의 의미를 발견하여 깨닫는 것
- 신경증은 일종의 자기소외로부터 자기로부터 멀어질수록 증상이 심해짐
- 분석적 심리치료는 치료자와 내담자의 인간적인 대화로 이루어짐

3) 치료기법

- 꿈 분석, 전이 분석, 적극적 상상 등과 같은 다양한 방법을 통해 내담자의 무의식 탐색
- 꿈 분석에서는 꿈의 맥락을 파악하여 꿈을 해석
- 전이 분석의 경우, 처음에는 개인 무의식으로부터의 투사를 다루고 그 후에 집단무의식의 투사를 다룸
- 적극적 상상을 통해 심상 활동을 활성화함으로써 무의식을 탐색하고 이해

4. 분석심리학의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 인간의 정신, 특히 무의식 세계에 대한 보다 심층적인 접근과 이해를 가능하게 함
- 모든 인류에게 보편적으로 존재하는 집단 무의식과 원형이라는 개념을 통해 사회문화적인 특수성을 넘어 정신장애 환자를 비롯한 모든 인간이 공통적 심성구조를 지닌 한 집단의 일원임을 인식하게 해줌
- 개인화 또는 자기실현이라는 개념을 통해 치료의 목표뿐만 아니라 인생의 의미와 목적을 새로운 관점에서 바라볼 수 있는 기틀을 제공

2) 한계 및 비판

- 치료효과에 대한 실증적인 연구 거의 이루어지지 않음
- 장기간의 치료기간
- 치료 대상이 제한

인간중심 치료 / 4주차 1차시

1. 인간중심 치료의 이해

- 1950-60년대에 양대 산맥을 형성하고 있던 정신분석과 행동주의 이론을 비판하면서 긍정적 인간관에 근거하여 새롭게 대두
- 결정론적(정신분석)이고 기계론적인 관점(행동주의)에 근거하여 인간의 자유의지와 존엄성을 무시하는 기존의 심리학 이론을 비판
- 자기실현 욕구를 인간의 가장 기본적인 상위 동기임을 주장. 인간을 전체적이고 통합적인 존재로 이해

1) 기본가정

- 인간은 자신을 구성하는 부분의 합을 넘어선 존재로서 구성요소로 환원될 수 없음
- 인간은 우주 생태계 속에서 실존하고 있을 뿐만 아니라 독특한 인간사회 속에서 실존하는 존재
- 인간은 자신에 대해 자각하고 있다는 것을 자각하는 의식적인 존재로서 다른 사람과의 관계 속에서 자신을 자각
- 인간은 선택하는 능력을 지니고 있으며 따라서 책임의식을 지님
- 인간은 의도적으로 행동하는 존재로서 나름대로의 목표를 지향하는 동시에 인생의 의미, 가치, 그리고 창의적인 것을 추구

2) 학자별 주요개념

(1) 매슬로(Maslow)의 인본주의 이론

- 자기실현
 - 욕구위계이론에서 가장 높은 욕구에 위치
 - 인간을 비롯한 모든 생명체 안에 깃들여 있는 고유한 속성을 표출하고 발전하려는 성향을 의미
 - 자기실현은 결핍을 채우기 위한 욕구가 아니라 성장을 추구하는 욕구로 개인의 포부와 야망을 성취하는데 기여
- 욕구위계이론
- 자기실현적 인간
 - 창조적 업적과 인격적 성숙을 통해 자아실현을 이룬 세계적인 위인들의 삶을 치밀하게



분석하여 자기실현적 인간의 15가지 특성을 추출

현실에 대한 정확한 인식	수용적 태도	솔직성과 자발성	창의적 태도	예민한 감상 능력
절정경험의 체험	자율성	혼자만의 시간에 대한 욕구	문화적 압력에 대한 저항	깊이 있는 대인관계
인도주의적 성향	비공격적인 유머감각	사명의식과 헌신적 태도	민주적인 인격구조	수단과 목적의 분별

- 자아실현적 사람들은 결핍동기보다 성장동기를 중시
- 많은 사람들이 자신의 새로운 변화를 다른 사람들이 받아들이지 못할 것이라는 두려움 때문에 개인적 성장을 회피하는 경향이 있다고 주장

(2) 로저스(Rogers)의 인간중심 이론

- 로저스는 인간이 기본적으로 유능하고 강인한 존재일 뿐만 아니라, 자신의 잠재력을 실현시킬 수 있는 능력을 지니고 있다고 주장
- 인간은 누구나 자신의 어려움을 극복하고 성장할 수 있는 역량을 지님
- 심리치료의 목표는 내담자가 자신의 내적 자원을 발휘할 수 있도록 자신에 대한 충분한 믿음과 신뢰감을 갖도록 하는 것
- 현상학적 입장에 근거, 현상학은 개인의 주관적인 경험과 인식을 중시
- 무의식 세계보다 의식적 경험을 중시할 뿐만 아니라, 객관적 현실보다 주관적 현실을 중시
- 개인의 행동을 이해하려면 그가 자기 자신과 자신이 존재하는 세계에 대하여 어떤 주관적 인식을 지니고 있는지를 알아야 함
- 따라서 다른 사람의 관점에서 부적절한 것일지라도, 그 자신에게는 체험된 진실이기 때문에 충분히 존중받을 가치가 있음
- 모든 유기체는 자신을 성장시키려는 자연적인 경향성을 지님
- 자기실현이란 최종의 완전한 상태를 의미하는 것이 아니라 더 유능한 인간으로 성장해가는

끊임없는 과정(on becoming)

■ 성격이론

① 통합된 유기체로서의 인간

- 인간은 하나의 통합된 유기체로 이해되어야 함
- 유기체는 육체와 정신을 모두 포함하는 전체로서의 개별적 생명체를 의미
- 어린 유아는 유기체적 감각을 통해 세상을 인식하며 통합된 전체로서 이에 반응
- 인간 유기체는 신체적 기능과 감각, 감정, 동기, 사고 등의 심리적 기능이 통합적으로 조직된 체계로서 환경과 상호작용하며 매 순간 유기체적 경험을 하게 됨
- 이러한 유기체적 경험은 개인이 경험하는 모든 것으로서 현상적 장, 즉 심리적 현실을 구성

② 주관적 현실로서의 현상적 장

- 현상적 장은 매 순간 개인의 의식에 지각되고 경험하는 모든 것
- 개인의 사적이고 주관적인 경험세계를 의미
- 세상이 개인에게 드러난 것으로서 개인이 반응할 수 있는 유일한 현실
- 현상적 장은 개인에게 실재적인 세계로 여겨지는 내적 참조체계로서 모든 판단과 행동의 근거

③ 자기실현 경향성

- 인간은 누구나 자신의 모든 잠재능력을 발현하여 좀 더 가치 있는 존재로 성장하려는 선천적인 성향, 즉 자기실현 경향성을 지님
- 자기실현 경향성은 두 가지의 방향성을 지님
- 하나는 개인이 선천적으로 타고나 신체적·심리적 기질을 그대로 유지하고 나타내려는 성향
- 다른 하나는 개인이 지닌 모든 잠재능력을 최대한 발휘하려는 성향
- 자기실현 경향성을 구속하는 유일한 요인은 개인이 속해 있는 환경
- 개인의 선천적 성향이 충분히 수용되고 존중받는 환경에서는 자기실현이 촉진
- 자신의 잠재능력을 충분히 발현하면서 자기실현을 이루는 사람들은 자신의 유기체적 경험을 수용하면서 자신의 삶에 만족할 뿐만 아니라 새로운 경험에 개방적인 자세를 지니고 다양한 삶의 과제에 도전하면서 창의적이고 생산적인 삶을 살아가는데, 이러한 사람은 온전히 기능하는 사람

④ 자기와 자기개념

- 자기는 로저스의 성격이론에서 가장 중요한 구성개념
- 어린 유아는 자신의 내부에서 지각되는 자기경험과 외부의 타인에 대한 경험을 구별하기 시작하면서 자기 존재에 대한 인식 발달
- 자기(self) 또는 자기개념(self-concept)은 개인이 자신에 대하여 지니고 있는 지속적인 체계적 인식을 의미
- 자기는 개인의 경험세계로부터 분화된 것으로서 자신에 대해서 의식적으로 지각한 것과 자신이 소중히 여기는 가치 포함
- 자기개념은 현재 자신이 어떤 사람인지에 대한 개인의 인식, 즉 자아상을 의미

- 자신에 대한 인식이 발달하면서 아동은 타인으로부터 긍정적인 존중을 받고자 하는 욕구 발달
- 자기개념은 현재의 자기 모습을 반영하는 현실적 자기뿐만 아니라 긍정적 존중을 받기 위해 추구해야 할 이상적 자기도 포함

⑤ 가치의 조건

- 개인은 각각의 경험을 자신이 어떻게 느끼는가에 따라 평가하는데, 이러한 평가과정을 유기체적 가치화 과정이라고 함
- 개인이 이러한 유기체적 가치화 과정에 따를 때, 자기는 경험과 일치하는 것으로 편안하게 여겨지기 때문에 방어의 필요성을 느끼지 못함
- 부모를 비롯한 중요한 타인과의 상호작용을 통해 자신이 소중하게 인정받는다는 느낌을 갖게 되는 가치의 조건을 습득
- 타인으로부터 받는 긍정적인 존중은 개인의 자기존중감과 자기가치감에 직접적인 영향을 미침

⑥ 자기와 경험의 불일치

- 개인이 유기체로서 소망하며 경험하는 것들과 자기존중감을 느끼기 위해 추구하는 것들 간에 불일치가 생겨나는 것

⑦ 무조건적 긍정적 존중과 온전히 기능하는 사람

- 개인이 경험하는 가치의 조건을 줄이기 위해 타인으로부터 무조건적 긍정적 존중이 필요하며 이를 통해 자기존중감이 증진

2. 인간중심 치료의 목표 및 원리

1) 치료의 목표

- 내담자가 직면한 문제의 해결뿐만 아니라 내담자의 심리적 성장을 목표
- 심리치료는 현재의 문제를 해결하기보다 내담자의 성장을 촉진함으로써 현재와 미래의 문제에 더 잘 대처할 수 있도록 도움
- 심리적 성장을 위해 내담자가 자신의 경험을 더 잘 자각하고 인식하여 있는 그대로의 자기 모습을 잘 수용하는 것이 중요
- 타인지향적인 삶을 사는 것이 아니라 자신의 내면적 욕망과 경험에 귀를 기울이며 자기주도적인 진실된 삶을 사는 것이 중요
- 내담자가 '온전히 기능하는 사람'이 되도록 돕는 것

2) 치료의 원리

- 내담자를 적응상태로 나아가도록 변화시키는 과정
- 개인의 부적응 상태를 정신병리적 진단범주로 분류하지 않음
- 심리적 부적응은 개인의 실현 경향성이 차단되고 봉쇄된 결과
예: 높은 성취를 강요하는 부모의 영향을 받고 자란 사람은 그들의 성취경험을 잘 기억하여 기억. 그러나 가치의 조건에 위배되는 경험과 행동은 그에 맞게 왜곡되거나 의식에서 배제
- 유기체적 경험을 탐색하고 자각하도록 함. 내담자의 몸과 마음에 떠오르는 감각, 욕망, 감정, 사고, 행동을 있는 그대로 자각하고 이러한 경험을 자신의 일부로 수용하는 것이 중요
- 자기수용과 자기신뢰가 증진되면, 자신이 방어할 필요성을 느끼지 못하기 때문에 자신의 내면적 욕구나 감정에 대한 솔직한 자기표현이 가능해짐
- 상담자는 내담자가 유기체적 경험을 왜곡 없이 지각하여 이를 자기개념에 통합할 수 있는 조건을 제공

3. 인간중심 치료기법의 적용

1) 내담자의 발전을 위한 상담기법

- 인간중심 심리상담 실제에서는 기법이 없다. 내담자와 '함께 존재하며' 최대한 내담자의 지각과 감정 세상 속으로 들어가는 것이 변화과정을 촉진하는 충분요건
- 내담자의 발전을 위해 꼭 필요한 것은 상담사의 존재함이며, 이는 내담자가 표현하는 관심과 함께 내담자에게도 완전히 집중하고 몰두하는 것

2) 치료결과를 결정하는 중요한 요인

- 무조건적 긍정적 존중, 공감적 이해, 진실함, 치료자의 태도와 인간적 특성, 내담자와 치료자의 관계의 질이 치료결과를 결정하는 중요한 요인

- 이론과 기법에 대한 치료자의 지식은 이차적 문제
- 내담자 스스로가 변화에 더 중대한 영향을 미침

4. 인간중심 치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 긍정적 인간관에 근거한 새로운 심리치료 모델 제시
- 문제해결을 위한 기법적인 전문활동이 아니라 인간 대 인간의 진정한 만남이 되어야 한다는 점을 일깨워 줌
- 치료자는 내담자의 잠재능력이 발현될 수 있는 치료적 분위기를 조성하는 촉매자라는 점을 설득력 있게 제시
- 인간이 성장 가능성을 지닌 긍정적 존재라는 인간관을 제시함으로써 치료자들로 하여금 내담자에 대한 관점을 긍정적으로 변화시킴
- 치료과정을 녹음하여 분석하는 방법 제시하여 치료자를 훈련시키기 위한 슈퍼비전 과정을 향상시키는데 기여
- 교육, 간호, 정치적 협상, 국제적 교류에도 영향을 미침

2) 한계 및 비판

- 전통적인 진단과 정신장애 분류체계의 유용성 부정
- 내담자의 문제를 지나치게 단순화 또는 일반화
- 다른 치료 이론에 비해 개념이 상대적으로 적고 단순

게슈탈트 치료 / 4주차 2차시

1. 게슈탈트 치료의 이해

- 1950년에 처음으로 '게슈탈트 치료'라는 용어를 만들
- 1960년대 이후 주목받기 시작

1) 게슈탈트(Gestalt)란?

- '전체', '형상', '형태', '모습' 등의 뜻을 지닌 독일어
- 개체는 대상을 지각할 때 부분들의 집합이 아니라 하나의 의미 있는 전체 즉, '게슈탈트'로 만들어 지각
- 만일 완결된 게슈탈트를 만들어 내지 못하면 이것은 유기체에 압력이 되어 계속 완결을 요구
- 개체가 자신의 욕구나 감정을 하나의 의미 있는 전체로 조직화하여 지각
- 욕구나 감정을 하나의 의미 있는 전체로 조직화하여 지각한 것을 게슈탈트라고 함
- 개체가 게슈탈트 형성에 실패하면 심리적, 신체적 장애
- 건강한 삶이란 분명하고 강한 게슈탈트를 형성할 수 있는 능력
- 그러나 게슈탈트를 형성하려고 인위적인 노력할 필요 없음
- 유기체가 매 순간 그 상황에서 자신에게 가장 필요한 것을 자연적으로 알아서 지각하고 해결하기 때문
- 유기체는 자기조정 능력이 있어 매 순간 자신에게 가장 필요한 욕구의 순서로 게슈탈트를 형성

2) 전경과 배경

- 어떤 대상을 지각할 때 관심이 있는 부분은 지각의 중심 부분, 나머지는 배경
- 게슈탈트를 형성한다는 말은 개체가 어느 한순간에 가장 중요한 욕구나 감정을 지각하여 전경으로 떠올리는 것
- 건강한 개체는 매 순간 자신에게 중요한 게슈탈트를 선명하고 강하게 형성하여 전경으로 떠올릴 수 있는데 반해, 그렇지 못한 개체는 전경을 배경으로부터 명확히 구분하지 못함
- 게슈탈트의 형성과 해소(전경이 배경과 교체) : 개체가 전경으로 떠올렸던 게슈탈트를 해소하고 나면 그것은 전경에서 배경으로 물러남 -> 다시 새로운 게슈탈트가 형성되어 전경으로 떠오르고, 해소되고 나면 다시 배경으로 물러남

3) 미해결 과제

- 어떤 게슈탈트를 형성하였지만, 상황적 여건에 따라 이를 해결하지 못하였거나 아니면 게슈탈트 형성 자체가 방해받았을 때 그것은 배경으로 사라지지 않고, 배경에 남아 있으면서

계속 전경으로 떠오르려고 노력

- 개체는 게슈탈트를 완결지으려는 강한 동기를 지니고 있는바, 아직 완결되지 않았으므로 계속 전경으로 떠오르려고 함
- 완결되지 않은 혹은 해소되지 않은 게슈탈트를 '미해결 게슈탈트' 혹은 '미해결 과제'라고 함
- 이러한 미해결 과제는 계속 이의 해결을 요구하며 전경으로 떠오르려 하기 때문에, 다른 게슈탈트가 선명하게 형성되는 것을 방해

예 : 아침에 남편과 싸우고 출근한 아내. 그것이 미해결 과제로 남아 회사 일에 집중 어려움

- 미해결 과제가 많아질수록 개체는 자신의 유기체 욕구를 효과적으로 해소하는 데 실패하게 되고 마침내 심리적, 신체적 장애
- 미해결 과제를 해결하는 방법은 '지금-여기'를 알아차리는 것

4) 알아차림과 접촉

- 전경과 배경의 교체에서 알아차림과 접촉이 매우 중요
- 알아차림이란 개체가 자신의 욕구나 감정을 지각하여 게슈탈트로 형성하여 전경으로 떠올리는 행위 또는 그러한 능력
- 알아차림은 누구에게나 자연적으로 갖추어져 있는 능력
- 접촉은 전경으로 떠오른 게슈탈트를 해소하기 위해 환경과 상호작용하는 행위

예 : 갈증을 알아차리면 갈증이 게슈탈트로 떠오르면 물을 마심으로써 게슈탈트를 해소.

여기서 물을 마시는 행위가 접촉

- 알아차림은 게슈탈트 형성과 관계하며, 접촉은 게슈탈트의 해소에 관계
- 둘 중에 어느 한쪽이라도 없으면 전경과 배경의 원활한 교체 불가능
- 접촉-경계 혼란이 개입함으로써 개체는 자신의 알아차림을 인위적으로 '차단'하고, 그 결과 게슈탈트 형성에 실패
- 게슈탈트가 형성되고 해소되는 반복과정을 '알아차림-접촉 주기'
- 건강한 유기체는 환경과의 교류를 통해 알아차림-접촉 주기를 자연스럽게 반복



(1) 배경 (2) 유기체 욕구나 감정이 신체감각의 형태로 나타남 (3) 개체가 이를 알아차려 게슈탈트를 형성하여 전경으로 떠올림 (4) 이를 해소하기 위해 에너지(흥분) 동원 (5) 행동 (6)

환경과의 접촉을 통해 게슈탈트 해소

5) 접촉-경계 혼란

- 건강한 개체는 접촉-경계에서 환경과 교류하면서 자신에게 필요한 것들은 경계를 열어 받아들이고, 환경에서 들어오는 해로운 것들에 대해서는 경계를 닫음으로써 이들의 해독으로부터 자신을 보호
- 경계에 문제가 생기면 이러한 환경과의 유기적인 교류 접촉이 차단되고 심리적, 생리적 혼란 발생

(1) 내사

- 치아 공격성 : 자신에게 필요한 것들을 외부로부터 받아들여, 이를 소화하고 동화시킴으로써 성장
- 치아 공격성 사용을 제지당하면 개체는 환경을 무비판적으로 받아들이게 됨
- 이렇게 무비판적으로 받아들임으로써 자기 것으로 동화되지 못한 채 남아 있으면서, 개체의 행동이나 사고방식에 악영향을 미치는 타인의 행동 방식이나 가치관을 내사라고 함
- 내사된 규칙과 도덕적 명령에 따라서만 살아감

(2) 투사

- 자신의 욕구나 감정을 자신의 것으로 자각하고 접촉하는 것을 두려워하며, 이를 차단하여 그것들에 대한 책임을 타인에게 돌림
- 투사를 함으로써 자신의 욕구가 좌절되는 것보다 고통을 덜 받음

(3) 반전

- 개체가 다른 사람이나 환경에 대하여 하고 싶은 행동을 자기 자신에게 하는 것, 혹은 타인이 자기에게 해주기를 바라는 행동을 스스로 자기 자신에게 하는 것
- 반전은 타인이나 환경과 상호작용하는 대신 자기 자신을 행동의 대상으로 삼는 것
- 성장 환경이 억압적이거나 비우호적이어서 개체가 자연스러운 접촉 행동을 할 수 없을 때 발생

(4) 융합

- 밀접한 관계에 있는 두 사람이 서로 차이점이 없다고 느끼도록 합의함으로써 발생하는 '접촉-경계 혼란'
- 서로 독립적이지 못하고 의존적 관계
- 갈등과 불일치 용납 못함

(5) 편향

- 감당하기 힘든 내적 갈등이나 외부 환경적 자극에 노출될 때, 이러한 경험으로부터 압도당하지 않기 위해 자신의 감각을 둔화시킴으로써 자신이나 환경과의 접촉을 약화시키는데 이를 편향이라고 함
- 예: 말을 장황하게 하거나 초점을 흐트리는 것, 말하면서 상대방을 쳐다보지 않거나 웃는 것 등

2. 게슈탈트 치료의 목표 및 원리

1) 치료의 목표

- 단절된 연결성을 회복하여 자기 자신의 내면과 타인, 환경, 문화, 자연, 우주, 신과 연결되도록 도와주는 작업
- 알아차림이 계속 이어지도록 하여 유기체, 관계, 집단, 사회 중 어떤 것에 관한 것이든 가장 큰 관심사와 흥미거리가 게슈탈트를 형성하여 전경으로 부각되어 온전히 경험되고 처리됨으로써 배경으로 녹아들어갈 수 있게 하여 그 다음에 떠오르는 적절한 게슈탈트에게 전경 자리를 내어주며 자유롭게 진행되는 게슈탈트 형성과정을 의미
- 내담자의 체험을 확장
- 내담자의 인격을 통합
- 내담자의 자립 능력 증진
- 자신의 삶에 대한 책임감 자각

2) 치료의 원리

(1) 알아차림

- 내담자의 인격을 통합
- 유기체의 내면적 욕구를 전경으로 떠올려 강한 게슈탈트를 형성함으로써 이러한 욕구의 완결을 가능하게 해줌
- 미해결 과제를 알아차림으로써 과제를 해소
- 현재 상황에서 새롭게 일어나는 욕구나 감정을 알아차려 게슈탈트 형성

(2) 접촉

- 자기 자신과의 접촉을 증진. 개인은 살아가면서 자기 자신이라고 동일시해온 부분 이외의 것들에 대해 회피. 만일 그러한 것들이 전경으로 떠오르려 하면 불안과 죄책감을 느끼게 되어 차단되고, 미해결 과제로 남음
- 대인관계 접촉을 증진. 대인관계 접촉은 가장 보편적 형태. 원활한 접촉을 위해 나와 다른 사람의 경계 명확, 서로 융합되거나 소외되지 않기 위해 긍정적 변화를 위한 에너지와 활력 필요, 만남의 순간에 의식되는 것들을 자유롭게 표현
- 환경과 접촉. 환경이란 인간 이외의 모든 생물이나 무생물을 의미. 환경과 잘 접촉한다는 것은 어떤 개념이나 인위적인 분석 없이 그냥 환경을 있는 그대로 지각하고 만나는 것을 의미

(3) 치료를 통한 성격 변화 단계

① 피상층

- 형식적이고 의례적인 규범에 따라 피상적으로 만나는 단계

② 공포층

- 고유한 자기 모습으로 살아가지 않고, 부모나 주위 환경의 기대에 맞추어 행동하며 살아가는 단계

③ 교착층

- 이제껏 해왔던 역할연기를 그만두고 자립하려고 시도하지만 동시에 심한 공포체험
- 이 단계에 들어서기를 회피하지만, 치료가 진전되면 내담자들은 이 단계에 도달
- 마음이 공허하다. 갑자기 모든 게 혼란스럽다. 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠다는 보고

④ 내파층

- 자신이 억압하고 차단해왔던 욕구나 감정을 알아차림
- 유기체 에너지들은 오랫동안 차단됐던 것들이기 때문에 상당한 파괴력 지님
- 이러한 파괴적 에너지를 외부로 발산하면 타인과의 관계가 악화될 것이라는 두려움을 느끼기 때문에 자신의 내부로 향하게 함
- 반전 행동 자주 보임

⑤ 폭발층

- 자신의 감정이나 욕구를 더 이상 억압하거나 차단하지 않고 밖으로 표출
- 억압하고 차단했던 미해결 과제들을 전경으로 떠올려 해소하고 완결지을 수 있음

3. 게슈탈트 치료기법의 적용

1) 욕구와 감정 자각

- 욕구와 감정을 자각함으로써 게슈탈트 형성 원활히 하고 환경과의 생생한 접촉을 가능하게 함

2) 신체자각

- 신체감각에 대해 자각하도록 함으로써, 자신의 감정이나 욕구 혹은 무의식적인 생각을 알아차리게 함

3) 환경자각

- 주위 사물과 환경에 대해 자각하도록 해줌으로써 환경과의 접촉을 증진시킴
- 내담자들은 흔히 미해결 과제로 인해 자기 자신에게 몰입해 있어서, 주위 환경에서 일어나는 사건들이나 상황을 잘못 알아차림

4) 언어자각

- 내담자가 사용하는 언어에서 행동의 책임소재가 불명확한 경우, 치료자는 내담자가 자신의 감정과 동기에 대해 책임을 지는 형식의 문장으로 바꾸어 말하게 시킴으로써 내담자의 책임 의식을 높임

5) 과장하기

- 내담자가 어떤 상황에서 자신의 감정을 체험하지만, 아직 그 정도와 깊이가 미약하여 그 감정을 명확히 자각하지 못하고 있을 때, 치료자는 내담자의 행동이나 언어를 과장하여 표현하게

함으로써 내담자의 감정 자각을 도움

6) 반대로 하기

- 내담자가 보이는 행동은 근거에 있는 억압된 충동의 반대 표현. 따라서 평소 행동과 반대되는 행동을 해보도록 요구함으로써 내담자가 억압하고 통제해온 자신의 다른 측면을 접촉하고 통합할 수 있도록 도움

7) 머물러 있기

- 내담자가 자신의 감정을 피하지 말고 계속 직면하여 그 상태에 머물러 있도록 요구함으로써 미해결 과제를 완결시키도록 도움

8) 빈 의자 기법

- 현재 치료 장면에서 와 있지 않은 사람과 상호작용할 필요가 있을 때 사용
- 내담자는 그 인물의 맞은편 빈 의자에 앉아 있다고 상상하고 그와 대화

9) 자기 부분들 간의 대화

- 내담자의 인격에서 분열된 부분들을 찾아내어 그것 간에 서로 대화시킴으로써 분열된 자기 부분들을 통합

4. 게슈탈트치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 개인이 자기 자신, 타인 그리고 환경과 접촉하는 것이 중요함을 일깨워줌
- 심리치료에서 치료자와 내담자의 진정한 관계가 중심적 역할을 해야 한다는 점을 강조
- 현상학적 입장에서 개인의 자기인식능력과 알아차림을 강조
- '지금-여기'에서의 체험을 강조할 뿐만 아니라 과거를 현재 속으로 가져와 생동감 있게 다룰 수 있는 다양한 기법 제시
- 내담자의 치료적 학습이 이루어지도록 다양한 실험적 방법을 창의적으로 사용

2) 한계 및 비판

- 이론적 체계성과 정교함 부족
- 임상진단체계를 간과함으로써 체계적인 연구와 치료활동 등한시
- 장기치료에 소홀

행동치료 / 5주차 1차시

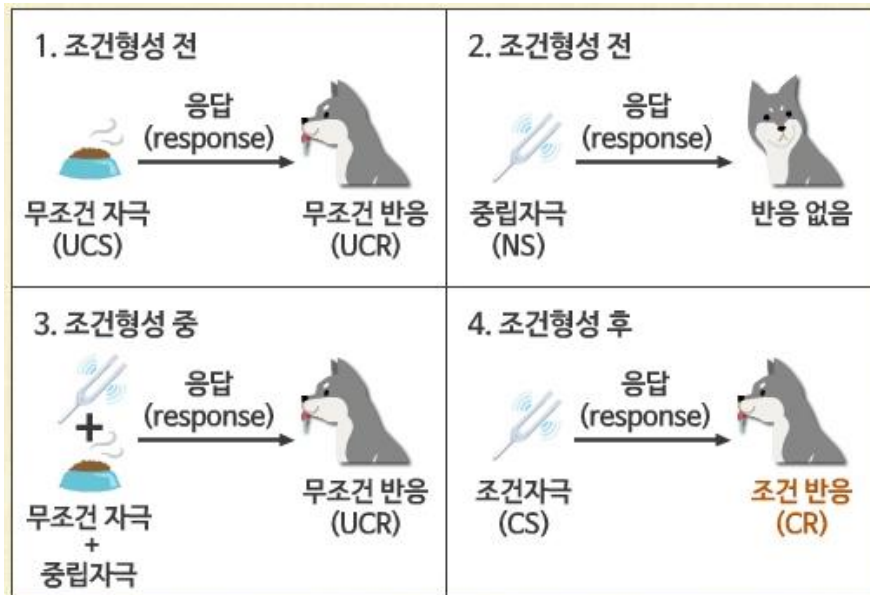
1. 행동치료의 이해

- 정신분석 이론의 비과학성을 비판하면서 엄격한 실증적 과학주의에 근거하여 발전한 심리학적 입장을 의미
 - 행동주의 심리학에서는 성격을 내면적인 심리적 구조나 역동으로 설명하기보다 외부 환경에 의해 강화된 행동 패턴으로 간주
 - 인간의 행동은 내면적인 요인보다 환경적 요인, 유전보다 후천적 경험, 특정 성향을 지니고 타고나기보다 백지상태라는 입장
 - 인간의 개인차를 관찰과 측정을 할 수 있는 외현적 행동에 초점
- 1) 개인의 성격특성은 관찰될 수 있는 구체적인 행동으로 분석되어 이해될 수 있음
- 개인의 성격은 내면적 특성에 의해 규정되기보다 개인의 다양한 상황에서 반복적으로 나타내는 독특한 행동 패턴임
 - 인간의 행동을 설명하고 예측하는 데에 있어 내면적 조직체로 가정되는 성격, 자아, 특질 등의 개념은 불필요
- 2) 인간이 나타내는 대부분의 행동은 후천적 학습에 의한 것
- 환경 결정론 : 개인의 행동 패턴은 환경과의 상호작용 속에서 후천적 경험을 통해 학습된 것
 - 인간은 '빈서판'과 같은 존재로 잠재적인 가능성을 지니고 태어날 뿐 선천적으로 결정된 행동 패턴은 없음
- 3) 인간의 모든 행동은 학습에 의해 습득
- 새로운 행동을 습득시키고 부적응 행동을 제거하는 학습의 원리
- 4) 행동의 변화도 학습의 원리를 응용하여 성공적으로 이루어질 수 있음
- 부적응적인 문제행동을 제거하거나 긍정적인 행동을 학습함으로써 내담자의 부적응 문제를 치료할 수 있음
 - 내담자의 과거 경험이나 무의식과 같은 내면적 요소의 변화보다 현재의 행동 변화에 초점
- 5) 사회적 학습이론
- 사회적 상황에서 나타나는 다양하고 복잡한 행동의 습득을 설명하기 위한 이론
 - 모델링 : 다른 사람의 행동을 그대로 따라 하는 모방학습
 - 대리학습 : 다른 사람들이 새로운 행동을 시도할 때 어떤 결과가 나타나는지를 관찰함으로써

자신이 그러한 행동을 했을 경우 초래될 결과를 예상하는 학습 방법

- 관찰학습 : 사회적 상황에서 다른 사람의 행동을 관찰해 두었다가 유사한 행동을 나타내는 학습 과정

6) 고전적 조건형성



7) 조작적 조건형성

- 반응에 뒤따르는 결과에 따라 행동에 변화를 일으키는 학습 과정



- 강화(reinforcement) / 강화물(reinforcer)
: 반응 뒤에 뒤따르는 강화물로 인해 반응의 확률이 증가하는 것
강화물(reinforcer) 반응 후에 그것이 제시되었을 때 그 반응의 확률을 증가시키는 사상
- 처벌 • 처벌(punishment) : 혐오적이거나 고통스러운 결과를 가져오는 반응은 그 빈도가 감소
- 행동 조성(shaping) : 강화물을 이용하여 점진적으로 원하는 반응을 만들어 내는 과정

2. 행동치료의 목표 및 원리

1) 치료 목표

- 치료 목표는 행동치료에서 매우 중요
- 행동치료의 일반적 목표는 개인의 선택을 증가시키고 새로운 학습 조건을 창출
- 평가와 치료는 동시에 이루어지지만, 변화의 결과가 되는 목표 행동을 결정하기 위해 치료에 앞서서 평가가 이루어짐
- 현대 행동치료는 치료에 관한 결정에서 내담자의 능동적인 역할 강조
- 상담자는 내담자가 평가할 수 있는 목표를 짜도록 도움
- 목표는 분명하고 구체적이며 내담자와 상담자가 합의한 것

2) 치료의 원리

- 상담사는 기능 평가(혹은 행동 분석)를 통해 선행 사건과 문제행동의 차원, 문제행동의 결과에 대한 정보를 체계적으로 모아 문제행동을 유지하는 상황 확인
- 사건-행동-결과(ABC model) : A(선행 사건), B(행동), C(결과)
- 선행 사건은 어떤 행동을 유발. 결과는 행동을 늘리거나 줄여서 어떻게든 행동을 유지하는 사상

3. 행동치료기법의 적용

- 소거 : 부적응적인 행동이 반복되어 나타나도록 강화하는 요인을 제거
- 혐오적 조건형성 : 바람직하지 않은 행동을 제거하는 매우 효과적인 행동변화 기법
- 노출법 : 내담자가 두려워하는 자극이나 상황에 반복적으로 노출시켜 직면하게 함으로써 그러한 자극 상황에 대한 불안을 감소
- 홍수법 : 실제 혹은 상상적으로 유발된 불안 자극에 오랫동안 노출시키는 것
- 사회기술 훈련 : 개인이 다양한 사회적 상황에서 다른 사람들과 효과적으로 교류하는 능력을 다루는 폭넓은 범주
- 사회적 학습 방법도 긍정적 행동을 학습시키는 데 효과적

4. 행동치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 접근의 구체성은 내담자가 불명확한 목표를 구체적 행동계획으로 바꾸도록 도와주며 상담사와 내담자가 이 계획에 집중하도록 함
- 다양하고 구체적인 기법이 존재
- 치료의 성과에 관한 연구와 평가 강조

2) 한계 및 비판

- 행동치료는 행동을 변화시킬 수 있어도 감정은 변화시키지 못함
- 통찰을 제공하지 않음
- 원인보다 증상을 다룸
- 상담사가 통제하고 사회적 영향력을 가짐

인지치료 / 5주차 2차시

1. 인지치료의 이해

- 정신분석과 행동주의가 심리학계의 양대 산맥으로 군림하던 1950년대에 등장
- 인간 행동을 설명하는 데 있어 인간의 사고 과정에 대한 이해가 핵심적이라는 입장
- 인간의 인지적 측면을 설명하고 측정하는 이론과 연구 방법이 발전하면서 인지 혁명 발생
- 인지주의적 관점에서 보면, 성격의 핵심은 개인이 자신과 세상을 심리적으로 구성하는 방식에 있음
- 인간은 객관적 현실에 반응하는 수동적 존재가 아니라 스스로 의미를 부여하여 주관적 현실을 구성하고 그에 근거하여 행동하는 능동적 존재

1) Kelly의 개인적 구성개념 이론

- 인간은 세상을 나름대로 구성하는 존재
- 인간은 자신의 생활하는 환경을 파악하기 위한 인지적 구성개념을 창조하고 그러한 구성개념에 근거하여 생활사건을 해석하고 예측
- 모든 사람은 과학자처럼 각자 독특한 구성개념을 지니며 그 바탕 위에서 사건을 이해하고 예견하며 삶을 영위
- 개인의 성격을 파악하기 위해 그가 세상을 해석하고 조직화하는 독특한 인지 체계인 개인적 구성개념을 이해하는 것이 중요
- 구성개념 : 개인이 세상을 해석하고 평가하는 주요한 차원이자 인식 특
- 세계 인식의 공통된 기초를 공유하기 때문에 서로 의사소통을 할 수 있지만, 개인마다 독특한 구성개념을 지니고 살아감
- 구성개념의 적응성은 그것이 상황을 얼마나 잘 설명하고 미래를 예측하는 데 유용한가에 달려 있음
- 적응적인 사람은 자신의 구성개념을 그들의 경험 속에서 직면하게 되는 새로운 정보에 알맞도록 지속적으로 개정하고 새롭게 함
- 구성적 대안 : 세상을 구성하는 방식에는 다양한 대안이 존재하며 개인은 자신의 구성 방식을 다른 대안으로 얼마든지 변화시킬 수 있음. 인간은 다양한 상황과 사람들을 접촉하면서 그것에 부합하는 구성개념을 발달시킴. 개인을 새로운 사람과 상황에 직면하면 구성개념의 목록을 확장하거나 수정하면서 삶을 영위

2) Beck의 인지이론

(1) 자동적 사고

- 우울증 내담자는 실패, 상실, 좌절과 같은 주제와 관련된 부정적 사고가 많음

- 부정적 생각과 심상은 다양한 생활사건에 의해 거의 자동적으로 촉발되는 경향. 이를 자동적 사고라고 명명
- 자동적 사고는 매우 빠르게 의식 속을 지나기 때문에 명료하게 인식되지 않으며 단지 그 결과로 뒤따르는 감정만이 인식됨
- 사람들은 자동적 사고의 존재를 인식하기 힘들 뿐만 아니라 그 타당성을 검토하지 못한 채 사실인 것처럼 무비판적으로 받아들이게 됨
- 자동적 사고는 주의를 기울이거나 약간의 훈련을 받게 되면 인식됨

(2) 인지적 오류

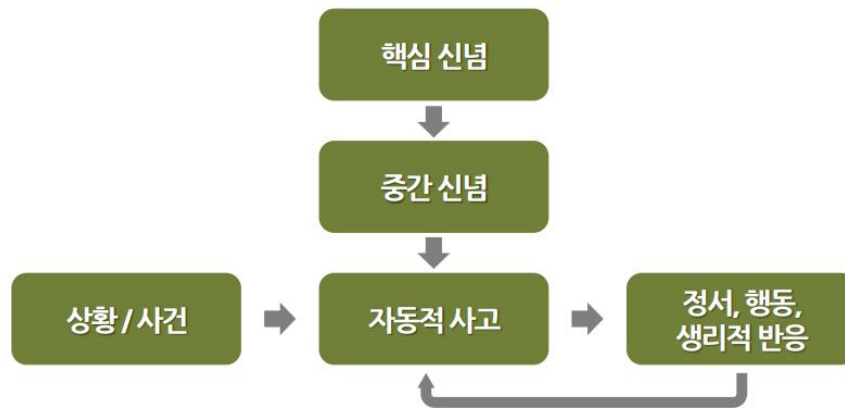
- 정서장애를 가진 내담자들은 객관적 현실을 자기 비하의 방향으로 왜곡하는 특징적인 '논리적 오류'를 범하는 경향
- 흑백논리적 사고 : 생활사건의 의미를 이분법적인 범주 중의 하나로 해석(예> 성공 또는 실패)
- 과잉일반화 : 특수한 상황의 경험으로부터 일반적인 결론을 내리고 무관한 상황에서도 그 결론을 적용(예> 사람들은 항상 나를 싫어해)
- 정신적 여과(선택적 추상화) : 특정한 사건과 관련된 일부의 정보만 선택적으로 받아들여 그것이 마치 전체를 의미하는 것으로 잘못 해석(예> 소수의 부정적 피드백에 집중)
- 의미확대와 의미축소 : 어떤 사건의 의미나 중요성을 실제보다 지나치게 확대하거나 축소하는 오류. 우울한 사람들은 부정적인 일의 의미는 크게 확대하고 긍정적인 일의 의미는 축소하는 경향
- 개인화 : 자신과 무관한 사건을 자신과 관련된 것으로 잘못 해석
- 잘못된 명명 : 사람의 특성이나 행위를 기술할 때 과장되거나 부적절한 명칭을 사용(예> 나는 실패자야)

(3) 역기능적 인지도식과 신념

- 인지도식 : 과거 경험을 추상화한 기억체계로써 생활 속에서 경험하는 사건들의 다양한 정보를 선택하고 사건의 의미를 해석하며 미래의 결과를 예상하는 인지적 구조
- 우울한 사람들은 생활사건의 의미를 부정적으로 해석하게 하는 역기능적 인지도식을 지님
- 역기능적 신념 또는 기저가정 : 우울한 사람들이 부정적인 사고를 하게 되는 이유는 당위적이고 완벽주의적인 완고한 신념을 가지고 있기 때문

(4) 핵심신념과 중간신념

- Judith Beck은 정신병리에 개입하는 역기능적 신념을 핵심신념과 중간신념으로 구분
- 핵심신념은 어린 시절에 중요한 인물과 상호작용하면서 형성되는 것으로서 가장 근원적이며 깊은 수준의 믿음
- 중간신념은 핵심신념과 자동적 사고를 매개하는 것으로서 핵심신념에 의해 영향받음. 중간신념은 삶에 대한 태도, 규범, 가정으로 구분되어 있으며 잘 인식되지 못함



2. 인지치료의 목표 및 원리

1) 정신병리 이론

- 개인이 지닌 매우 특수한 역기능적 인지도식이 활성화되면 정신병리 상태가 유발
- 잘못된 사고, 적절하지 않거나 올바르지 않은 정보에 근거한 그릇된 추론, 환상과 현실의 구분 실패 등과 같은 과정에서 심리적 문제 발생
- 역기능적 인지도식이 생활사건에 의해 활성화되는 빈도나 범위에 따라 일시적 증후군과 성격장애로 구분



- 개인이 지니는 자동적 사고의 내용에 따라 유발되는 부적응적 증상 상이
- 정신장애의 유형은 자동적 사고의 주제와 밀접한 관련
- 성격장애는 정보처리 과정에 강력한 영향을 미치는 인지도식과 신념 체계의 특성에 기인

정신장애	자동적 사고의 주제
우울증	자기 자신, 미래, 환경에 대한 부정적 견해
경조증	자기 자신, 미래, 환경에 대한 긍정적 견해
불안증	신체적 또는 심리적 위협과 위험
공황장애	신체나 정신적 경험에 대한 파국적 해석
공포증	구체적이고 회피 가능한 상황에서의 위협
전환장애	운동기관 또는 감각적 이상에 대한 믿음
강박증	안전에 대한 반복적 경고 및 회의
자살	희망 상실, 절망
섭식장애	살찌는 것에 대한 공포
건강염려증	심각한 의학적 질병에 걸려 있다는 믿음

2) 치료의 목표

- 내담자가 효과적으로 기능하고 적응하도록 돕기 위해 잘못된 정보처리 수정
- 내담자 자신과 세상에 대한 왜곡된 인지를 인식하고 수정하도록 도움
- 역기능적 신념을 좀 더 현실적이고 유연한 신념으로 변화시키고 적응적인 행동을 증진하기 위해 다양한 인지적 기법과 행동적 기법 사용
- 왜곡된 인지를 수정함으로써 내담자의 심리적 고통과 증상을 완화할 뿐만 아니라 내담자가 현실적으로 문제에 대해 효과적인 문제해결자가 되도록 도움
- 내담자로 하여금 자신의 사고와 신념을 자각하고 그것을 타당성과 효용성의 관점에서 따져본 뒤에 스스로 선택하여 자신의 생각을 변화시키는 기술을 가르침
- 인지치료의 기술을 내담자가 다양한 상황에서 활용하도록 촉진함으로써 증상 완화와 문제해결은 물론 치료의 종결 이후에도 재발 방지를 도모

3) 치료의 원리

- 정신병리를 유발하는 왜곡된 인지 수정하여 재구성
- 심리교육적 모델에 근거하여 내담자 스스로 자신의 부정적 사고를 인식하여 변화시키는 역량을 키우는데 주력

3. 인지치료기법의 적용

- 비교적 자각하기 쉽고 수정하기 쉬운 자동적 사고에서 시작하여 점차 깊은 수준의 인지를 수정해나감
 - (1) 자신의 부정적이고 자동적인 사고를 관찰하여 파악하기
 - (2) 인지, 정서, 행동 간의 관련성을 인식하기

- (3) 자동적 사고의 지지 증거와 반대 증거를 검토하기
- (4) 편향적인 인지를 좀 더 현실적인 대안적 사고로 대체하기
- (5) 경험을 왜곡하는 취약성으로 작용하는 역기능적 신념을 파악하고 수정하기
- 인지치료의 치료 지침으로 인지적 모델에 근거한 사례 개념화, 협동적 경험주의, 소크라테스식 대화, 인도된 발견이 있음

4. 인지치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 비교적 단시간에 우울과 불안을 다루는 데 효과적임
- 내담자가 자신의 세상을 보는 방식을 이해하는 방법으로서 자세한 사례 개념화를 개발하는 것을 중요시 함

2) 한계 및 비판

- 긍정적 사고의 힘을 지나치게 강조
- 피상적이고 극단적으로 단순
- 과거의 중요성을 부정하고 지나치게 기법에 의존
- 치료관계를 제대로 활용하지 못함
- 감정의 역할 부정

합리적 정서행동치료 / 6주차 1차시

1. 합리적 정서행동치료의 이해

1) 인간 본성에 대한 관점

- 인간은 외부의 조건에 의해서라기보다 스스로가 자신의 정서적 혼란을 일으킬 여건을 만든다. 특히 정서적 혼란을 가져오는 신념을 스스로 창출하고, 그 신념에 따라 정서적으로 혼란하게 되는 경향성이 있음
- 인간은 사실을 왜곡하고 정서적 혼란을 일으키게 하는 생득적, 문화적 경향성을 가짐
- 인간은 동시에 사고하고, 느끼고 행동하며, 이들은 상호 영향
- 인간은 사고, 정서와 행동의 과정을 바꿀 수 있는 능력을 소유. 즉, 인간은 자신이 늘 사용하던 행동유형과는 다른 형태를 선택할 수 있으며, 더 편안하게 살아갈 수 있도록 스스로 훈련 가능
- 인간은 자기와 대화하고(self-talking), 자기를 평가하며(self-evaluating), 자기를 유지하는(self-sustaining) 존재

2) 인간의 정서에 대한 관점

- 사고의 결과로 정서가 나타남
- 합리적인 생각을 가지면, 더 적절한 정서와 행동이 이루어짐
- 정서를 적절한 정서와 부적절한 정서로 구분

(1) 적절한 정서

- '~하기를 좋아한다', '~하기를 바란다', '~하기를 더 좋아한다'라는 생각들과 관련된 정서
- 긍정적 정서와 부정적 정서 존재. 긍정적 정서는 좋아하거나 원하는 것이 이루어졌을 때 생기는 행복, 호기심, 사랑 등과 같은 정서. 부정적 정서는 좋아하거나 원하는 것을 얻지 못했을 때 생기는 불쾌감, 걱정, 초조 등과 같은 정서
- 부정적 정서가 적절한 정서인 근거는 상황이 악화되는 것을 방지하며, 바라는 바를 더 잘 성취할 수 있도록 하고, 바라지 않는 것을 감소시킬 수 있도록 주의하고 조심하게 하기 때문

(2) 부적절한 정서

- '반드시 ~을 해야한다', '반드시 ~이어야 한다', '절대로 해서는 안 된다.'라는 식의 절대적인 명령이나 요구와 관련된 정서
- 좋아하거나 원하는 일이 이루어지지 못할 때 느끼는 불안, 모욕감, 우울감, 절망감, 적대감, 무가치감 등과 같은 격렬한 부정적 감정
- 이 정서는 자기 패배적인 생각, 즉 '나는 ~ 때문에 쓸모가 없는 사람이다'. '~은 끔찍하고 두려운 일이다', '~을 참고 견딜 수가 없다' 등과 같은 생각과 관련된 정서
- 이러한 정서는 어려운 상황을 변화시키는 데 도움이 되지 않으며, 상황을 더욱 악화시키고 목표 달성에 방해가 됨

- 부적절한 정서에 선행하는 비합리적 신념이 존재

(3) 비합리적 신념

- 모든 사람으로부터 항상 사랑과 인정을 받아야 함
- 모든 면에서 반드시 유능하고 성취적이어야 함
- 악하고 야비하며 나쁜 사람은 반드시 준엄한 저주와 처벌을 받아야 함
- 바라는 대로 되지 않는 것은 끔찍한 파멸임
- 인간의 불행은 외부 환경 때문이며, 인간의 힘으로 그것을 통제하는 것은 불가능
- 위험하거나 두려운 일이 일어날 가능성은 언제나 존재
- 난관과 책임을 직면하는 것보다 회피하는 것이 쉬움
- 의존할만한 강한 누군가가 필요
- 과거의 경험과 사건에 의해 현재 행동과 운명이 결정되며, 과거의 영향에서 벗어나는 것은 불가능
- 주변 사람들이 겪는 어려움과 관련한 영향을 피하는 것은 불가능
- 모든 문제에는 적확하고 완벽한 해결책이 반드시 존재하며, 그것을 찾지 못하면 파멸

3) 성격에 대한 관점

(1) 성격의 생득적 성향

- 인간은 생득적으로 자기실현의 경향과 자기 파괴적 경향성을 가짐
- 자기 파괴적인 생득적 경향의 내용
 - ① 나쁜 결과를 가져오더라도 지금까지의 생각이나 행동을 쉽게 바꾸지 못하는 경향성
 - ② 바람직하지 못한 목표임에도 이에 대한 욕망을 버리지 못하고, 때로 극단적으로 집착
 - ③ 비효과적인 습관을 버리지 못하는 경향성
 - ④ 어렸을 때 가지게 된 편견이나 신념에 집착하는 경향성
 - ⑤ 주의만 기울여도 되는 일에 지나치게 경계하고 조심하는 경향성
 - ⑥ 다른 사람보다 우월하고 어떤 면에서는 완벽하다는 것을 입증하려는 욕구
 - ⑦ 자신의 생각이 잘못된 근거에서 비롯되었다는 것이 입증되었을 때, 검토 과정 없이 그와 반대되는 견해로 쉽게 넘어가는 경향
 - ⑧ 더 좋은 방법이 있음에도 상투적인 습관대로 하려는 경향성
 - ⑨ 이롭지 못한 분명한 증거가 있음에도, 그러한 사실을 자주 잊어버리는 경향성
 - ⑩ 지나치게 낙관적인 경향성
 - ⑪ 열심히 노력하거나 훈련하기보다 '너무 힘들다'라는 구실을 대며 게으름을 피우고 미루는 경향성
 - ⑫ 자신을 정당하게 대해주는 것을 당연하게 생각해 요구하며, 때로는 이에 대해 집요하게 생각하는 경향성
 - ⑬ 어리석은 행동에 대해 과도한 자기 비난을 하는 경향
 - ⑭ 과거에 일어났거나 미래에 일어나 일에 대해 지나치게 일반화하려는 경향성

⑮ 당황하게 되었을 때 정신 신체적으로 쉽게 영향받는 경향성

2. 합리적 정서행동치료의 목표 및 원리

1) 치료목표

- 문제행동의 배후에 있는 핵심적인 자기 패배적 신념을 줄이고 삶에 대해 더 현실적이고 합리적인 가치관을 갖도록 함
- 자기 관심 : 타인을 위해 자신을 자학하고 희생시키지 않으며, 비교적 자유로운 상태에서 자신에게 관심
- 사회적 관심
- 자기 지향 : 자기 삶에 책임을 느끼며 문제를 독립적으로 해결
- 관용
- 융통성
- 불확실성의 수용
- 창조적 일에 대한 실행
- 과학적 사고 : 객관적이고 이성적
- 자기수용 : 살아있는 것 자체에 기쁨을 느끼며 삶을 즐기고 행복과 기쁨을 창조할 수 있는 능력이 자신에게 있다는 것을 믿음
- 모험 실행
- 장기적 쾌락
- 반유토피아주의 : 얻고자 하는 것을 다 얻을 수 없으며, 모든 고난을 완전히 회피할 수 없다는 사실 인식
- 정서적 혼란에 대한 자기책임

2) 치료의 원리

(1) 상담자-치료자 관계

- 권위적이면서 친절한 선생님
- 지나친 따뜻함을 표현하지 않도록 절제하는 경향

(2) A-B-C-D-E 이론

- 선행사건(Activating Event) : 정서적 혼란을 초래하는 사건
- 신념 체계(Belief System) : 어떤 사건이나 행위 등과 같은 환경적 자극에 대해 개인이 갖는 태도 또는 사고방식. 신념 체계에는 합리적 신념(Rational Belief, rB)과 비합리적 신념(Irrational Belief, iB)
- 결과(Consequence) : 선행사건에 대한 비합리적 태도 또는 사고방식을 가지고 그 사건을 해석함으로써 느끼게 되는 정서적 결과
- 논박(Dispute) : 비합리적 신념이나 사고에 대해 도전. 상담자가 논리적인 원리를 제시하여

내담자의 그릇된 신념들을 논박하여 내담자가 자기 패배적인 생각을 포기하도록 도움

- 효과(Effect) : 내담자의 비합리적인 신념을 철저히 논박함으로써 합리적인 신념으로 대치한 다음에 느끼게 되는 자기 수용적인 태도와 긍정적인 감정의 결과를 지칭

3. 합리적 정서행동 치료기법의 적용

1) 인지적 기법

- 합리적인 자기 진술 카드를 사용
- 숙제 부여
- 어의학적 용법 사용
예) 내담자 : 나는 00를 할 수 없어요 -> 상담자 : 당신은 00를 하지 않는 것이군요
- 유추의 기법

2) 정서적 기법

- 유머 사용
- 상담자의 자기 경험 공개
- 비유나 우스꽝스러운 노래 사용

3) 행동적 기법

- 행동적 숙제 부여
- 내담자가 실생활에서 모험을 하고 새로운 경험을 함으로써 비효과적인 습관을 포기하도록 함
- 만성적인 불안감을 경험하는 상황에 처하게 한 다음에 그 불안한 감정을 장시간 경험해 보도록 권장
- 미루는 습관에 대해서는 당장 일을 착수하도록 유도
- 상과 벌 사용
- 고정 역할 치료 : 이미 합리적인 인간이 된 것처럼 연출

4) 삼가는 기법

- 내담자가 더 의존적으로 되게 하는 기법
- 내담자가 현혹되게 하는 기법
- 비효과적인 기법(예 : 정신 분석적 기법)
- 단시일 내에 호전하게 하는 기법
- 선행사건을 변화시키고자 하는 기법

4. 합리적 정서행동치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 인간의 부적응에 신념 체제와 사고방식이 영향을 미친다는 점을 체계적으로 제시
- 상담 과정을 통해 얻은 통찰을 실천하는 것의 중요성 강조. 행동적 측면을 치료과정의 결정적인 부분으로 간주
- 내담자 스스로 능동적으로 변화하는 방법 가르칠 수 있음

2) 한계 및 비판

- 지적 수준이 낮거나 현실감 없는 내담자, 사고가 경직된 내담자에게는 적용 어려움
- 지시적이고 교육적인 접근법은 상담자의 가치나 철학을 내담자에게 강요할 수 있음
- 논박하는 과정에서 내담자에게 불쾌한 감정을 유발할 수 있음

현실치료 / 6주차 2차시

1. 현실치료의 이해

- 내담자의 현재 행동에 초점을 두고 그 행동이 내담자가 원하는 것을 얻을 수 있는지를 분석하는 상담기법
- 행동 특히 행동과 사고를 선택하는 책임이 우리에게 있다는 것을 강조
- 인간의 모든 행동은 유전인자 속에 뿌리하고 있는 인간의 기본욕구를 만족시키기 위한 것

1) 소속, 힘, 자유, 즐거운, 생존에 대한 욕구

- 기본적 욕구에 소속, 힘, 자유, 즐거움, 생존에 대한 욕구가 있음
 - 소속욕구 : 사랑하고 나누고 협력하고자 하는 속성
 - 힘에 대한 욕구 : 경쟁하고 성취하고 중요한 존재이고 싶어하는 속성
 - 자유에 대한 욕구 : 이동하고 선택하는 것을 마음대로 하고 싶어하는 속성
 - 즐거움에 대한 욕구 : 많은 새로운 것을 배우고 놀이를 통해 즐기고자 하는 속성
 - 생존에 대한 욕구 : 살고자 하고 생식을 통해 자기 확장을 하고자 하는 속성
- 인간의 기본적 욕구 중 하나 혹은 그 이상의 욕구를 만족시키려고 항상 노력
- 자신을 통제하고 주변 환경 세계를 통제하기 위한 최선의 선택을 하려고 시도

2) 인간 행동관

- 자신과 주위 사람들이 자신을 사랑하고 가치있게 여기면 성공적인 정체감 발달
- 개인의 바램과 질적인 세계와 지각 세계가 불일치 하는 경우 갈등이 생기며 문제행동을 선택하게 됨
- 전통적인 상담이론과 달리 내담자 자신이 선택한 행동과 결과에 책임을 지도록 함

3) 현실치료의 특징

- 신경증적 행동, 정신병적 행동, 신체화, 중독 모두 욕구 충족을 위한 최선의 선택으로 간주
- 과거나 미래보다 현실을 중요시
- 전이 및 역전이의 필요성 인정하지 않음
- 내담자의 무의식과 꿈의 해석보다 의식 세계에서 현실지각을 중요시
- 정신분석치료와의 차이점
 - 내담자가 정신질환을 앓고 있다는 개념을 수용하지 않음
 - 내담자의 과거나 미래보다 현재에 초점
 - 상담자는 초연한 전이적 대상이 아니라 따뜻한 인간적인 위치에서 내담자와 친밀한 관계 맺음

- 무의식적인 행동의 원인을 배제하며 행동의 진단보다 욕구와 행동 선택을 평가하는 것에 초점
- 행동의 도덕성과 책임성을 강조
- 통찰을 통한 변화보다 적극적이고 효과적인 욕구 충족을 위한 새로운 방법을 교육하는 것을 강조

2. 현실치료의 목표 및 원리

1) 치료목표

- 내담자가 자신의 삶을 좀 더 효과적으로 통제할 수 있도록 도움
- 자기 욕구 충족을 위한 행동의 효과성을 자기평가 하면서 욕구를 충족하는 합당하고 새로운 방법을 찾도록 상담자가 교육적으로 도움
- 사생활의 효율적인 통제를 향상하기 위해 사용할 뿐만 아니라, 교육 현장, 부모 역할, 지도나 인사관리 방법 등 여타의 생활 장면에서 자신의 욕구를 만족시키는 방법을 배우고 책임을 지게 할 수 있도록 도움

2) 치료원리

(1) 상담환경 가꾸기

- 친근감을 가지고 내담자의 이야기를 경청하기
- 내담자의 과거사는 현재 상황을 설명하는 데 도움이 되지 않는 한 이야기하지 않음
- 내담자의 느낌이나 생리현상을 내담자가 통제할 수 있는 현재의 생각과 활동 요소를 연결하게 함
- 무책임한 행동에 대한 변명 허용하지 않음

(2) 행동 변화를 위한 치료원리

- ① 욕구, 바람, 지각 탐색하기 : 내담자의 바람, 욕구, 지각을 탐색하여 내담자가 그것을 상담자와 나누기 위해 진지하게 상담에 임할 수 있도록 내담자로부터 약속받아내는 단계
- ② 전(全)행동 탐색하기
 - 전행동은 활동하기, 생각하기, 느끼기와 같은 생기 기능의 네 가지 요소로 구성
 - 전행동 탐색하기는 상담자가 상담 초기에 내담자에게 상담의 전반적인 방향, 즉 내담자가 어디로 가고 있는가를 탐색하도록 도와주는 절차
 - 내담자가 통제할 수 있는 활동을 스스로 탐색할 것을 강조하는데, 이는 활동 요소를 바꿈으로써 우울, 격분, 외로움 등의 느낌 요소와 생리기능까지 변화시킬 수 있음
 - “당신은 무엇을 하고 있습니까?”라는 질문 사용
 - “당신은”은 자기 행동을 환경조건 혹은 남의 탓으로 돌리거나 변명하려는 활동을 중단시키는데 효과
 - “무엇”은 내담자의 내면세계로 들어가 내담자의 행동 효과성을 파악하고, 자기통제가 가능한

영역과 그렇지 않은 영역을 확인하는 기회를 제공

- “하고”는 내담자의 활동 요소에 초점. 내담자가 원하는 것과 그것을 얻기 위한 행동에 대해 자기평가를 할 수 있도록 도움
- “있습니까”는 내담자가 현재의 행동에 초점을 맞출 수 있도록 도움

③ 행동과 계획에 대한 자기평가

- 개인의 행동과 욕구와의 관계를 점검하기
- 당신의 지금의 행동이 당신에게 도움이 됩니까?
- 당신이 지금하고 있는 것은 당신이 진정으로 원하는 것을 얻는 데 도움이 됩니까?
- 당신이 행동하는 것이 규칙에 어긋납니까?
: 규칙을 위반하는 내담자의 행동에 대해 자신의 활동 요소를 관찰하는 데 도움을 줌
- 당신이 원하는 것은 현실적이거나 실현할 수 있는 것입니까?
- 그런 식으로 보는 것이 당신에게 도움이 됩니까?
- 상담의 진행과 당신 인생의 변화에 대해 어떻게 약속하시겠습니까?
- 도움이 되는 계획입니까?

④ 계획하기

- 계획과 실행과정으로서 긍정적인 행동 계획과, 그 계획에 대한 약속, 과정에 대한 마무리 제안하는 단계
- 내담자들은 예전에 계획하기에서 실패한 경험으로 인해 새로운 계획을 세우고 실행하는데, 두려움을 느낄 수 있음
- 상담자는 내담자의 가능성을 신뢰하며, 용기를 북돋워 주고 희망을 불어넣어 줌
- 내담자의 진정한 바람과 욕구를 충족시킬 수 있는 계획 수립을 도울 필요
- 단순하고 현실적이고 실현가능한 계획을 세우도록 도움
- 어떤 행위를 중지시키는 것이 아니고 특정한 행위를 하도록 권장하는 것이 효과적
- 내담자의 힘이나 성취욕구에 초점을 맞추는 계획 수립이 필요
- 구체적인 계획은 계획하기의 마지막 단계에서 필요. “무엇을 할 것인가? 어디서 할 것인가? 누구와 할 것인가? 얼마나 자주 할 것인가?” 등의 질문을 통해 내담자가 능동적으로 효과적인 계획을 수립할 수 있도록 도움
- 측정할 수 있고 반복적인 계획 수립이 중요
- 평가를 통해 내담자가 자신의 욕구와 바람을 충족시킬 수 있도록 계획인 짜였는지 검토할 수 있음. 이때 “그 계획이 어떤 욕구와 바람을 충족시킬 수 있는가?”라는 질문이 효과적
- 계획한 것을 이행하도록 확고한 약속

⑤ 계획에 대해 약속하기

- 내담자 자신이 계획을 실행하겠다고 약속을 재확인하는 단계
- “당신은 정말 이 계획을 실천하시겠습니까?” “지금 당신이 계획해서 하려는 일을 다시 말씀해주시겠습니까?”, “하겠다고 한대로 여기 용지에 사인해 주시겠습니까?” 등의 질문이 효과적

⑥ 역설적인 방법을 적용하기

- 이 도구는 가끔 유용하지만 자주 사용하지 않는 것을 원함

예: 내담자가 신체적인 아픔을 계속 호소할 경우, 상담자는 “정말 당신은 안 아픈 곳이 없는 대단한 병자이군요”

3. 현실치료기법의 적용

1) 주의를 기울이는 행동

- 얼굴 표정(눈맞춤, 자연스럽게 바라보기, 진지한 관심 드러내기), 수용적 자세, 언어적 행동(경청하는 태도로 내담자의 말을 뒤따르고 반영하기), 비언어적 행동(목소리의 억양과 같은 내담자의 표현 방식에 대해 주의 기울이기), 바꾸어 말하기(내담자의 의견을 다른 말로 표현하기) 등

2) AB 법칙을 실시하기

- Always Be Calm & Courteous(항상 침착하고 예의바를 것) : 상담 초기에 상담자와 내담자와의 우호적인 관계를 형성하는 것은 효과적인 상담을 위해 중요하며, 상담자는 침착하고 동요되지 않는 모습을 보이면서 친절하고 예의가 바를 필요
- Always Be Determined(항상 신념을 지닐 것) : 내담자에게 더 효율적이고 도움이 되는 행동 선택이 가능하다는 것과 내담자가 효과적인 행동 선택을 함으로써 좀 더 보람된 삶을 살아갈 수 있다는 것에 대한 확신을 가질 필요
- Always Be Enthusiastic(항상 열정적일 것) : 내담자를 만날 때 유쾌하고 긍정적인 상태 유지할 필요. 상담자가 개인적 고통으로 지쳐있으면 상담자로서의 힘이 감소하기 때문에 상담의 효율성인 낮아짐. 상담자 자신도 상담에 임할 때 자신의 욕구와 바램을 충족시킬 수 있도록 유념할 필요
- Always Be Firm(항상 확고할 것) : 상담자의 일관된 침착하고 당당한 태도, 합리적인 법칙의 실천, 상담자와 내담자 사이의 결정적이고도 확고한 계획 찾기가 필요
- Always Be Genuine(항상 진실하기) : 상담자의 정직하고 솔직한 태도는 개방적이고 솔직할 때 정신적으로 건강해지고 삶이 향상된다는 사실을 은연중에 내담자에게 교육할 수 있음

3) 판단 보류하기

- 내담자의 어떠한 행동도 내담자 자신의 욕구를 충족시키려는 최선의 선택으로 이해할 필요

4) 예상하지 않은 행동하기

- 내담자가 그의 또 다른 내적 바램을 보게 하며 고통을 제쳐주도록 도움

5) 건전한 유머 사용하기

6) 자기답게 상담하기

- 진취적, 부드러움, 조용함 등 가장 자기답게 상담하기

7) 개방하기

- 상담자의 진지하고도 개방적인 태도는 내담자가 자기의 질적 세계로 상담자를 들어올 수 있게 할 뿐만 아니라 상담자에 대한 내담자의 신뢰 증진. 때로는 내담자의 자기 개방 촉진. 그러나 지나친 개방은 삼가기

8) 은유적 표현에 집중하기

- 내담자의 표면적인 표현 이면에 진심을 이해하기

9) 주제에 귀 기울이기

- 상담 주제로부터 내담자가 이탈되지 않게 효과적으로 방향 설정

10) 요약하기와 초점 맞추기

- 내담자의 이야기를 요약하여 진실로 원하는 것에 초점을 맞출 수 있도록 도움. 초점 맞추기는 한가지 또는 그 이상의 요점들, 주제, 평가적인 사고 등을 강조하는 것을 의미

11) 결과를 허용하거나 떠맡기기

- 내담자가 바람직하지 않은 행동에 대해 책임지게 하는 기술

12) 침묵 허용하기

- 내담자가 침묵하는 동안 자신의 생각을 모으고 자신의 내면적인 심리적 사진과 지각을 명료하게 하고 문제 해결을 위한 계획을 세울 수 있도록 돕고 내담자에게 책임을 지게 하는 것

4. 현실치료의 공헌, 한계 및 비판

1) 공헌

- 개인의 책임을 강조하여 내담자가 선택하고 자신의 삶을 통제하는 힘이 있음을 인식할 수 있게 함
- 현재를 강조하며, 긍정적 변화를 위해 지금 할 수 있는 일에 집중
- 명확하고 달성할 수 있는 목표를 설정하여 동기부여 및 목적의식을 갖게 할 수 있음
- 실용적이고 실행할 수 있는 전략 사용

2) 한계 및 비판

- 깊은 정서적, 심리적, 역사적 요인을 무시하여 근본 문제를 해결하지 못할 수 있음
- 심각한 심리적 정신적 문제에 적용하기 어려움
- 개인의 책임에 대한 지나친 강조
- 문화적 민감성 부족

다문화 상담 / 7주차 1차시

1. 다문화 상담의 이해

- 상담에서 문화의 중요성이 강조되면서 다문화 상담은 정신역동, 인지행동, 실존주의-인본주의에 이어 제4의 세력으로 등장
- 모든 사람은 문화적 존재이므로 모든 상담도 문화적 존재 간의 상호작용으로 구성된 다문화적 만남
- 국내의 다문화 상담은 결혼이주 여성, 이주 노동자, 다문화 가정 등과 같이 민족과 인종을 주로 다루어왔지만, 실제로 다문화 상담은 여성, 성소수자, 장애, 여성, 노인, 학력, 사회경제적 지위, 도시 거주 여부 등을 포괄
- 다문화라는 개념은 단순히 다양성(diversity)과 차이를 설명하는 것이 아니라 주류와 다름으로 인해서 겪게 되는 차별과 억압을 포함하고 있음을 이해할 필요
- 다문화 상담에서는 사회적 구체와 체제로 인해 소외, 차별, 억압을 경험한 모든 사람을 대상으로 함
- 다문화 상담 운동의 영향은 상담자들이 특정 사회 구성원에 대해 지닌 선입견과 고정관념 같은 편향성을 새롭게 조명하였고, 심리 장애를 단지 내적인 현상으로 바라보는 전통적 입장에서 문화와 사회정치적 요인들의 영향을 인식하도록 패러다임을 전환함
- 내담자 문제를 다른 요인들의 영향을 고려하지 않고 심리 내적 현상으로만 개념화하여 접근한다면, 내담자가 겪고 있는 어려움을 개인의 책임으로만 전가하는 태도를 일으킬 수 있음
- 다문화 상담은 사회적 소수자들이 디디고 있는 '기울어진 운동장'에 대해 상담자들이 인식하는 계기를 만들어줌
- 다문화 상담에서는 특권, 억압, 차별에 관심

1) 특권

- 한 사회에서 구체적인 특징을 기반으로 선택된 집단의 사람들에게 사회적으로 부여하는 체계적이고 획득된 혜택
- 특권을 그것을 누리는 사람들에게는 의식되지 않는 특성이 있어서, 누리는 사람은 자신이 누리는 특권이 무엇인지 의식하지 못함. 자신에게 허락된 특권이 무엇인지, 그것이 상대방에게도 허락되는지에 대하여 생각할 필요조차 없음

2) 억압

- 권위나 힘의 불공평한 또는 잔인한 행사를 의미. 사회적 소수자는 있는 그대로의 자신을 드러낼 때, 부정적인 평가를 받을 것이라는 불안과 두려움 느낌
- 억압으로 인한 부작용은 개인의 문제로 돌려지기 쉽다는 점. 이런 과정이 반복되면서 억압은

내면화되고, 개인이 자신의 불행을 책임져야 한다는 개인주의, 자유주의 사회의 가치관에 지지받음

- 억압은 권력에 근거하여 수행되며, 개인과 집단은 의도적, 비의도적으로 자신이 지닌 편견을 드러내어 억압을 발생, 유지, 심화시킴
- 인종, 성, 종교, 장애 여부, 국적, 성적 지향 등에 있어 주류와 다른 특징을 지닌 개인은 자기표현을 억압당하거나 자신을 억압
- 호의적 오명(courtesy stigma) : 스스로 억압하는 사람은 타인이 더 이상 자신에게 낙인을 찍거나 억압하지 않을 때도 낙인과 억압을 경험. 호의적인 오명은 사회적으로 낙인찍힌 낮은 자기 존중감을 지니도록 유도하며, 거부 받는 것을 피하려고 사회적 상호작용에서 철수하도록 함
- 소수자 스트레스 : 역사적으로 주변화된 집단의 구성원이 경험하는 사회적 억압과 낙인이 정신건강에 부정적 영향
- 억압은 개인적, 사회문화적 그리고 제도적 수준 모두에서 작동

개인적 수준의 억압	관계를 맺는 상대방 또는 자신을 지속적으로 비인간화
사회문화적 형태의 억압	한 사회의 지배 문화적 규준과 관행이 사회적 소수자를 대상화하고 비인간화
제도적 수준의 억압	개인의 인종, 민족, 성, 성적 지향, 연령, 능력, 경제적 또는 종교적 정체성에 근거하여 사회에서 재화, 서비스 그리고 기회에 접근하는데 있어 차별로 발생

3) 차별

- 차별은 편견에 근거하여 개인에게 부정적으로 대하는 의식적, 무의식적 행동
- 차별의 형태는 의도적이고 노골적인 것에서부터 비의도적이고 미묘한 방식이 존재
- 마이크로어그레션(microaggression) : 국내에서는 미시차별, 먼지차별, 미묘한 차별 등으로 번역하여 사용. 명백한 의도를 가하는 차별에서부터 선의에서 비롯된 태도이지만 그 바탕에는 편견이 반영되어 드러나는 차별적 태도를 의미. 마이크로어그레션은 미묘한 공격(microassault), 미묘한 모욕(microinsult), 미묘한 비타당화(microinvalidation)로 구분

미묘한 공격	상대를 공격하고 피해를 주기 위한 명백한 의도를 가진 언행 미묘한 공격은 익명성이 보장되거나 다수가 함께할 때 더 자주 발생
미묘한 모욕	소수자에 대한 비하, 멸시, 모욕적인 언행을 의미 분명한 의도성을 가지고 행해지기도 하지만 그렇지 않은 상태에서 발생하기도 함 (예: 장애인에게 '희망을 잃지 마세요'라며 격려하는 것)
미묘한 비타당화	소수자의 생각, 감정, 경험적 현실을 배제, 부정 또는 무효화 하는 것을 의미 대부분 의식화되지 않은 상태에서 발생 소수자의 경험 자체를 인정하지 않기 때문에 가장 유해

2. 다문화 상담의 필요성

- 1960년대 말 다양한 인종과 민족이 공존하는 미국 사회에서 특정한 문화적 가치에 바탕을 둔 상담 접근이 다양한 문화 배경의 구성원들에게 적합하지 않다는 인식이 고조되면서 그 필요성이 제기
- 기존의 상담 접근은 인간 경험의 보편성과 동질성을 강조하였지만, 이런 입장이 주류 사회에서 비가시적 즉, 존재가 가려진 채 살아온 소수인종이나 민족, 성소수자, 장애인 등과 같은 구성원에게 얼마나 부합할 수 있는가에 대한 문제 제기
- 이러한 문제를 '문화적으로 밀폐된 상담자'라는 용어에 빗대어 비판. 문화적 밀폐란 타인의 문화적 배경에 대해 인식하지 못하거나 이해가 부족한 나머지 자신의 문화적 규범이 중립적이고 보편적이라고 여기는 현상
- 다문화 상담은 전통적 상담이론 및 기법이 다문화를 충분히 반영하지 못한다는 비판에서 비롯됨
- 상담자는 내담자에게 안전하고 효과적인 상담 서비스를 제공해야 하며, 상담자의 문화적 역량은 다양한 문화적 배경을 가진 내담자와의 상담의 질을 높일 수 있음

1) 상담자 자신의 문화적 특성

- 다문화 상담에서는 상담자 자신의 문화적 특징을 이해할 것을 강조
- 문화적으로 밀폐된 상담자는 자신과 다른 세계관, 문화 및 가치관을 지닌 내담자의 '현실'을 고려하지 않고 상담자 자기 경험을 내담자에게 적용하여 비효과적인 상담을 제공할 수 있음
- 상담자 자신의 문화적 특징을 알지 못하면, 상담자가 의도하지 못하는 사이에 내담자에게 차별과 억압을 행사할 우려
- 상담자가 내담자의 문화적 특징뿐만 아니라 자신의 문화적 특징까지 충분히 이해하지 못하거나 둘 사이의 문화적 공통점과 차이점을 파악하지 못하거나, 각각의 문화적 특징에 대한 충분한 지식을 갖지 못하면 차별과 억압이 발생
- 상담자 또한 문화적 존재이기 때문에, 자신의 문화적 특징에 따라 내담자를 바라보는 관점이 다를 수 있고, 내담자와 문제에 대한 평가가 달라질 수 있으며, 상담 개입 방법이 달라질 수 있음

2) 내담자의 문화적 특성

- 내담자를 전통적 상담에서와 같이 개인적 차원에서만 바라보면 제대로 이해하지 못할 수 있음
- 내담자는 가족과 친척, 학교와 또래 및 교사 등의 미시체계, 이런 미시체계 간의 관계로 구성되는 중간체계, 가족의 친구나 직장 및 지역 교육청 등의 외체계, 사회규범이나 정책과 매스컴 등의 거시 체계와 끊임없이 상호작용
- 내담자를 둘러싸고 내담자와 끊임없이 상호작용하며 유무형의 결과를 남기는 체계는 내담자의

성장배경이 되고, 체계의 특징은 내담자로 하여금 독특한 문화적 특징을 지님

- 같은 문제를 호소하는 내담자라 할지라도 그가 어떤 문화적 배경에서 성장했고, 현재 어떠한 문화적 여건에 놓였느냐에 따라 문제의 심각도나 해결방안에서 차이가 날 수 있음

3) 문화적 맥락을 이해할 때, 효과적인 문제의 해결

- 다문화 상담 또한 전통 상담과 마찬가지로 내담자가 스스로 문제를 해결하도록 돕는 것을 목표. 다문화 상담자는 자신에게 어려움이 있음을 호소하는 내담자가 자신의 감정을 만나며, 스스로에게 도움이 되는 생각을 탐색하고, 적응적인 행동을 할 수 있도록 도움
- 내담자의 심리적 어려움이 사회구조적 억압, 소외, 차별에서 영향을 이해하고, 내담자의 어려움을 개인화하지 않도록 주의

3. 다문화 상담 역량

- 다문화 상담역량은 내담자의 문화적 맥락과 배경을 민감하게 인지하고 인식하여 적절하게 반응할 수 있는 상담자의 능력을 의미

1) AMCD(Association for Multicultural Counseling and Development) 다문화 상담 역량

(1) 자신의 문화적 가치와 편견에 대한 상담자의 인식

- 태도와 신념 : 자신의 문화적 배경과 경험의 중요성 인식
- 지식 : 자신의 문화에 대한 구체적 지식
- 기술 : 자신의 문화적 특징을 알기 위해 기울이는 노력(컨설팅, 훈련, 자문 구하기 등)

(2) 내담자의 세계관에 대한 상담자의 인식

- 태도와 신념 : 다른 집단에 대하여 자신이 가진 편견 인식
- 지식 : 내담자의 출신 집단 문화에 대하여 알고 있음
- 기술 : 다양한 문화 집단에 관한 최근 연구 및 실무에 익숙해지려고 노력

(3) 문화적으로 적절한 개입 기술

- 태도와 신념 : 문화적 차이가 상담에 미치는 영향을 긍정적으로 수용
- 지식 : 심리치료와 관행이 특정 집단 출신 내담자에게 미치는 영향에 대해 인식
- 기술 : 내담자의 문화에 맞는 상담 기술을 활용하고 연계

2) 한국 상담자의 다문화 상담역량

(1) 상담자 문화에 대한 수용

- 내담자와 종교적 신념 차이를 경험할 때 민감성을 유지하면서도 편안하게 받아들임
- 내담자와 사회 계층적 특징 차이를 경험할 때 민감성을 유지하면서도 편안하게 받아들임
- 내담자와 성(gender)역할 고정관념 차이를 경험할 때 민감성을 유지하면서도 편안하게 받아들임

- 내담자와의 인종, 민족, 정체성 차이를 경험할 때 민감성을 유지하면서도 편안하게 받아들임
- 내담자와의 신체적 특징(장애, 외모 등) 차이를 경험할 때 민감성을 유지하면서도 편안하게 받아들임

(2) 상담자 문화에 대한 지식

- 사회경제적 배경에 대한 상담자의 고정관념이 상담을 진행하는 데 어떤 영향을 미치는지 인식
- 성(gender)에 대한 상담자의 고정관념이 상담을 진행하는 데 어떤 영향을 미치는지 인식
- 인종, 민족에 대한 상담자의 고정관념이 상담을 진행하는 데 어떤 영향을 미치는지 인식
- 특정 신체적 특징(장애, 외모 등)을 가진 사람들에 대한 상담자의 고정관념이 상담을 진행하는 데 어떤 영향을 미치는지 인식
- 성소수자에 대한 상담자의 고정관념이 상담을 진행하는 데 어떤 영향을 미치는지 인식

(3) 상담자 문화의 영향 조절 노력

- 성(gender)에 대한 상담자의 고정관념이 상담에 미치는 영향을 이해하기 위해 교육이나 훈련, 슈퍼비전을 받음
- 인종, 민족에 대한 상담자의 고정관념이 상담에 미치는 영향을 이해하기 위해 교육이나 훈련, 슈퍼비전을 받음
- 상담자 세대의 특징으로 인한 고정관념이 상담자의 고정관념이 상담에 미치는 영향을 이해하기 위해 교육이나 훈련, 슈퍼비전을 받음
- 특정 신체적 특징을 가진 사람에 대한 상담자의 고정관념이 상담에 미치는 영향을 이해하기 위해 교육이나 훈련, 슈퍼비전을 받음
- 문화적 배경이 다른 사람들과의 상담을 위해 교육이나 훈련, 슈퍼비전을 받음

(4) 내담자 문화에 대한 존중

- 내담자가 어떤 사회경제적 배경 출신이든 내담자를 존중
- 내담자가 여성이든 남성이든 내담자를 존중
- 내담자가 어떤 인종, 민족 출신이든 내담자를 존중
- 내담자의 신체적 특징에 개의치 않고 내담자를 존중
- 내담자의 국적에 개의치 않고 내담자를 존중

(5) 내담자 문화에 대한 지식

- 내담자의 신체적 특징이 내담자의 삶에 미치는 영향을 이해
- 내담자의 문화적 배경이 내담자의 심리적 장애의 발현에 미치는 영향을 이해
- 내담자의 문화적 배경이 내담자의 도움 요청 행동에 미치는 영향을 이해
- 내담자의 문화적 배경이 내담자의 대인관계에 미치는 영향을 이해

(6) 다문화 지식의 활용

- 다양한 종교에 관한 최근 연구 경향을 알고 내담자를 이해하는 데 활용
- 다양한 사회경제적 배경에 관한 최근 연구 경향을 알고 내담자를 이해하는 데 활용
- 성역할에 관한 최근 연구 경향을 알고 내담자를 이해하는 데 활용
- 다양한 인종, 민족의 현안에 대해 알고 내담자를 이해하는 데 활용

- 다양한 인종, 민족의 특성이 정신건강과 심리상태에 미치는 영향에 관한 최근 연구 경향을 알고 내담자를 이해하는 데 활용

(7) 다문화 기법 수용

- 상담을 진행할 때 내담자의 사회경제적 배경을 존중하는 상담기법 사용
- 상담을 진행할 때 내담자의 성을 존중하는 상담기법 사용
- 상담을 진행할 때 내담자의 인종, 민족, 정체성을 존중하는 상담기법 사용
- 상담을 진행할 때 내담자의 연령을 존중하는 상담기법 사용
- 상담을 진행할 때 내담자의 신체적 특징을 존중하는 상담기법 사용

(8) 개입기법의 차별적 요소에 대한 지식

- 심리검사 도구나 상담기법에 포함된 소외계층에 대한 미묘한 차별적 표현을 식별할 필요
- 심리검사 도구나 상담기법에 포함된 성차별적 표현을 식별할 필요
- 소수인종, 민족 출신의 내담자가 상담 서비스를 이용할 때 경험할 수 있는 어려움을 이해할 필요
- 심리검사 도구나 상담기법에 내재된 연령 차별적 표현을 식별할 필요
- 어떠한 신체적 특징을 지닌 내담자가 상담 서비스를 이용할 때 경험할 수 있는 어려움 이해

(9) 다문화적 상담 개입 기술

- 내담자의 사회경제적 배경을 고려하면서 효과적으로 상담할 수 있음
- 내담자의 성을 고려하면서 효과적으로 상담 가능
- 내담자의 인종, 민족, 정체성을 고려하면서 효과적으로 상담 가능
- 내담자의 연령을 고려하면서 효과적으로 상담 가능
- 내담자의 신체적 특징을 고려하면서 효과적으로 상담할 수 있음

1. 마음챙김

1) 마음챙김 개념

- 자신의 마음에 떠오르는 현상들을 있는 그대로 바라보는 행위
- 마음챙김은 불교의 수행법 중 하나의 위빠사나 명상에서 기인
- 불교 수행법은 다양하게 구분되지만, 그 핵심은 마음을 고요하게 하는 것과 마음을 관찰하여 깨달음을 얻는 것
- 마음의 현상을 있는 그대로 세세밀밀하게 바라보면서 깨달음에 이르는 수행법은 관법으로 위빠사나 명상 또는 통찰 명상이라고 불림
- 관법수행, 즉 위빠사나 명상의 핵심이 마음챙김(sati)

2) 사띠

- 사띠(sati)는 '기억하다'라는 의미를 지닌 동사에서 파생된 명사이지만 '분명한 알아차림', '현재에 대한 주의집중', '충분히 깨어있음'을 의미하며 감각기관의 문을 통해 일어나고 사라지는 몸과 마음의 모든 현상을 감지하여 알아차리는 것
- 사띠(sati)는 영어로 'mindfulness'로 번역되어 사용되고 있으며 한글로는 마음챙김, 알아차림, 마음지킴, 마음모음, 마음 바라보기 등의 다양한 용어로 사용되고 있으니 '마음챙김'이 가장 널리 사용됨

3) 마음챙김의 주요한 네 가지 특징

- (1) 즉시성, 즉 지금 일어나고 있는 대상에 대한 즉각적인 자각
- (2) 들뜨지 않음, 즉 관찰 대상에 주의를 집중하려는 의도적인 노력
- (3) 대상을 조작하지 않음, 즉 몸과 마음에 나타나는 현상을 조작하거나 조절하려 하지 않고 다만 대상을 있는 그대로 관찰하는 것
- (4) 보호함, 즉 번뇌의 공격으로부터 막아주거나 보호하는 작용

마음챙김은 몸과 마음에서 현재 일어나고 있는 의식 경험에 주의를 집중하여 이를 있는 그대로, 즉 비판단적이고 비평가적인 수용적 태도로 명확하게 알아차리는 의도적 노력으로 번뇌에서 벗어나게 해줌

4) 마음챙김의 요소

- (1) 알아차림(내적, 외적 현상에 주의를 기울이고 민감하게 자각하는 것)
- (2) 명명하기(내적, 외적 현상에 이름을 붙이는 것)
- (3) 비판단적으로 수용하기

(4) 현재의 순간에 집중하기

5) 마음챙김의 심리 치유적 기능

- 마음챙김은 현재의 경험을 수용적으로 자각하여 알아차릴 수 있게 함
- 사람들은 일상적으로 마음의 초점을 현재보다 과거와 미래에 두고, 자신의 경험에 대해 평가적이고 판단적이며, 자신의 마음 상태를 알아차리지 못한 채로 살아감
- 마음챙김을 하게 되면, 관찰 자아와 체험자아가 분리됨으로써 자기 경험을 대상화하여 바라보게 되고 그 결과 관찰 자아와 체험자와의 탈 동일시가 나타남
- 관찰자아가 체험 자아에 함몰되지 않은 채로 거리를 두고 바라볼 수 있어서, 자기 경험의 변화에 대한 정서적 반응이 감소하며 평정의 상태로 체험 자아를 바라봄
- 통증이나 불안과 관련된 사고를 비판단적으로 관찰함으로써, 그러한 사고가 실재의 반영이 아니라 '단지 생각일 뿐'임을 깨닫게 됨으로써 이를 회피하거나 제거하기 위한 불필요한 행동을 하지 않게 됨
- 마음챙김을 통해 자신의 마음에 대한 이해도가 깊어질 수 있음
- 현재의 자기 경험에 대한 관찰은 자기 이해를 깊게 할 뿐만 아니라, 탈자동화를 통해 부적응적 습관을 약화시킴
- 마음챙김은 고통과 불안을 유발하는 심리적 경험에 대한 반복적 노출을 통해 그에 대한 인내력 증진함
- 마음챙김은 정서적 평정과 심리적 자유로움을 가져다줄 수 있음. 자기 경험을 비판단적, 비평가적, 수용적 자세로 관찰함으로써 정서적 평정과 자유로움을 경험하게 만듦

2. 수용전념치료(ACT)

1) 수용전념치료의 개념

- 수용전념치료는 Steven Hayes와 그의 동료들에 의해 개발된 제3세대 인지행동치료로서 마음챙김을 주요한 치료적 요소로 포함
- 수용전념치료의 대전제는 '고통은 인간 삶의 기본 요소'라고 하는 가정으로 인간에게 있어 고통은 보편적이며 정상적인 것으로 봄
- 인간의 병리가 '경험 회피'와 '인지적 융합'으로 인한 '심리적 경직성'에서 기인한다고 주장

2) 경험 회피와 인지적 융합

(1) 경험 회피

- 경험 회피는 인간이 고통스러운 경험을 직면하기보다 그것을 제거하거나 변화시키려고 통제하려는 노력을 의미. 그러나 이러한 통제의 노력은 오히려 역설적으로 고통을 가중함
- 생각하지 않으려는 시도, 감정을 느끼려 하지 않는 시도 등과 같은 경험 회피는 오히려 그 생각과 감정에 몰입하게 만든다.

(예 : 바나나를 생각하지 마세요, 사회공포증 때문에 모임에 나가지 않는 경우)

(2) 인지적 융합

- 인지적 융합은 언어로 인해 생각을 현실로 인식하면서 개념의 틀 속에서 갇혀 고통을 겪는 것을 의미. 즉, 인간은 경험을 있는 그대로 바라보는 것이 아니라 언어를 통해 재구성하여 생각이 마치 '현실'인 것처럼 또는 '자기'인 것처럼 인식하는 것

3) 수용전념치료 목표

- 수용전념치료의 목표는 개인이 추구하는 가치에 이바지하는 행동을 지속할 수 있는 능력을 증대시키는 것

4) 수용전념치료의 치료적 요소

(1) 수용

- 비판단적인 태도를 지니고 자신의 생각, 감정, 신체적 감각 등의 경험을 능동적으로 껴안는 것
- 수용은 경험을 없애거나 통제하거나 회피하지 않고 있는 그대로를 기꺼이 경험하는 것
- 즉, 고통은 '통제' 노력으로 인해 강화되고 '통제'는 더 이상 고통을 완화할 수 없다는 '창조적 절망감'을 자각하게 되면서, 고통에 대한 관계를 변화와 통제가 아닌 '수용'으로 바꾸는 것
- 이를 위해 언어적 설득과 지적인 통찰을 삼가고 마음챙김 명상, 비유, 게슈탈트 치료기법, 게임이나 연습 등과 같은 체험적 기법이 활용됨
- 기꺼이 경험하기의 목표는 자신에게 다가오는 모든 감정, 특히 나쁜 감정들조차도 더 온전하게 느낌으로써 자신의 삶을 더 완전하게 영위하려는 것
- 기꺼이 경험하기는 '더 좋게 느끼려고' 노력하는 것이 아니라, '더 잘 느끼는' 법을 배우는 것

(2) 인지적 탈융합

- 인간은 언어로 인해 인지적 융합을 경험하게 되므로 심리적 고통을 가중시킴
- 인지적 융합이란 우리의 생각을 생각으로 간주하는 것이 아니라 실제로 간주하는 것을 의미
- 생각의 내용 중 많은 부분이 평가적이기 때문에 인지적 융합은 평가와 관련성이 높음
(예 : 불안은 나쁜 것이다, 나는 우울증 환자이다)
- 생각, 심상, 감정, 기억을 언어적 개념으로 추상화하지 말고 있는 그대로 체험하도록 함
- 생각에서 보는 것이 아니라 생각을 보는 것을 연습
- 생각이 한 개인의 세계를 어떻게 구성하는지 알아차리고, 생각을 통해 그 세계를 더 견고하게 만들고 있음을 인식
- 생각을 생각으로, 감정을 감정으로, 기억을 기억으로, 신체적 감각을 신체적 감각으로 보도록 가르침으로써 언어의 굴레에서 벗어나도록 함
(예 : '젠장, 나 너무 불안해' -> '나는 지금 불안하다고 생각하고 있어')
- 기술과 평가의 차이를 구분하도록 도움. 기술은 대상이나 사건의 직접적 관찰할 수 있는 측면이나 특징과 연결된 언어표현. 평가는 사건 또는 그 측면에 대한 반응
(예 : 기술 - 이것은 나무로 만든 탁자다 / 평가 - 이것은 좋은 탁자다)

▪ 그 밖의 인지적 탈융합 기법

이름표 달기	부정적인 평가(예 : 비열한, 우둔한, 까칠한, 못난 등)를 이름표에 적어서 가슴에 달고 다니기. 한동안 이를 아무에게도 설명하지 않고 그저 이름표를 달고 다니는 것이 어떻게 느껴지는지 느끼기
반대로 행동하기	만일 마음이 어떤 행동을 중지시키면, 스스로 마음이 한 것과 같이 명령하면서 행동은 의도적으로 그 반대로 하기(예 : '나는 꼼작도 할 수 없어.'라고 말하면서 그 자리에서 일어나 주위를 걷기
무엇에 도움이 되는지	당신이 어떤 생각의 내용을 믿고 있을 때, 잠시 뒤로 물러서서 스스로 질문해 보기. "이 생각을 믿는 것이 무엇에 도움이 되는가?" 만일 도움이 되지 않는다면, 그 생각을 믿는 것을 멈추기
당신이 옳다. 그래서?	당신의 삶에 도움이 되지 않음에도 당신의 생각이 '옳다'는 것을 위해 투쟁하고 있다면, 판사가 '당신의 생각이 옳다.'라고 선언했다고 가정하기. 그런 다음 자신에게 질문하기. "그래서? 내 생각이 옳다고 해서 더 가치 있는 삶을 위해 내가 실제로 무엇을 할 수 있는데?"
왜, 왜, 왜?	만일 "왜 그렇지?"와 같은 이유를 질문에 휩쓸려 듣게 된다면, 대답하기 곤란할 지경에 이를 때까지 "왜 그 사건이 존재하지?" "왜 그것은 그런 식으로 기능하지?"와 같은 질문을 반복해서 하기. 그 이야기가 실은 얼마나 피상적인지, 그리고 경험의 회피 때문에 어떻게 부재의 고통이 나타나는지를 깨닫는 데 도움이 됨 (예 : 나는 못 해. 왜? 불안하니까. 불안하면 왜 할 수 없는데?)
생각을 '믿는다'	그저 일어난 생각과 자신이 믿고 있는 생각을 구별하기 위해 적극적인 언어 사용 (예 : 나는 내가 나쁜 사람이라는 생각을 믿고 있는 것 같아)

(3) 맥락으로서의 자기

- 지금-여기의 경험을 '조망하는 자기' 혹은 '관찰하는 자기'를 의미
- 언어로 인해 개념화된 자기(예: '나는 쓸모없는 사람이다'라는 평가)와의 과도한 융합이 심리적 경직성을 초래
- 개념화된 자기에게서 벗어나 생각, 감정, 기억, 신체적 감각 등과 같은 사적인 사건이 일어나는 '맥락으로서의 자기', 즉 지금-여기의 경험을 '조망하는 자기' 혹은 '관찰하는 자기'로 경험하는 것

(4) 현재에 존재하기

- 언어로 인해 과거와 미래에 집착하는 것에서 벗어나 지금-여기의 체험을 알아차리며 현재에 존재하도록 하는 것
- 개방적으로 현재의 순간에 접촉하도록 촉진
- 내담자가 환경과 사적 경험의 존재를 관찰하고 알아차리도록 훈련함

- 내담자가 과도한 판단이나 평가 없이 현재에 존재하는 것을 명명하거나 기술하도록 가르침

(5) 가치

- 개인이 실현하기를 원하는 삶의 중요한 가치나 목표를 의미
- 내담자는 생각과 감정을 통제하려는 노력이 비효과적임을 깨닫고 경험을 있는 그대로 수용하면서, 그동안 통제에 투여했던 에너지를 어디에 쓸 것인지 관심을 두게 됨
- 이 단계에서 내담자는 진정으로 삶을 통해 실현하고자 하는 가장 소중한 가치를 생각해 볼 수 있음
- 개인의 가치가 명료해지면, 그에 따른 구체적인 목표와 행동들을 정할 수 있음

(6) 전념적 행동

- 소중한 가치와 목표를 실현하기 위한 구체적 행동에 전념하는 것
- 이 단계에서는 내담자가 자기 행동에 대한 의도한 또는 의도하지 않은 결과를 받아들이도록 격려하는 동시에 가치 있는 행동을 지속해 실행하도록 함
- 수용전념치료에서는 변화가 가능한 영역에서는 구체적인 행동을 통해서 변화를 유발하는 데에 초점을 두는 한편, 변화할 수 없거나 유익하지 않은 영역에서는 수용과 알아차림에 역점을 두는 균형적인 접근을 취함
- 행동적 영역에서는 내담자 문제에 따라 심리교육, 문제해결, 노출 및 행동 치료적 기법 등을 사용

상담방법 / 9주차 1차시

1. 상담자의 기본적 태도

1) 자신에 대해서 알기

- 상담자는
 - 내담자와 만났을 때 어떠한 독특한 특성을 가지게 됨
 - 연령, 인종, 문화, 성별, 성적지향, 학력, 경제적 수준, 결혼 여부, 자녀 여부 등이 내담자와 다를 경우 상담 관계에서 일종의 짐이 되기도 함
 - 자신의 특성이 상담 관계에서 내담자에게 어떠한 영향을 미칠 수 있는지 인식할 필요
- 자신에게 영향을 끼친 중요한 사건들에 대한 이해
 - 예) 모의 우울, 지인의 자살, 부의 중독, 성폭행, 외상 경험 등
- 개인적인 경험을 내담자를 이해하고 공감하는데 기본 바탕을 제공.
 - 그러나 상담자가 자기 경험을 바탕으로 내담자의 경험을 왜곡시킬 수 있음

2) 자신에게 영향을 미쳤던 경험을 인식하기

- 내담자가 호소하는 문제가 상담자의 개인적인 오래된 삶의 주제를 자극하기도 함
 - 예) 섭식장애를 겪었던 상담자. 섭식장애 대학생으로 구성된 집단상담 운영하려 할 때, 집단원보다 날씬한 사람이 되려는 욕구가 생김.
 - 상담자는 집단원들과 경쟁의식을 갖게 되었고, 이러한 상담자의 태도는 집단원들에게 미묘한 불편감을 느끼게 할 수 있음

3) 자기 개방에 대한 숙고

- 상담자가 의미 있게 받아들이는 것이라도 내담자는 다를 수 있음
- 상담의 초점을 내담자의 이야기에 초점을 맞출 필요
- 상담자는 자기 노출에 주의하고 계획과 전략을 가져야 할 필요
 - 예) 독실한 기독교인 상담자. 불교를 믿는 내담자를 따라 기독교였던 내담자의 애인이 개종을 고려하고 있다는 이야기를 듣고, '개종을 하는 것이 두 분의 관계에 어떤 의미가 있을지 모르겠다'라는 비판적으로 이야기.
 - 이러한 상담자의 자기 개방은 상담에 도움이 되지 않음

4) 지양해야 할 태도

(1) 기법 자체를 위한 기법 사용

- 임상적 전문 용어를 사용하거나 복잡한 전략을 사용하여 내담자가 소외되는 상황 발생할 수 있음

- 이전에 통했던 방법이 새로운 내담자에게 맞지 않을 수 있음
 - 한 가지 주제나 방법을 강요하기보다는 유연성을 가질 필요
- (2) 내담자 탓으로 돌리기
- 상담에 진전이 없을 때 내담자의 책임을 돌리는 것
 - 상담자 자신이 어떻게 변화해야 하는지 이해하기보다 내담자가 좀 더 빨리 변화하지 않는다고 탓하기 쉬움
 - 내담자가 상담자가 기대하는 것과 다를 때 짜증을 내거나 좌절감을 느낄 수 있음
- (3) 내담자를 빨리 치료하려는 시도
- 내담자가 준비된 수준보다 더 빨리 진행하려는 시도는 효과적이지 않음
 - 충고나 미숙한 해결책을 제공하거나 특정 행동을 해 보라고 압력을 가하는 것은 도움이 되지 않음

2. 라포 개념 및 촉진적 조건

1) 라포 개념

- 상담자와 내담자 사이의 치료적 관계의 질
- 상담 과정에서 내담자와 상담자가 긍정적인 분위기 속에서 호감과 신뢰에 기반한 상호 조력과 협력의 인간관계를 구축하는 상태
- 내담자가 상담자의 첫인상에 근거하여 가지게 되는 우호적 느낌으로서, 주로 상담 1~2회기에 중요하게 작용함
- 내담자와 상담자 간에 빠르게 형성되는 최초의 신뢰, 공감, 유대 등의 긍정적 감정 및 그에 기반한 초보적 협력 관계인 동시에, 이후의 상담 지속 여부와 후속 회기 상담의 수준, 질 등을 결정지음

2) 촉진적 조건

(1) 무조건적인 긍정적 관심

- 내담자의 감정이 어떤 것이든 느끼든 그대로 표현하도록 허용하는 것
 - 혼란, 분노, 두려움, 노여움, 용기, 사랑 등
- 구체적 태도
 - 내담자의 걱정애 관심 갖기
 - 내담자의 불완전성을 인정하고 수용하며 상태가 나아지도록 돕는 과정에 기꺼이 동참함으로써, 내담자가 혼자 외롭게 싸워야 할 필요가 없음을 깨닫게 됨
 - 개인적 반응 보류하기
 - 내담자를 판단하려 들지 않고 경청할 필요.
 - 비판을 잠시 보류함으로써 상담에서 탐색을 위해 필요한 안정감을 얻게 됨
 - 내담자의 자율성 인정하기

- 내담자가 자신의 행동 방향을 스스로 선택할 권리를 주게 되면 존중감이 가장 확실하게 유지될 수 있음.

- 상담자는 편견과 고정관념, 가정 등을 예의 주시해서 이런 것들을 내담자에게 강요하지 않도록 유의해야 함

- 문화적 차이 존중하기

- 문화적 차이를 인정하는 것이 중요

- 내담자의 책임감 존중하기

- 내담자가 선택한 것에 책임을 질 수 있는 존재로 대할 필요.

- 내담자의 책임감 있는 행동 능력을 강화해 줄 때 내담자의 자존감 발달을 지원할 수 있음

- 상담자의 자존감 유지하기

- 상담자가 자신의 인간적 속성(기본 욕구, 정서적 반응, 소망, 가치관, 규범)을 존중할 때 다른 사람을 존중하기가 더 용이.

- 기본적인 수준으로 적절한 상담료, 상담 시간 초과하지 않기 등이 이에 해당하며, 나아가 상담자 자신의 가치관, 규범, 선택을 스스로 존중할 필요.

- 공감적 이해

- 공감적 이해는 라포의 기반을 제공하기 때문의 초기에 가장 중요

- 내담자가 경험하는 감정을 정확히 감지하고 이러한 이해를 내담자에게 전달할 필요.

- 최상의 공감적 이해가 이루어지면, 상담자는 내담자의 개인적 세계의 매우 깊은 곳까지 들어갈 수 있게 됨(Rogers)

- 공감 상태 또는 공감한다는 것은, 다른 사람의 내적 준거 체제를 마치 자신이 그 사람인 것처럼 정서적 요소 및 의미와 함께 정확하게, 그러나 '마치 그런 것처럼'이라는 조건을 잊지 않고 인식하는 것

- '마치 그런 것처럼'이라는 조건을 인식하는 것은 상담자가 자신의 견해를 희생해야 한다거나 반드시 동정이나 인정을 베풀어야 한다는 것을 의미하지 않음.

- 그러나 지금, 이 시점에서 내담자에게 진실로 다가오는 것이 무엇인지 확인할 필요

- 예) 40세 한 여성은 알코올중독 남편과 별거한 뒤 상담을 받으러 내방. 그녀는 이혼을 앞두고 지지와 확인을 원함. 그녀는 지난 수년 동안 무시당하고 살아온 데 대해 몹시 화가 나 있었기 때문에 까다로운 요구조건을 내 걸음. 상담자는 이혼 과정에 있는 여러 커플을 상담해왔지만, 현재 내담자의 감정을 정확하게 알지 못한다고 가정하고 상담을 진행. 그녀가 느끼는 고유한 감정 경험을 이해하기 위해 경청하는 태도가 필요

- 상담자가 이해할 수 없는 것을 이해하는 척하는 태도 지양해야 함

- 일치성

- 진솔하게 생각하고 느낀 것을 표현하게 되는 것

- 상담자는 어떤 내담자가 목소리로 말하는 것과 신체언어로 말하는 것이 다른 것에 대해 이러한 불일치를 탐색할 수 있음

- **경청**
 - 자신의 편견, 고정관념, 가정이 무엇인지 인식하고 영향받지 않기 위한 노력: 효과적인 경청을 막는 것은 이미 알고 있다는 착각
 - 예) T라서 그래 F라서 그래
 - 다른 문제에 몰두하지 않기 위한 노력: 다른 문제에 골몰해 있을 때, 내담자에게 경청하기 어려움
 - 자신의 문제를 다른 모든 사람 속에서 보려 하지 않기
 - 예) 내담자의 문제가 상담자 개인적 경험을 떠올리게 할, '나는 왜 이것 내담자에게 말하고 싶지', '이걸 털어놓는 것이 내담자를 위한 일인가?' 생각해보기
 - 내담자의 상황을 최소화하지 않기: 비극적인 이혼에 대한 상담을 진행한 후, 다음 내담자가 토로하는 룸메이트와의 연쟁 이야기를 들으며 사소한 문제로 치부하는 것과 같은 태도를 조심할 필요
 - 다른 사람을 결부시키는 것: 내담자의 이야기를 듣다가 다른 누군가를 결부시킬 때 내담자의 문제를 최소화하기 쉬움

3. 역전이 개념

1) 고전적 접근

- Freud는 역전이는 내담자의 전이에 대한 상담자의 반응
- 역전이는 상담자의 미해결된 갈등, 무의식적 문제에서 기인
- 역전이는 상담에 방해물로 작용하므로 제거하거나 통제할 필요

2) 전체적 접근

- 역전이에 대한 광의의 개념
 - 내담자에 대한 모든 생각, 감정, 환상 등이 모두 역전이라는 개념
 - 상담에 이용할 수 있는 도구가 될 수 있다는 입장
 - 내담자에 대한 정서 반응을 잘 다루기만 한다면 내담자를 이해하는 데 도움이 될 수 있음

3) 절충적 접근

- 고전적 개념과 전체적 개념의 유용성을 포함한 것이 절충적 접근
- 내담자의 문제나 개인적 특성이 상담자의 갈등을 건드릴 때 나타나는 상담자의 반응으로 역전이를 정의
- 상담자의 갈등이란 과거 유아기적인 미해결된 신경증적 갈등만을 의미하지 않고 현재 문제나 갈등도 포함됨
- 상담자가 역전이를 어떻게 지각하고 활용하느냐에 따라 상담 과정에 긍정적일 수도, 부정적일 수도 있음

표1. 역전이 정의의 비교

	고전적 접근	전체적 접근	절충적 접근
출처	상담자	내담자와 상담자의 상호작용	상담자의 갈등을 인정하지만, 엄격히 제한하지 않음
시기	과거 갈등	과거와 현재의 경험 모두 포함	과거 현재 경험 모두 포함
지형도	무의식	기본적으로 무의식이지만 의식적인 요소도 포함	무의식 반응과 의식적 반응 모두 포함
치료	방해물	인식된다면, 내담자를 이해하고 상호작용하는데 유용	긍정적 부정적 요소 모두 인정

4. 역전이 관리

- 1) 성취하려는 것 알기
- 내담자에게 과도하게 보호적
 - 지나치게 요구하는 태도로 반응
 - 내담자의 화에 위협당하는 느낌
 - 내담자에 대한 거부감
 - 내담자가 화나고, 짜증이 나고, 성가심
 - 내담자에게 지속적인 강화와 승인 추구
 - 내담자에게 상담자 자신의 모습 발견
 - 내담자에게 성적이거나 낭만적인 감정을 발전시킴
 - 강제로 충고
 - 내담자와 사적인 관계 추구
 - 내담자의 선택에 지나치게 신경을 씀
- 2) 사회문화적 차이에 대한 민감성 유지하기
- 학력, 장애, 인종, 민족, 성적지향, 성별 정체성, 성별 등의 차이로 인해 발생할 수 있는 상담자의 편견과 가치 인식

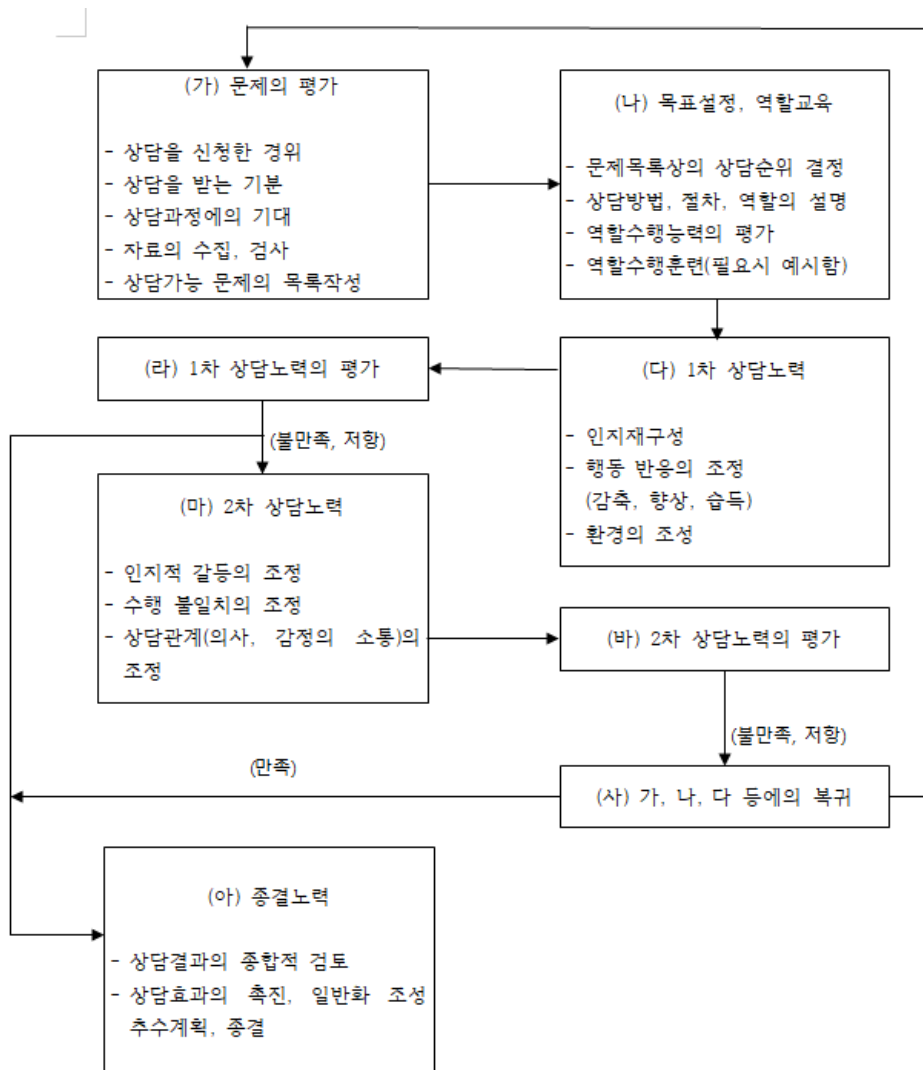
3) 자기 노출에 관한 결정 내리기

- 상담자의 동기와 기대를 고려
 - 나는 이러한 자기 노출이 내담자에게 어떻게 도움이 되는지 분명하게 말할 수 있는가?
 - 나는 그 이유를 동료나 슈퍼바이저에게 설명할 수 있는가?
 - 이런 개방을 할 정도로 상담 관계가 충분히 강한가?
 - 이러한 자기 개방을 촉진하는 다른 감정이 숨어 있는가?
 - 나는 이 내담자에게 화가 나 있지 않은가?
 - 이러한 질문에 적절한 답을 할 수 있어야 함
- 시점을 고려
 - 내담자가 피드백을 수용할 수 있는 시점을 잘 선택할 필요
- 초점을 내담자에게 지속해 맞출 필요
 - 상담자의 지나친 자기 개방은 상담의 초점을 상담자에게 가져가게 할 수 있음
 - 내담자가 상담자로 하여금 상담자의 이야기를 하게 만드는 것은 내담자 스스로는 자신의 문제를 더 이상 생각하지 않으려는 시도일 수 있음.
 - 상담자에게 개인적인 정보나 의견을 구함으로써 치료적인 작업은 피하려고 하는 것
- 이전 경험보다는 현재의 사적 경험을 노출
 - '지금-여기'에서 일어나는 경험에 대해 솔직하게 반응할 때 친밀해짐
 - 내담자가 자신의 감정을 자각하지 못할 때 상담자는 내담자가 자신의 반응을 좀 더 깊이 생각해보도록 격려하는 차원에서 자기 노출하는 것 도움
- 지지적이 되어라
 - 내담자 대부분 지지하고 격려하는 형태의 자기 노출에 대해 긍정적으로 반응
 - 지지적이지 않은 것을 노출해야 할 경우, 상담자는 매우 조심할 필요
 - 상담자는 자신의 그 어떤 반응도 내담자의 상담 목표를 성취하려는 소망에서 나온 것이지 개인적인 기분이나 소망 또는 판단에서 나오는 것이 아님을 분명히 해둘 필요
- 내담자에게 반응할 기회를 충분히 주기
 - 상담자가 말한 것에 내담자가 반응할 기회를 주는 것이 중요
 - 상담자는 내담자에게서 직접적인 피드백을 받기가 어렵기 때문에 내담자가 반응할 기회를 최대한 주도록 노력할 필요
 - '제가 좀 전에 말한 것에 대해 당신이 어떤 느낌이 드는지 말씀해 주시면 좋겠습니다.', '혹시 제가 잘 못 알고 있는 것이 있을까요?' 등의 질문이 도움이 됨

상담과정 모델과 단계 / 9주차 2차시

1. 상담과정 모델

그림1. 상담과정의 모형도



1) 문제평가

- 내담자가 왜 그리고 어떻게 상담실에 오게 되었는지 확인: 상담 동기, 기대 명료화

- 상담목표를 어떻게 설정하며, 각 목표들을 달성하기 위해 어떻게 해야할지 정하기: 내담자에 관한 자료 수집 필요

2) 목표설정 및 역할교육

- 문제들 중 어느 문제를 먼저 다룰 것인지를 내담자와 협의, 결정할 필요
- 상담시간, 상담기간, 상담비 등의 상담절차와 내담자가 준수해야 할 사항을 분명하게 정하여 전달할 필요
- 내담자가 실제 상담에서 이루어지는 것과 동떨어진 기대를 갖을 수 있기 때문에, 효과적인 상담을 위한 바람직한 기대와 역할을 하도록 내담자를 '교육'하는 것이 필요

3) 1차 상담노력

- 내담자의 세계관을 변화시키거나 명료화시키는 인지 재구성
- 세계에 대한 내담자의 환경대처행동을 변화시키거나 효율적으로 수정하는 행동반응의 조정
- 내담자의 인간관계 환경의 변화 등

(1) 인지 재구성

- 생활경험에 영향을 주는 내담자의 인지구조를 변화시키고 대안을 발견하려는 상담 노력

(2) 행동반응의 조정

- 내담자의 행동양식 중에서 바람직하지 못한 반응의 빈도를 줄이는 반응감축, 바람직한 반응의 빈도를 늘이는 반응증대, 그리고 새로운 반응을 훈련시키는 반응습득의 세 가지
 - 반응감축: 내담자의 반응양식 중 어떤 것이 바람직하지 못하여 변화되어야 할 반응인가를 구체적으로 규정
 - 반응증대: 바람직한 반응의 빈도를 촉진. 내담자의 어떤 반응이 증대되어야 할 것인지를 결정한 다음에는 그 반응을 유지 또는 보강할 수 있는 효과적인 강화요인을 주의해서 선택
 - 반응습득: 내담자가 갖추지 못하고 있거나 실천하지 못하고 있는 반응을 발견하여 훈련하는 것

(3) 환경의 조성

- 생활환경이 내담자의 행동에 미치는 영향이 크기 때문에 상담만으로 불충분한 경우가 많음
- 내담자에게 도움이 될 지역사회 내의 가능한 모든 사회기관 활용
- 내담자의 문제를 실질적으로 유지, 강화하고 있는 주위의 주요 인간관계를 조정

4) 2차 상담노력

- 1차 상담노력으로 최초로 설정한 상담목표와 관련해 만족스러운 상담결과를 얻은 것으로 합의가 되면 종결노력으로 연결
- 보통은 1차 상담노력만으로 불충분, 2차 상담노력까지 필요
- 1차 상담결과로 나타나는 내담자의 불만족은 저항과 상통하는 개념.
- 내담자가 구두로 보고하는 불만족이나 행동으로 나타나는 저항들은 내담자의 주관적 갈등이

아니면 상담자와의 관계 및 환경적 요인과 관련된 것으로 보는 것이 타당

- 이러한 저항을 다루기 위해 내담자가 상담자를 어떻게 보는지, 상담자를 보고 어떤 사람을 떠올리는지, 상담자와의 관계에 대한 느낌 및 기대 등의 측면을 탐색할 필요

5) 종결노력

- 설정한 목표수준에 따라 내담자와 구체적으로 검토해 결정

2. 상담과정의 단계

1) 1단계: 문제 및 상담의 필요성에 대한 인식

- 내담자의 문제, 걱정, 찾아온 이유를 탐색
- 내담자로 하여금 자기가 말하고 싶은 것을 안심하고 이야기할 수 있는 분위기의 조성
- 내담자로 하여금 상담자가 경청하고 있고 그의 말을 이해하고 있음을 인식하도록 하는 것

2) 2단계: 촉진적 관계의 형성

- 솔직하고 신뢰로운 관계형성
- 내담자가 상담자에게 느끼는 전문적 숙련성, 매력, 신뢰성 등은 상담효과에 대한 긍정적 기대를 갖게 하는 요인
- 촉진적 관계 형성을 위해 공감적 이해, 성실한 자세, 내담자에 대한 수용적 존중 및 적극적인 경청 등이 필요

3) 3단계: 목표설정과 구조화

- 상담과정의 방향과 골격을 분명히 함
- 구조화는 상담의 효과를 최대한도로 높이기 위해 상담의 기본성격, 상담자 및 내담자의 역할한계, 바람직한 태도 등을 설명하고 인식시켜 주는 작업
- 구조화에 포함될 사항
 - 상담의 성질, 상담자의 역할과 책임, 내담자의 역할과 책임, 상담의 목표 등
- 내담자의 어떤 기대는 상담과정을 촉진하지만, 어떤 기대는 상담과정을 방해
- 내담자의 기대가 장애가 될 때에는 상담자가 이를 표면화하여 솔직하게 다룰 필요
- 바람직한 기대
 - 자기의 문제를 솔직하게 말하기
 - 상담과정에서 적극적인 참여자라는 인식
 - 상담은 자기검토와 자기성찰의 과정이라는 것
 - 상담자는 문제를 해결해주는 것이 아니라 내담자 스스로 해결하도록 돕는다는 것 등
- 비생산적인 태도와 행동경향
 - 도움의 책임이 상담자에게만 있다거나, 상담자의 전문적인 지시를 받는 수동적 입장이라고

여기거나, 자기성찰의 필요가 없다고 여기는 것.

- 침묵하거나 저항적인 태도, 회피하려는 태도
- 바람직하지 못한 기대
 - 상담자가 내담자의 문제를 해결하고 치료해줄 것이라는 기대.
 - 상담과정은 관계된 모든 사람들이 적극적으로 참여하고, 참여책임을 받아들이는 때에만 잘 진행되는 것.
 - 내담자는 상담자의 전문적 노력에만 의존하는 단순한 수혜자가 아님
 - 또는 상담자로부터 별을 받을지도 모른다는 예상을 하고 내방하는 경우
- 도움을 청하는 이유
 - 자발적으로 상담에 내방했는지, 비자발적으로 상담자를 찾았는지가 상담의 내용에 큰 영향.
 - 그러나 상담과정의 단계는 비슷

4) 4단계: 문제해결의 노력

- 문제에 대해 명확히 정의
- 문제해결을 위한 방향과 가능한 방안을 정함
- 문제해결방안에 관련된 정보 수집
- 수집된 자료를 바탕으로 대처행동 의논
- 검사와 심리진단자료 등을 참고로 바람직한 행동절차 및 의사소통의 실제 계획을 수립
- 계획된 것을 실제 생활과정에서 실천
- 실천결과를 평가하고 행동계획을 수정, 보완

5) 5단계: 자각과 합리적 사고의 촉진

- 자각은 자신과 생활과정에서의 주요 경험 및 사건들을 이전보다 분명히 그리고 통합된 시야에서 재인식
- 이 단계에서 고려할 것은 내담자가 자기탐색 및 사고방식의 변화요구에 대한 심리적 부담 때문에 상담을 중단하려고 하거나 직간접의 저항이 발생할 수 있음
- 이러한 저항은 의사소통, 내담자-상담자 개념 차이 등의 차원에서 탐색 및 조정 필요

6) 6단계: 실천행동의 계획

- 내담자의 새로운 견해나 인식이 실생활에서 실현되도록 내담자의 의사결정이나 행동계획을 도울 필요
- 이 단계에서 이루어야 할 목표는 내담자의 구체적인 행동절차를 협의하고 세부적인 행동계획을 작성

7) 7단계: 실천결과의 평가와 종결

- 종결은 내담자-상담자 합의에 의해 이루어짐
- 내담자가 종결을 희망하더라도 불충분하다는 판단이 들 경우 권유할 수 있음
- 상담 종결이 갑자기 이루어질 경우 발생할 수 있는 문제를 최소화하기 위해 2주 또는 3주 간격으로 상담간격을 조정할 수 있음
- 종결에 앞서 그 동안 성취한 것들을 상담목표에 비추어 평가하거나 목표에 도달하지 못한 이유를 토의할 필요
- 종결 후에 문제가 생기면 다시 찾아올 수 있도록 추수상담의 가능성 제시
- 상담결과가 만족스럽지 못한 경우에는 상담과 상담자의 한계에 대해 명확히 밝히고, 필요하다면 다른 기관이나 다른 상담자에게 의뢰
- 내담자에 의해 조기 종결될 경우, 상담에 대한 내담자의 이야기를 충분히 할 수 있도록 도움
- 상담자에 의해 조기 종결될 경우, 이에 대한 내담자의 감정을 다루고, 종결에 따른 사후 대책을 의논할 필요

상담자 윤리 / 10주차 1차시

1. 한국상담심리학회 윤리강령

1) 전문가로서의 태도

(1) 가. 전문적 능력

1. 상담심리사는 자기 능력의 한계를 인정하고 교육과 수련, 경험 등에 의해 준비된 역량의 범위 안에서 전문적인 서비스와 교육을 제공함.
2. 상담심리사는 자신이 가진 능력 이상의 것을 주장하거나 암시해서는 안 되며, 타인에 의해 능력이나 자격이 오도되었을 때에는 수정해야 할 의무가 있음
3. 상담심리사는 문화, 신념, 종교, 인종, 성적 지향, 성별 정체성, 신체적 또는 정신적 특성에 대한 자신의 편견을 자각하고, 이를 극복하기 위해 노력해야 함. 특히 위와 같은 편견이 상담 과정을 방해할 우려가 있을 경우 자문, 사례지도 및 상담을 요청해야 함.
4. 상담심리사는 자신의 활동분야에 있어서 최신의 과학적이고 전문적인 정보와 지식을 유지하기 위해 지속적인 교육과 연수의 필요성을 인식하고 참여함.
5. 상담심리사는 자신의 전문적 능력에 대해 정확히 인식하고 정기적으로 전문인으로서의 능력과 효율성에 대해 자기점검 및 평가를 해야 함. 상담자로서 직무를 수행하는데 방해가 되는 개인적 문제나 능력의 한계를 인식하게 될 경우 지도감독이나 전문적 자문을 받을 책무가 있음

(2) 나. 성실성

1. 상담심리사는 자신의 신념체계, 가치, 제한점 등이 상담에 미칠 영향력을 자각해야 함.
2. 상담심리사는 내담자에게 상담의 목표와 이점, 한계와 위험성, 상담료 지불방법 등을 명확히 알림.
3. 상담심리사는 능력의 한계나 개인적인 문제로 내담자를 적절하게 도와줄 수 없을 때, 전문적 자문과 지원을 받는 등의 적절한 조치를 취한 뒤, 직무수행을 제한할지 아니면 완전히 중단할지 여부를 결정해야 함.
4. 상담심리사는 자신의 질병, 죽음, 이동, 퇴직으로 인한 상담의 갑작스런 중단가능성에 대비하고 있어야 하며, 또한 내담자의 이동이나 재정적 한계 등과 같은 요인에 의해 상담이 중단될 경우, 이에 대해 적절한 조치를 취해야 함.
5. 상담심리사는 내담자가 더 이상 도움을 필요로 하지 않거나, 상담을 지속하는 것이 더 이상 내담자에게 도움이 될 가능성이 없거나, 오히려 내담자에게 해가 될 것이 분명하다면 상담 관계를 종결해야 함. 내담자가 다른 전문가를 필요로 할 경우에는 적절한 과정을 거쳐 의뢰하거나 관련 정보를 제공함.
6. 상담심리사는 개인의 이익을 위해 상담전문직의 가치와 품위를 훼손하는 행동을 해서는 안 됨
7. 상담심리사는 자신이 지도감독 내지 평가 하거나 기타의 권위를 행사하는 대상, 즉 내담자, 학생, 수련생, 연구 참여자 및 피고용인을 물질적, 신체적, 업무상으로 착취하지 않음.
8. 상담심리사는 자신의 기술이나 자료가 다른 사람들에게 의해 오용될 가능성이 있는 활동에 참여해서는 안되며, 이런 일이 일어난 경우에는 이를 바로잡거나 최소화하는 조치를 취함.

(3) 다. 자격관리

1. 상담심리사는 자신의 자격급수와 상담경력을 정확히 알려야 하며, 자신의 자격을 과장하지

않음.

2. 상담심리사는 자신이 상담 관련 분야에서 취득한 최종 학위 및 전공을 정확히 명시하고, 그 이외의 분야에서 취득한 학위가 있더라도 그것을 마치 상담 관련 학위인 것처럼 알리지 않음.
3. 상담심리사는 자신의 전문자격을 유지하기 위하여 지속적인 교육, 연수를 받아야 함. 만약 자격이 정지되었을 경우에는 이에 따른 책임을 지며 자격을 회복하기 위해 노력함.

2) 사회적 책임

(1) 가. 사회와의 관계

1. 상담심리사는 사회의 윤리와 도덕기준을 존중하고, 사회공익과 상담분야의 발전을 위해 최선을 다함.
2. 상담심리사는 필요시 무료 혹은 저가의 보수로 자신의 전문성을 제공하는 사회적 공헌 활동에 참여함.
3. 상담비용을 책정할 때 상담심리사들은 내담자의 재정상태를 고려하여야 함. 책정된 상담료가 내담자에게 적절하지 않을 때에는, 대안적 서비스를 받을 수 있도록 도움.
4. 상담심리사는 상담자 양성에 도움이 되는 다양한 전문적 활동에 참여함.

(2) 나. 고용 기관과의 관계

1. 상담심리사는 자신이 종사하는 기관의 목적과 방침에 공헌할 수 있는 활동을 할 책임이 있음. 기관의 목적과 방침이 상담자 윤리와 상충될 때에는 이를 해결하기 위해 노력해야 함.
2. 상담심리사는 근무기관의 관리자 및 동료들과 상담업무, 비밀보장, 직무에 대한 책임, 공적 자료와 개인자료의 구별, 기록된 정보의 보관과 처분에 관하여 상호 협의해야 함. 상호 협의한 관계자들은 협의 내용을 문서화하고 공유함.
3. 상담심리사는 자신이 속한 기관의 효율성에 제한을 줄 수 있는 상황에 대해 미리 알려주어야 함.

(3) 다. 상담 기관 운영자

1. 상담기관 운영자는 기관 내에서 이루어지는 제반 상담활동을 관리 감독함에 있어, 내담자의 권리와 복지를 최우선으로 고려해야 함.
2. 상담기관 운영자는 방음, 편안함, 주의집중 등을 고려하여 상담 및 심리평가에 적합한 독립된 공간을 제공해야 함.
3. 상담기관 운영자는 상담심리사를 포함한 피고용인의 권리와 복지 보장 및 전문성 제고를 위해 최선의 노력을 다 할 책임이 있음.
4. 상담기관 운영자는 업무에 적합한 전문성을 갖춘 상담심리사를 고용하고, 이들의 증명서, 자격증, 업무내용, 기타 상담자와 관련된 다른 정보 등을 정확하게 파악하고 관리하여야 함.
5. 상담기관 운영자는 직원들에게 기관의 목표와 활동에 대해 알려주어야 함.
6. 상담기관 운영자는 고용, 승진, 인사, 연수 및 지도 시에 성별, 장애, 나이, 성적 지향, 성별 정체성, 사회적 신분, 외모, 인종, 가족형태, 종교 등을 이유로 차별적인 행동을 해서는 안 됨.
7. 상담기관 운영자는 고용을 빌미로 상담심리사가 원치 않는 유료 상담, 유료 교육, 내담자 모집을 강제해서는 안 됨.

(4) 라. 다른 전문직과의 관계

1. 상담심리사는 함께 일하는 다른 전문직 집단의 특성을 존중하고, 상호 협력적 관계를 도모함.
2. 공적인 자리에서 개인 의견을 말할 경우, 상담심리사는 그것이 개인적 의견에 불과하며 상담심리사 전체의 견해나 입장이 아님을 분명히 해야 함.
3. 상담심리사는 내담자가 다른 정신건강 전문가의 서비스를 받고 있음을 알게 되면, 내담자로 하여금 상담 사실을 그 전문가에게 알리도록 권유하고, 긍정적이고 협력적인 치료관계를 맺도록 노력함.

4. 상담심리사는 내담자 의뢰나 소개와 관련한 비용을 수취하거나 요구하지 않음.

(5) 마. 자문

1. 자문이란 개인, 집단, 사회단체가 전문적인 조력자의 도움이 필요하여 요청한 자발적인 관계를 말함. 상담심리사는 자문을 요청한 개인이나 기관의 문제 혹은 잠재된 문제를 규명하고 해결하는데 도움을 줌.
2. 상담심리사는 자신이 자문에 참여하는 개인 또는 기관에게 도움을 주는데 필요한, 자질과 능력을 갖추었는지를 스스로 검토하고 자문에 임해야 함.
3. 상담심리사는 자문에 임할 때 자신의 가치관, 지식, 기술, 한계성이나 욕구에 대한 깊은 자각이 있어야 하고, 자문의 초점은 문제를 가진 사람이 아니라 풀어나가야 할 문제 자체에 두어야 함.
4. 자문 관계는 자문 대상자가 스스로 성장해 나가도록 격려하고 고양하는 것이어야 함. 상담심리사는 이러한 역할을 일관성 있게 유지해야 하고, 자문 대상자가 스스로의 의사결정자가 되도록 도와주어야 함.
5. 상담활동에서 자문의 활용에 대해 홍보할 때는 학회의 윤리강령을 성실하게 준수해야 함.

(6) 라. 홍보

1. 상담심리사는 전문가로서의 자신의 자격과 상담경력에 대해 대중에게 정확하게 홍보해야 하며, 오해를 일으킬 수 있거나 거짓된 내용을 전달해서는 안 됨.
2. 상담심리사는 일반인들에게 상담의 전문적 활동이나 상담 관련 정보, 기대되는 상담효과 등을 정확하게 알려주어야 함.
3. 상담심리사는 출판업자, 언론인, 혹은 후원사 등이 상담의 실재나 전문적인 활동과 관련된 잘못된 진술을 하는 경우 이를 시정하고 방지하도록 노력함.
4. 상담심리사가 워크숍이나 상담 프로그램을 홍보할 때는 참여자의 선택을 위해서 정확한 정보를 제공해야 함.
5. 상담심리사는 상담자의 품위를 훼손하지 않도록 책임의식을 가지고 홍보해야 함.
6. 상담심리사는 홍보에 활용하기 위하여 내담자에게 소감문 작성이나 사진 촬영 등을 강요하지 않음.
7. 상담심리사는 자신이 실제로 상담 및 자문 활동을 하지 않는 상담기관이 자신의 이름을 기관의 홍보에 사용하지 않도록 해야 함.

3) 내담자의 복지와 권리에 대한 존중

(1) 가. 내담자 복지

1. 상담심리사의 일차적 책임은 내담자의 복지를 증진하고 존엄성을 존중하는 것임.
2. 상담심리사는 내담자의 잠재력을 개발하여 건강한 삶을 영위하도록 도움을 주며, 어떤 방식으로든 해를 끼치지 않음.
3. 상담심리사는 상담관계에서 오는 친밀성과 책임감을 인식해야 함. 상담심리사의 개인적 욕구충족을 위해서 내담자를 희생시켜서는 안 되며, 내담자로 하여금 의존적인 상담관계를 형성하지 않도록 노력해야 함.
4. 상담심리사는 직업 문제와 관련하여 내담자의 능력, 일반적인 기질, 흥미, 적성, 욕구, 환경 등을 고려하면서 내담자와 함께 노력하지만, 내담자의 일자리를 찾아주거나 근무처를 정해줄 의무가 있는 것은 아니다.

(2) 나. 내담자의 권리와 사전 동의

1. 내담자는 상담 계획에 참여할 권리, 상담을 거부하거나 상담 개입방식의 변화를 거부할 권리, 그러한 거부에 따른 결과에 대해 고지 받을 권리, 자신의 상담 관련 정보를 요청할 권리 등이

있음.

2. 상담심리사는 상담을 시작할 때 내담자가 충분한 설명을 듣고 선택할 수 있도록 적절한 정보를 제공해야 하고, 상담자와 내담자 모두의 권리와 책임에 대해서 알려줄 의무가 있음. 이러한 사전 동의 절차는 상담과정의 중요한 부분이며, 내담자와 논의하고 합의된 내용을 적절하게 문서화함.
3. 상담심리사가 내담자에게 설명해야 할 사전 동의 항목으로는 상담자의 자격과 경력, 상담 비용과 지불 방식, 치료기간과 종결 시기, 비밀보호 및 한계 등이 있음.
4. 상담심리사는 내담자에게 상담 과정의 녹음과 녹화 가능성, 사례지도 및 교육에의 활용 가능성에 대해 설명하고, 내담자에게 동의 또는 거부할 권리가 있음을 알려야 함.
5. 내담자가 미성년자 혹은 자발적인 동의를 할 수 없는 경우, 상담심리사는 내담자의 최상의 복지를 고려하여, 보호자 또는 법정 대리인의 사전 동의를 구해야 함.
6. 상담심리사는 미성년인 내담자를 상담할 때, 필요하면 부모나 보호자가 상담에 참여 할 수 있음을 내담자에게 알림. 이 경우, 상담자는 부모 혹은 보호자의 참여에 앞서 그 영향을 고려하고 내담자의 권익을 보호하도록 함.

(3) 다. 다양성 존중

1. 상담심리사는 모든 인간의 기본적인 권리, 존엄성, 가치를 존중하며 성별, 장애, 나이, 성적 지향, 성별 정체성, 사회적 신분, 외모, 인종, 가족형태, 종교 등을 이유로 내담자를 차별하지 않음.
2. 상담심리사는 내담자의 다양한 문화적 배경을 이해하려고 적극적으로 시도해야 하며, 상담심리사 자신의 고유한 문화적 정체성이 상담과정에 어떤 영향을 주는지 인식해야 함.
3. 상담심리사는 자신의 고유한 가치, 태도, 신념, 행위를 인식하고, 내담자에게 자신의 가치를 강요하지 않음.

4) 상담관계

(1) 가. 다중 관계

1. 상담심리사는 객관성과 전문적인 판단에 영향을 미칠 수 있는 다중 관계는 피해야 함. 가까운 친구나 친인척, 지인 등 사적인 관계가 있는 사람을 내담자로 받아들이면 다중 관계가 되므로, 다른 전문가에게 의뢰하여 도움을 줌. 의도하지 않게 다중 관계가 시작된 경우에도 적절한 조치를 취해야 함.
2. 상담심리사는 상담 할 때에 내담자와 상담 이외의 다른 관계가 있다면, 특히 자신이 내담자의 상사이거나 지도교수 혹은 평가를 해야 하는 입장에 놓인 경우라면 그 내담자를 다른 전문가에게 의뢰함.
3. 상담심리사는 내담자와 상담실 밖에서 연애 관계나 기타 사적인 관계(소셜미디어나 다른 매체를 통한 관계 포함)를 맺거나 유지하지 않음.
4. 상담심리사는 내담자와의 관계에서 상담료 이외의 어떠한 금전적, 물질적 거래를 해서는 안 됨.
5. 상담심리사는 내담자의 선물로 인해 발생할 수 있는 문제를 숙고해야 함. 선물의 수령 여부를 결정함에 있어서 상담 관계에 미치는 영향, 선물의 의미, 내담자와 상담자의 동기, 현행법 위반 여부 등을 신중하게 고려해야 함.

(2) 나. 성적 관계

1. 상담심리사는 내담자 및 내담자의 보호자, 친척 또는 중요한 타인에게 자신의 지위를 이용하여 성희롱 또는 성추행을 포함한 성적 접촉을 해서는 안 됨.
2. 상담심리사는 내담자 및 내담자의 보호자, 친척, 또는 중요한 타인과 성적 관계를 가져서는 안 됨.

3. 상담심리사는 이전에 연애 관계 또는 성적인 관계를 가졌던 사람을 내담자로 받아들이지 않음
 4. 상담심리사는 상담관계가 종결된 이후 적어도 3년 동안은 내담자와 성적 관계를 맺지 않아야 함. 그 후에도 가능하면 내담자와 성적인 관계는 갖지 않음.
- (3) 다. 여러 명의 내담자와의 관계
1. 상담심리사가 두 명 이상의 사람들에게 상담 서비스를 제공하는 경우 (예: 남편과 아내, 부모와 자녀), 누가 내담자이며 각각의 사람들과 어떤 관계를 맺어갈지를 명확히 하고 상담을 시작해야 함.
 2. 만약에 상담심리사가 내담자들 사이에서 상충되는 역할을 해야 된다면, 상담심리사는 그 역할에 대해서 명확히 하거나, 조정하거나, 그 역할로부터 벗어나도록 함.
- (4) 라. 집단상담
1. 상담심리사는 집단 목표에 부합하는 집단원들을 모집하여 집단상담이 원활히 진행되도록 함.
 2. 상담심리사는 집단참여자를 물리적 피해나 심리적 외상으로부터 보호하기 위해 충분한 주의를 기울임.
 3. 집단리더는 지위를 이용하여 집단원의 권리와 복지를 훼손하지 않음. 또한, 집단 과정에서 집단원의 선택의 자유를 존중하고, 이들이 집단 압력으로부터 보호 받을 권리가 있음을 유념함.
 4. 집단 리더는 다중관계가 될 수 있는 가까운 친구나 친인척, 지인 등을 집단원으로 받아들이지 않음. 또한, 집단상담이 끝난 후 집단원과 사적인 관계를 맺거나 유지하지 않음.

5) 정보의 보호 및 관리

(1) 가. 사생활과 비밀보호

1. 상담심리사는 상담과정에서 알게 된 내담자의 민감 정보를 다룰 때 특별히 주의해야 하고, 상담과 관련된 모든 정보의 관리에 있어 개인정보 보호와 관련된 법을 준수해야 함.
2. 상담심리사는 사생활과 비밀유지에 대한 내담자의 권리를 최대한 존중해야 할 의무가 있음.
3. 내담자의 사생활 보호에 대한 권리는 존중되어야 하나, 때로 내담자나 내담자가 위임한 법정 대리인의 요청에 의해 제한될 수 있음.
4. 내담자의 사생활 보호가 제한되는 경우라 하더라도, 상담심리사는 내담자의 사생활 침해를 최소화하기 위해 노력해야 하고, 문서 및 구두 보고 시 사생활에 관한 정보를 포함시켜야 할 경우 그 목적과 밀접한 관련이 있는 정보만을 포함시킴.
5. 상담심리사는 강의, 저술, 동료자문, 대중매체 인터뷰, 사적 대화 등의 상황에서 내담자의 신원확인이 가능한 정보나 비밀 정보를 공개하지 않음.
6. 상담심리사는 상담 기관에 소속된 모든 구성원과 관계자들에게도 내담자의 사생활과 비밀이 보호되도록 주지시켜야 함.

(2) 나. 기록

1. 상담기관이나 상담심리사는 상담의 기록, 보관 및 폐기에 관한 규정을 마련하고 준수해야 함.
2. 상담심리사는 법, 규정 혹은 제도적 절차에 따라, 상담기록을 일정기간 보관함. 보관 기간이 경과된 기록은 파기해야 함.
3. 공공기관이나 교육기관 등은 각 기관에서 정한 기록 보관 연한을 따르고, 이에 해당하지 않는 경우에는 3년 이내 보관을 원칙으로 함.
4. 상담심리사는 상담의 녹음 및 기록에 관해 내담자의 동의를 구함.
5. 상담심리사는 면접기록, 심리검사자료, 편지, 녹음 파일, 동영상, 기타 기록 등 상담과 관련된 기록들이 내담자를 위해 보존된다는 것을 인식하며, 상담기록의 안전과 비밀보호에 책임을

짐.

6. 상담심리사는 내담자가 합당한 선에서 기록물에 대한 열람을 요청할 경우, 열람할 수 있도록 함. 단, 상담심리사는 기록물에 대한 열람이 내담자에게 해악을 끼친다고 사료될 경우 내담자의 기록 열람을 제한함.
7. 상담심리사는 내담자의 기록 열람에 대한 요청을 문서화하며, 기록의 열람을 제한할 경우, 그 이유를 명기함.
8. 복수의 내담자의 경우, 상담심리사는 각 개별 내담자에게 직접 해당되는 부분만을 공개하며, 다른 내담자의 정보에 관련된 부분은 노출되지 않도록 함.
9. 상담심리사는 기록과 자료에 대한 비밀보호가 자신의 죽음, 능력상실, 자격박탈 등의 경우에도 보호될 수 있도록 미리 계획을 세움.
10. 상담심리사는 상담과 관련된 기록을 보관하고 처리하는데 있어서 비밀을 보호해야 하며, 이를 타인에게 공개할 때에는 내담자의 직접적인 동의를 받아야 함.

(3) 다. 비밀보호의 한계

1. 내담자의 생명이나 타인 및 사회의 안전을 위협하는 경우, 내담자의 동의 없이도 내담자에 대한 정보를 관련 전문인이나 사회에 알릴 수 있음.
2. 내담자가 감염성이 있는 치명적인 질병이 있다는 확실한 정보를 가졌을 때, 상담심리사는, 그 질병에 위험한 수준으로 노출되어 있는 제 삼자(내담자와 관계 맺고 있는)에게 그러한 정보를 공개할 수 있음. 상담심리사는 제 삼자에게 이러한 정보를 공개하기 전에, 내담자가 자신의 질병에 대해서 그 사람에게 알렸는지, 아니면 스스로 알릴 의도가 있는지를 확인함.
3. 법원이 내담자의 동의 없이 상담심리사에게 상담관련 정보를 요구할 경우, 상담심리사는 내담자의 권익이 침해되지 않도록 법원과 조율하여야 함.
4. 상담심리사는 내담자 정보를 공개할 경우, 정보 공개 사실을 내담자에게 알려야 함. 정보 공개가 불가피할 경우라도 최소한의 정보만을 공개함.
5. 여러 전문가로 구성된 팀이 개입하는 상담의 경우, 상담심리사는 팀의 존재와 구성을 내담자에게 알림.
6. 비밀보호의 예외 및 한계에 관한 타당성이 의심될 때에 상담심리사는 동료 전문가 및 학회의 자문을 구함.

(4) 라. 집단상담과 가족상담

1. 집단 상담을 할 경우, 상담심리사는 그 특정 집단에 대한 비밀 보장의 중요성과 한계를 명백히 설명함.
2. 가족상담에서 상담심리사는 각 가족 구성원의 사생활 보호에 대한 권리를 존중함. 한 가족 구성원에 대한 정보는, 해당 구성원의 허락 없이는 다른 구성원에게 공개될 수 없음. 단, 미성년자 혹은 심신미약자가 포함된 경우, 이들에 대한 비밀보장은 위임된 보호자에 의해 제한될 수 있음.

(5) 마. 상담 외 목적을 위한 내담자 정보의 사용

1. 교육이나 연구 또는 출판용 목적으로 상담관계로부터 얻어진 자료를 사용할 때에는 내담자의 동의를 구해야 하며, 각 개인의 익명성이 보장되도록 자료 변형 및 신상 정보의 삭제와 같은 적절한 조치를 취하여 내담자에게 피해를 주지 않도록 함.
2. 다른 전문가의 자문을 구할 경우, 상담심리사는 사전에 내담자의 동의를 구해야 하며, 적절한 조치를 통해 내담자의 사생활과 비밀을 보호하도록 노력함.

(6) 바. 전자 정보의 관리 및 비밀보호

1. 전자기기 및 매체를 활용하여 상담관련 정보를 기록·관리하는 경우, 상담심리사는 기록의 유출 또는 분실 가능성에 대해 경각심과 주의의무를 가져야 하며 내담자의 정보보호를 위해 적극적인 노력을 해야 함.

2. 내담자의 기록이 전산 시스템으로 관리되는 경우, 상담심리사는 접근 권한을 명확히 설정하여 내담자의 신상이 드러나지 않도록 조치를 취함.

6) 심리평가

(1) 가. 기본 사항

1. 심리평가의 목적은 심리검사를 활용하여 내담자의 자기이해 및 의사결정을 돕고 치료계획을 수립하는 데 있음.
2. 상담심리사는 규정된 전문적 관계 안에서만 심리검사를 활용한 진단, 평가 및 개입을 함.
3. 심리평가에 대한 상담심리사의 결과해석, 소견 및 권고는 충분한 정보와 근거를 바탕으로 이루어져야 하며, 상담심리사는 이에 대한 내담자의 알권리를 존중함.
4. 상담심리사는 심리검사의 결과나 해석을 오용해서는 안 되며, 전문적 자격을 갖추지 않은 사람에 의한 심리검사의 개발, 출판, 배포, 사용에 대해서는 적절한 조치를 취함.
5. 상담심리사는 내담자 혹은 내담자의 법정대리인의 동의가 있는 경우에만 내담자의 개인정보가 포함된 심리평가 관련 자료를 공개함. 단, 공개 대상은 자료를 해석할만한 충분한 자격을 갖춘 전문가로 제한함.

(2) 나. 검사를 사용하고 해석하는 능력

1. 상담심리사는 심리평가를 수행함에 있어 평가 도구의 채점, 해석과 사용, 관리에 대한 책임이 있으며, 자신이 훈련받은 검사와 평가만을 수행해야 함. 이는 온라인 검사의 경우에도 해당됨.
2. 상담심리사는 검사도구의 타당도와 신뢰도, 검사도구의 개발과 사용 지침에 대해 이해하고 있어야 함.
3. 상담심리사는 검사의 실시, 채점 및 해석이 제공되는 온라인 검사의 경우에도 원 검사의 구성 및 해석에 대해 숙지하고 있어야 함.
4. 상담심리사는 수련생이 심리검사를 유능하게 수행할 수 있는지 지속적으로 감독해야 함.

(3) 다. 사전 동의

1. 상담심리사는 심리평가 전에 내담자 또는 내담자의 법정 대리인에게 사전 동의를 받아야 함. 사전 동의를 구할 때에는 검사의 목적과 용도, 비용에 대해 내담자가 이해할 수 있도록 설명해야 함.
2. 상담심리사는 검사결과를 제공할 때 내담자 혹은 내담자가 사전 동의한 수령인에게 결과를 전달하고 적절한 해석을 제공해야 함. 이는 집단으로 실시된 검사도 해당됨.

(4) 라. 검사의 선택 및 실시

1. 상담심리사는 내담자에게 적절한 심리검사를 선택해야 하며 검사의 타당도와 신뢰도, 제한점 등을 고려함.
2. 상담심리사는 다문화 배경을 가진 내담자를 위한 심리검사 선택 시, 그의 사회문화적 맥락을 신중히 고려해야 함.
3. 상담심리사는 표준화된 조건에 따라 검사를 시행함. 검사가 표준화된 조건에서 시행되지 않거나, 검사 수행 중 일반적이지 않은 행동 혹은 예외적인 상황이 발생할 경우, 그러한 내용을 기록해야 하고, 그 검사결과의 타당성을 의심하거나 무효 처리할 수 있음.
4. 상담심리사는 신뢰할 수 있는 검사결과를 얻기 위해 검사지 및 검사도구가 노출되지 않도록 주의하고 그 내용을 언급하지 않을 책임이 있음.

(5) 마. 검사 결과의 해석과 진단

1. 상담심리사는 검사 해석에 있어서 성별, 장애, 나이, 성적 지향, 성별 정체성, 사회적 신분, 외모, 인종, 가족형태, 종교 등의 영향을 고려하고, 다른 관련 요인들과 통합 비교하여 검사 결과를 해석함.

2. 상담심리사는 경험적으로 입증되지 않은 평가 도구를 사용할 경우, 그 도구를 사용하는 목적을 내담자에게 설명하고 결과 해석에 신중해야 함.
 3. 상담심리사는 정신장애에 대한 평가를 하는 경우 각별한 주의를 기울여야 함. 내담자를 위한 치료 방향, 치료 유형 및 후속조치를 결정하기 위해서 개인 면담 및 평가 방법을 신중하게 선택하고 사용함.
 4. 상담심리사는 내담자의 문제가 그가 속한 문화의 영향을 받는다는 것을 인지하고, 정신장애 진단 시 사회경제 및 문화적 경험을 고려해야 함.
 5. 상담심리사는 정신장애를 진단하는 것이 내담자나 다른 사람들에게 해가 된다고 판단할 경우, 진단 혹은 진단 결과의 보고를 유보할 수 있음. 상담자는 진단이 지니는 긍정적, 부정적 함의를 신중하게 고려함.
- (6) 바. 검사의 안전성
1. 상담심리사는 공인된 검사의 전부 또는 일부를 발행자 허가 없이 사용, 재발행, 수정하지 않음.
 2. 상담심리사는 실시한 지 오래된 검사 결과에 기초한 평가를 피하고, 시대에 뒤떨어진 검사 도구를 사용하지 않음.
 3. 상담심리사는 심리검사의 요강, 도구, 자극, 또는 문항이 대중매체, 인터넷(온라인)등을 통해 노출되지 않도록 해야 하며, 또한 특정한 반응에 대한 구체적인 해석이 대중적으로 공개되지 않도록 해야 함.

2. 상담 및 심리치료 직업윤리

- 모든 사람은 직업을 통해 충족시키고자 하는 욕구 존재
- 상담자 역시 상담관계에서 충족시키고 싶은 욕구가 있을 수 있음
- 상담자 스스로 내담자로부터 충족시키려는 욕구를 인식하여, 조절을 위한 노력이 필요. 이는 한국상담심리학회 윤리규정의 내담자의 복지와 권리에 대한 존중에서도 언급.
- 내담자와의 전문적 관계와 사적 관계를 구별할 필요. 이에 상담자는 자기개방에 관한 적절한 수준을 염두할 필요. 자기개방의 영역에는 (1) 상담자의 훈련이나 상담 실체에 대한 정보 (2) 개인 생활환경에 대한 정보 (3) 내담자에 대한 개인적 반응 (4) 상담에서 한 실수 인정하기가 있음

3. 내담자의 권리와 상담자의 책임

1) 내담자의 권리

- 내담자는 상담 계획에 참여할 권리, 상담을 거부하거나 상담 개입방식의 변화를 거부할 권리, 그러한 거부에 따른 결과에 대해 고지 받을 권리, 자신의 상담 관련 정보를 요청할 권리 등이 있음
- 내담자는 상담자의 자격과 경력, 치료기법, 비밀보호 및 한계, 치료기간과 종결 시기 등에 대해 확인할 수 있는 권리가 있음
- 내담자는 상담내용 녹음, 녹화, 사례지도 및 교육에의 활용가능성에 대해 동의 또는 거부할 권리가 있음

2) 상담자의 책임

- 상담자는 상담을 시작할 때 상담자와 내담자 모두의 권리와 책임을 알릴 의무. 내담자에게 충분히 설명하고 선택할 수 있도록 적절한 정보제공 필요
- 상담자는 내담자에게 상담자의 자격과 경력, 상담 비용과 지불 방식, 치료기간과 종결 시기, 비밀보호 및 한계 등을 알릴 필요
- 상담자와 내담자 모두의 권리와 책임에 대해 알릴 의무. 내담자와 논의하고 합의한 내용을 문서화 할 필요
- 내담자가 미성년자 혹은 자발적인 동의를 할 수 없는 경우, 상담사는 보호자 또는 법정 대리인의 사전 동의를 구해야 함

상담 슈퍼비전 / 10주차 2차시

1. 슈퍼비전의 개요

1) 슈퍼비전의 정의

- 슈퍼비전은 상담자의 상담 수행을 감독 혹은 지도하는 활동
- 전문 상담자가 되고자 하는 수련생에게 적절한 직업적 행동을 습득할 수 있도록 슈퍼바이저가 도와주는 지속적인 교육 과정
- 슈퍼비전은 수업과 실습 과정 혹은 상담 실재의 두 가지 교육 내용을 합하여 상담자가 실제적 지식을 습득할 수 있도록 도와주는 것

2) 슈퍼비전의 목적

(1) 내담자 보호

- 슈퍼비전은 효과적이지 않은 상담으로부터 내담자를 보호
- 내담자가 효과적인 상담을 제공받게 하려면 슈퍼비전은 상담 경험과 기술이 부족한 상담자(초보 상담자 혹은 처음 상담 실습을 시작한 대학원생 상담자)로부터 내담자를 보호.
- 손상된 상담자로부터 내담자를 보호.
 - 손상된 상담자란 상담자의 실제 능력 면에서는 내담자에게 효과적인 도움을 줄 수 있으나, 현재 개인적인 문제로 인하여 일시적으로 자신의 기능을 충분히 발휘하지 못하는 상담자.
 - 이런 경우 슈퍼바이저는 슈퍼비전 시간에 상담자 개인의 문제를 다룰 수 있음

(2) 상담자 발달

- 슈퍼비전은 상담자에게 전문 상담자로서 필요한 능력을 습득하게 하고, 그 능력을 직업적 발달 단계에 맞추어 발전할 수 있도록 하는 것을 목적
- 상담자 발달의 궁극적 목표는 임상 장면에서의 지혜를 획득하는 것.
 - 임상 장면에서의 지혜란 상담자가 모호한 상태, 즉 내담자의 정보가 부족한 상태에서도 임상적으로 적절한 결정을 내릴 수 있는 전문가로서의 능력

2. 슈퍼비전 이론적 모델

1) 심리역동적 슈퍼비전

(1) 평행과정 모델

- 심리역동적 슈퍼비전 모델 중 최근의 모델은 평행과정 모델
- 평행과정 모델은 슈퍼비전에서 일어나는 역동을 상담 혹은 치료 장면에서 일어나는 역동의 반복
- 즉 슈퍼바이저와 수퍼바이지 사이에서 내담자와 수퍼바이지 사이의 역동이 재현

- 평행과정은 양방향에서 발생할 수 있음
- 평행과정 모델의 장점
 - 수퍼바이저가 내담자와 수퍼바이저와의 관계에서 역동이 평행 또는 반복되는 성향이 있다는 것을 이해하고, 내담자의 부적응이 어떻게 발달했는가를 이해
 - 수퍼바이저 자신이 치료적 과정에 대한 이해가 증가하면서, 수퍼바이저가 치료적 수련생을 대하듯이 내담자에게 더 치료적으로 대할 수 있음

(2) 작업동맹 모델

- 최근의 심리역동적 수퍼비전의 모델
- 작업동맹은 세 가지 차원으로 구성
- 첫 번째는 정서적 유대로, 수퍼바이저와 수련생 사이의 정서적 유대감 및 신뢰를 의미.
 - 수퍼바이저와 수퍼바이저 사이의 정서적 유대는 서로의 애착 유형에 의해 결정
- 둘째는 목표에 대한 합의로, 수퍼바이저가 수퍼비전을 통해 얻고자 하는 것과 수퍼바이저가 수련생이 수퍼비전을 통해 얻어야 한다고 믿는 목표에 대한 동의 정도.
 - 수퍼바이저와 수퍼바이저가 서로 다른 기대하고 있다면, 수퍼비전에 대한 서로의 기대가 일치하도록 초기에 타협과 조정 필요
- 셋째는 과제에 대한 합의로 수퍼바이저와 수련생이 이미 동의한 수퍼비전 목표를 달성하기 위해 구체적으로 어떤 일을 해야 하는가에 동의하는 정도

2) 인간중심 수퍼비전

- 인간중심적 상담접근에 근거
- 인간중심적 상담의 창시자인 Rogers는 이전의 수퍼비전이 수련생의 자기 보고로만 이루어졌던 것이 비해, 상담 축어록과 회기 녹음을 이용하는 등 수퍼비전의 새로운 방향을 제시
- 인간중심 상담에서 상담자가 내담자에게 자기실현 경향이 있음을 확신하듯이, 상담자가 성장하고 상담 및 자신에 관해 탐구하고자 하는 능력과 동기를 가지고 있음을 확신
- 인간중심 수퍼비전의 목적인 상담자의 자신감, 자신에 대한 이해, 치료적 과정에 대한 이해 등 상담자의 성장을 돕는 것
- 수퍼바이저는 수퍼바이저에게 모델이 되어 통합되고 촉진적이고 비지시적인 상담자의 행동을 시범으로 보여줌으로써 수련생이 배울 수 있도록 도움
- 수퍼바이저가 수퍼바이저의 잠재력에 대한 믿음을 가지며, 수퍼바이저가 수퍼비전 경험을 통해 내담자와 같은 경험을 하고, 상담자가 수퍼바이저에게 어떻게 반응해야 하는지 알게 되는 것이 장점

3) 인지-행동주의 수퍼비전

- 능숙한 상담자의 수행은 학습된 기술에서 비롯된다는 관점.
- 이에 수퍼비전의 목적은 적합한 상담자 행동을 가르치고 부적합한 행동을 제거하는 것
- 상담자의 전문가 역할을 특정 기술을 필요로 하는 확인 가능한 과제로 구성되어 있다는 점에서

교육과 슈퍼비전은 이러한 기술들을 발달시키고, 적용시키고, 기술 사용을 세련되게 함으로써 수련생을 도울 필요

- 상담 기술은 행동적으로 정의될 수 있으며 학습 이론의 적용이 가능

(1) 인지-행동주의 슈퍼비전 과정

- ① 슈퍼바이저와 슈퍼바이지 사이의 관계성 확립
- ② 슈퍼바이지의 기술에 대한 분석과 평가
- ③ 슈퍼비전 목표의 설정
- ④ 목표 성취를 위한 전략 수립과 실행
- ⑤ 학습에 따른 평가와 일반화

(2) 슈퍼비전의 목표

- 인지적, 행동적, 정서적 차원
- 인지적 차원으로 상담 장면에서 이미 습득한 지식을 효과적으로 사용하는 것.
- 슈퍼바이지는 모델링, 역조건화, 혐오 조건화, 목표 설정, 자기통제 프로그램, 체계적 둔감화 등과 같은 학습 이론을 기본적으로 알아야 함
- 행동적 기술은 상담자가 상담 과정에서 보이는 모든 행동적 반응 즉 과정적 기술, 대인 관계적 상담 기술, 행동적 상담 기술, 전문가적 기술, 자기 계발 기술을 갖추 필요
 - 과정적 기술: 상담자가 진단과 치료적 기술을 수행하는 능력
 - 대인 관계적 상담 기술: 정확한 공감, 진실성, 상담의 구조화 등을 제공하는 것
 - 행동적 상담 기술: 내담자에게 인지-행동주의적 상담과 진단에 대한 논리적 설명. 상담과정에서 나타날 수 있는 어려움이나 문제 예상할 수 있고, 상담 과정이 예상처럼 잘 이루어지지 않을 때 문제점을 찾아내는 능력
 - 전문가적 기술: 상담자가 속한 혹은 다른 분야의 전문가에게 자문을 구할 수 있는 능력, 내담자와 다른 분야의 전문가와 의사소통을 할 수 있는 상담 사례 보고서를 쓰는 능력, 관련된 행정 업무 능력 등
 - 자기 계발 기술: 슈퍼비전을 포함한 계속 교육을 추구하는 행동
- 정서적 기술은 상담자가 자신의 정서적 반응에 대응하는 기술
- 슈퍼비전 목적을 사용하기 위해 학습 이론의 원칙들을 슈퍼비전의 전략으로 사용
 - 반응 조형과 강화 과정: 이미 상담자가 가지고 있는 대인 관계와 치료적 기술을 강화하는 과정
 - 반응 촉진 과정: 이미 배운 기술을 사용하는 것을 방해하는 요인들을 줄이거나 변형하는 과정
 - 반응 학습 과정: 새로운 반응 혹은 반응들을 패턴화하는 새로운 방법을 배우는 과정
 - 반응 전환 과정: 새로 배운 상담 기술을 다양한 상황에서 사용할 수 있도록 슈퍼바이지를 돕는 과정
- 인지-행동주의 슈퍼비전의 목표가 과정은 다른 슈퍼비전에 비해 더 구체적이고 체계적
- 분명한 학습목표를 가지고 교육을 받을 수 있다는 장점, 그러나 상담자를 성장하는 존재가

아니라 단지 학습 가능한 존재로만 가정하고 슈퍼비전을 학습으로 보기 때문에 슈퍼바이저가 상담자의 학습 및 성장에 대해 책임져야 한다는 한계

3. 슈퍼비전 윤리

1) 수련 감독과 내담자 복지

- 수련감독자는 수련생이 진행하는 상담을 지도·감독할 때, 내담자의 복지를 우선적으로 고려해야 함
- 수련감독자는 수련생이 내담자들에게 상담 서비스를 제공함에 있어서, 자신의 자격 요건을 명확히 알리도록 지도함
- 수련감독자는 사전 동의 및 비밀보장 등의 권리가 내담자에게 있음을 수련생에게 주지시킴

2) 수련감독자의 역량과 책임

- 수련감독자는 사례지도 방법과 기법들에 대한 교육과 훈련을 받음으로써, 사례지도 역량을 향상시키기 위해 노력함
- 수련감독자는 전자 매체를 통하여 전송되는 모든 사례지도 자료의 비밀 보장을 위해서 주의하고, 필요한 조치를 취함
- 수련감독자는 사례지도를 진행할 때, 학회에서 권고한 사례지도 형식과 시간을 준수해야 함
- 수련감독자는 사례지도를 시작하기 전에, 진행 과정에 대해 충분히 설명한 후 동의를 받음으로써, 수련생의 적극적 참여를 독려할 책임이 있음
- 수련감독자는 수련생에게 그들이 준수해야 할 전문가적 · 윤리적 기준과 법적 책임을 숙지시킴
- 수련감독자는 지속적 평가를 통해 수련생의 한계를 파악하고, 그가 자신의 한계를 인식하고 보완할 수 있도록 도움
- 자격 심사 추천을 하는 주 수련감독자는 수련생이 합당한 역량을 모두 갖추었다고 여겨질 때에만 훈련과정을 확인 및 추천함

3) 수련감독자와 수련생 관계

- 수련감독자는 수련생과 상호 존중하며 윤리적, 전문적, 개인적, 그리고 사회적 관계를 명료하게 정의하고 유지함
- 수련감독 관계의 변화나 확장이 있을 경우, 수련감독자는 그로 인한 문제가 발생하지 않도록 적절한 전문적 조치를 취함
- 수련감독자와 수련생은 성적 혹은 연애 관계를 갖지 않음
- 수련감독자와 수련생은 상호 성희롱 또는 성추행을 해서는 안 됨
- 수련감독자는 가족, 친구, 동료 등 상대방에 대한 객관성을 유지하기 힘든 사람과 수련감독 관계를 맺지 않는 것을 원칙으로 함

4) 상담 교육자의 책임과 역할

- 상담 교육자는 상담과 관련된 자신의 지식과 능력 범위 안에서 교육을 제공하며, 상담 분야에서의 가장 새로운 정보와 지식을 활용함
- 상담 교육자는 교육과정에서 상담자의 다양성 인식 증진 및 다문화적 역량 향상을 도모함
- 상담 교육자는 교육생들이 상담이라는 전문직의 윤리적 책임과 규준을 숙지할 수 있도록 지도하고, 교육자 스스로 윤리적인 역할 모델이 될 수 있도록 노력함
- 상담 교육자는 자신이 속한 기관의 정책과 실재가 수련과정의 취지와 어긋난다면, 가능한 범위에서 그 상황을 개선하도록 노력함
- 상담 교육자는 수련중인 학회 회원의 상담료나 교육비를 책정할 때 특별한 배려를 함으로써 상담자 양성에 기여함
- 강의나 수업 중에 내담자, 학생, 혹은 수련생에 관한 정보나 이야기를 사례로 활용할 경우, 신상 정보를 충분히 변경하여 그 개인이 드러나지 않도록 보호함
- 상담 교육자는 교육생들이 훈련프로그램 중 상담자의 역할을 할 경우에도, 실제 상담자와 동일한 윤리적 의무와 책임이 있음을 인식하도록 지도함
- 상담 교육자는 평가대상이 되는 학생과 상담 관계를 맺지 않음
 - 단 학교 현장에서 교육의 목적으로 이루어지는 집단 상담의 경우는 예외로 함
- 상담 교육자와 교육생은 성적 혹은 연애 관계를 갖지 않음
- 상담 교육자와 교육생은 상호 성희롱 또는 성추행을 해서는 안 됨

4. 슈퍼비전의 실제

1) 슈퍼비전 첫 회기

(1) 동맹 관계 형성

- 긍정적인 동맹 관계 맺기
- 동맹 관계 형성을 위해 상담과 관련된 경험 혹은 일반적인 경험에 대한 서로의 정보를 나누는 것이 중요
- 슈퍼바이저는 자신의 교육과 경험에 대한 정보를 슈퍼바이저에게 제공해야 함
- 이론적 접근, 상담과 관련된 경험, 슈퍼비전에 대한 접근에 관한 정보 제공할 필요

(2) 평가에 대한 구조화

- 슈퍼바이저는 자신들의 상담 수행이 어떻게 평가될 것인지, 어떤 방법으로 피드백이 주어질 것인지, 자신들의 책임이 무엇인지 등 슈퍼바이저, 대학원 과정, 실습 기관이 자신들의 상담 수행에 어떤 기대를 가지고 있는지 알 필요
- 슈퍼바이저는 평가의 기준을 수련생과 공유하는 것이 바람직
- 슈퍼바이저 역시 슈퍼바이저에게 슈퍼비전의 유용성에 대한 지속적인 평가와 피드백 제공 필요

2) 슈퍼비전 관련 기록

(1) 상담 사례 기록

- 슈퍼비전 받을 상담 사례를 구두 보고, 축어록, 사례 노트, 오디오 테이프, 비디오 녹화 테이프, 직접 관찰 등을 통해 슈퍼바이저에게 보고할 수 있음
- 구두 보고
 - 슈퍼바이저의 기억에 의존하여 상담 내용을 구두로 보고.
 - 구두 보고는 내담자 문제에 대해 슈퍼바이저의 독립적인 판단 기회가 없고, 내담자 정보로부터 어떻게 추론해야 하는지에 대해 지도할 수 없다는 제약
- 사례 노트
 - 구두 보고와 같은 내용을 담고 있으나 슈퍼바이저가 슈퍼비전 전에 보고 내용을 미리 작성한다는 점이 다름
- 축어록
 - 상담 회기에 녹음한 후 그것을 그대로 기술하는 양식.
 - 사례 노트보다 많은 정보 제공.
 - 슈퍼바이저가 상담 장면을 알 수 있어서 슈퍼바이저와 상담자의 관계를 더욱 촉진적으로 만들어 줌

(2) 슈퍼비전 기록

- 슈퍼비전 날짜와 회기번호, 사례에 대한 기록, 내담자 문제와 진전, 내담자 진단 자료, 상담 계획과 전 계획의 수정에 대한 제안, 수련생의 발달과 문제점, 수련생의 교육 목표와 계획 등
- 수련에 대한 자료를 만들기 위해 슈퍼비전 기록 필수적

3) 슈퍼비전 평가

- 수련생에 대한 측정과 평가는 슈퍼비전의 기본 역할이고 슈퍼비전에서 계속되는 활동
- 수련생을 평가하는 것은 발달 단계에 따라 변화하는 수련생의 슈퍼비전에 대한 요구를 충족시키고 촉진하는 슈퍼비전 환경을 제공하기 위해 필요
- 슈퍼바이저가 수련생의 평가에 적용할 이론적 틀을 가지는 것이 좋음 한다.

집단상담 I / 11주차 1차시

1. 집단상담의 개요

1) 집단상담이란?

- 집단상담은 한 사람의 상담자가 동시에 몇 명의 내담자들을 상대로 각 내담자의 관심사, 대인관계, 사고 및 행동양식의 변화를 가져오게 하려는 노력
- 집단구성원 간의 상호작용적 관계(역동적 관계)를 바탕으로 내담자 개개인의 문제 해결 및 변화가 이루어지는 '집단적 접근방법'
- 집단상담은 내담자들의 병리적 문제보다는 주로 발달의 문제를 다루거나 생활 과정의 문제를 다룸
- 대인관계에 관련된 태도, 정서, 의사결정과 가치문제 등에 초점
- 집단상담의 일차적 목표는 개인으로 하여금 자기 이해와 대인관계의 능력을 향상하게 시키고, 생활환경에 더욱 건전하게 적응할 수 있도록 하는 것

2) 개인상담과 집단상담의 비교

(1) 공통점

- 가치 있는 개인으로 수용되는 것
- 자기 행동에 대한 책임감을 느끼는 것
- 인간 행동에 대한 이해를 심화시키는 것
- 개인의 정서적 생활의 다양성을 탐색하고, 충동적 정서를 통제하는 것
- 자신의 관심과 가치를 검증하고, 그 결과를 실제 생활 과정과 행동계획에 통합시키는 것

(2) 차이점

- 집단상담은 개인상담에 비해 개인의 과거나 집단 밖에서의 사건보다 서로의 인간관계에 더 관심
- 집단상담 참가자들은 다른 사람들이 어떻게 생각하여, 어떻게 느끼는가에 주의를 기울이고 타인의 감정과 생각을 존중할 수 있게 됨
- 집단상담 참가자는 개인상담을 보다는 내담자에 비해 '지금 그리고 여기'에 더 집중하는 경향
- 개인상담에 비해 현실검증이 중요시

(3) 집단상담보다 개인상담이 적합한 경우

- 복잡하거나 심각한 문제를 가졌거나, 대인관계의 어려움이 극심할 때는 개인상담이 적합
- 불안이 너무 높으면 집단상담에 참여 어려움
- 인정욕구가 너무 강하면 집단상담 부적합

3) 집단의 분류

- 아래의 내용으로 분류되지만, 명확히 구분되지 않고 중복되는 면이 있음

차원 범 주	지도집단	훈련집단	상담집단	치료집단
보편적 이름	토론집단, 정보제공 및 생활 안내 집단, 경력(진로) 및 직업지도집단	훈련집단, 대인관계 집단, 감수성훈련, 참만남 집단	집단상담	집단치료, 집단요법
집단원	영역과 필요성에 의해 자진 또는 타인이 선발	대인관계 경험 및 정서적 성장을 위해 자진 또는 타인의 추천	적응 문제로 인해 자신 또는 타인이 의뢰	이상행동으로 인해 자진 혹은 타인의 의뢰
인원	10~80	8~30	6~12	4~8
초점	교육적, 직업적, 개인적 정보제공과 생활계획	자기 노출과 피드백, 지금-여기의 상호작용	관찰할 수 있는 비 적응적 행동, 집단원 간의 상호작용에 의한 문제 해결	집단 내·외에서의 비적응적 행동, 집단원의 심리적 갈등
목표	생활계획과 의사결정의 촉진을 위한 환경적·개인적 요인에 대한 지식의 증가	바람직한 대인관계의 체험적 학습 및 정서적 순화	자기 탐색을 추진하기 위한 환경을 제공하고, 문제 해결·대안적 행동의 탐색, 실천	성격적 변화·이상행동의 수정
지도자	지도책임자(상담 자, 교수 등)	훈련자(교육자, 심리학자, 사회복지사 등)	상담자(심리상담 사, 집단상담 전문가 등)	치료자(임상심리 학자, 정신과 의사, 심리상담사, 사회복지사 등)
지도 형태	지도자가 집단방향과 내용을 정함	구성원의 요구에 따라 지도자가 집단과정을 안내, 촉진	지시적 또는 집단 중심적 접근	치료자의 훈련 배경, 환자의 문제에 따라 다르나 대체로 분석적, 지시적 접근
지도 기간	전달된 정보, 자료의 성질에 따라 1~7, 8회	보통 1~10일간 지속	5~25회 정도 지속	보통 7, 8회 ~30회 동안 지속
면접 시간	20~50분	1일에 8~12시간	1~2시간	1~2시간

장소	교육기관(중등학교, 산업체, 대학)	산업, 종교, 교육, 의료기관의 회의실, 주로 숙박형식 수련회	교육기관의 상담실이나 일반 상담소	병원 정신과나 임상진료실

4) 구조화된 집단 프로그램

- 구조화된 집단상담은 내용과 진행에 대한 지침이 명확히 제시되어 상대적으로 집단지도자의 경험과 지식이 풍부하지 않더라도 진행 가능
- 구조화된 집단 프로그램 종류

프로그램명	주목적
잠재력 개발을 위한 집단상담프로그램	개인의 잠재력 향상
학습 습관 향상을 위한 집단상담프로그램	성적향상
대학생의 스트레스 대처 훈련 프로그램	스트레스에 대한 대처방안 교육
자기 명료화글 위한 집단상담 프로그램	가치관 확립
관계 증진을 위한 의사소통 기법 훈련	바람직한 의사소통 기법 훈련
진로 탐색 프로그램	진로 정보획득 및 희망 직업 선정
비행 청소년 지도를 위한 집단상담	비행 청소년의 선도
가족기능화 훈련 프로그램	지지, 규제, 양육 등 가족기능의 강화

2. 집단상담의 구성 및 과정

1) 집단상담 구성

(1) 집단구성원의 선정

- 성별, 연령, 과거의 배경, 성격 차이 등을 고려
- 집단의 목표에 적절한 내담자로 구성

(2) 집단의 크기

- 적절한 집단의 크기는 집단의 성격에 따라 다르나 일반적으로 6~7명에서 10~12명 수준이 보통
- 집단의 크기가 너무 작으면 내담자들의 행동의 범위가 좁아지고 각자 받는 압력이 커지므로 비효율적

- 집단의 크기가 너무 클 경우, 내담자들의 일부는 전적으로 참여할 수 없게 되고, 상담자가 각 개인에게 적절한 주의를 기울이지 못함

(3) 모임의 빈도

- 1주일에 한 번 혹은 두 번
- 문제의 심각성이나 집단의 목표에 따라 모임의 빈도를 증감시킬 수 있으며, 때로는 불가피한 주위 여건 때문에 일정이 변경되기도 함
- 집단을 구성하는 이유가 빠른 해결을 보아야 하는 급박한 문제 때문이라면, 어느 정도 진전이 보일 때까지는 매일 혹은 격일로 만날 수 있음.
- 때에 따라 격주 혹은 그 이상의 시간 간격으로 만날 때도 있으나, 집단상담자들은 대체로 한 주일 이상의 간격을 두고 만나는 것은 좋지 않을 것으로 판단

(4) 모임의 시간

- 집단상담의 적절한 시간은 내담자의 연령이나 모임의 종류 및 모임의 빈도에 따라 달라짐
- 청소년의 경우라면 한 시간 내지 한 시간 반 정도가 좋으나, 아동의 경우는 20~40분 정도가 적당
- 연속집단에서는 한 번에 15~20시간 혹은 그 이상 지속

(5) 집단모임 장소

- 외부로부터 방해받지 않는 곳
- 모든 집단원이 서로 잘 볼 수 있고 잘 들을 수 있는 곳

(6) 폐쇄 집단과 개방집단

- 집단의 목표에 따라 집단의 운영을 폐쇄형으로 할 것인가 혹은 개방형으로 할 것인가 정할 필요
- 폐쇄 집단은 상담이 시작될 때 참여했던 사람들로만 끝까지 밀고 나가는 것.
 - 도중에 탈락자가 생겨도 새로운 구성원을 채워 넣지 않음.
 - 대개 학교에서의 집단상담은 이와 같은 형태를 위함.
 - 이러한 집단은 여러 장점을 가족 있으나 집단원이 도중에 탈락하면 집단의 크기가 너무 작아질 염려
- 개방집단은 집단이 허용하는 한도 내에서 새로운 사람을 받아들이는 것.
 - 이때에는 집단원 간에 의사소통이나 수용, 지지 등이 부족해지거나 갈등이 발생할 수 있음.
 - 새로운 구성원을 받아들일 때는 반드시 집단 전체가 그 문제를 충분히 논의할 필요

2) 집단상담의 과정

① 참여 단계

- 상담자는 상담집단의 분위기를 형성하고 유지하는 책임이 있음
- 각 구성원에게 왜 이 집단에 들어오게 되었는지 분명히 해주고 서로 친숙하게 만들며, 수용과 신뢰의 분위기를 형성하여 집단상담에서 새롭고 의미 있는 경험을 가지도록 이끌어 줌
- 구성원들은 자유로이 각자의 의견과 느낌을 나누도록 지지

- 이 시기에 상담자는 내담자들에게 스스로 집단의 '규범' 준수와 상호협력적인 자세를 갖추도록 함으로써 효율적인 집단 분위기를 형성할 수 있음

② 과도적 단계

- 참여 단계는 한 번의 모임으로 완료되는 때도 있고 보다 어려운 집단에서는 5~6회가 소요되기도 함
- 과도적 단계는 참여 단계와 엄격하게 구분되지는 않음
- 참여 단계에서 생산적인 작업 단계로 넘어가도록 하는 '과도적' 과정이 과도적 단계
- 이 단계의 성공 여부는 주로 상담자의 태도와 기술에 달려 있음
- 과도적 단계의 주요 과제
 - 집단원들에게 집단에 참여하는 과정에서 일어나는 망설임, 저항, 방어 등을 자각하고 정리하도록 도와주는 것
- 이 단계에서 적극적으로 참여하지 못하거나 집단구성원들로부터 거부당하는 구성원 있을 수 있음.
- 상담자는 이런 집단원이 고립되거나 완전히 집단에서 떠나는 것을 방지하기 위해 집단원들에게 그를 이해하고 받아들이도록 노력
- 과도적 단계에서 상담자는 구성원들 간의 진정한 느낌이 교환되도록 격려하는 데 노력을 집중할 필요.
 - 개인적 느낌의 토의가 위험하지 않다는 것을 보여줄 필요
- 집단원들은 과도적 과정에서 느낌과 지각내용의 상호교류가 얼마나 이로운가를 배우게 됨.
- 진정한 느낌과 생각을 점진적으로 나누게 되면, 다른 사람이 자기를 알도록 허용함으로써 비생산적인 방어를 줄일 수 있음
- 상담자는 스스로 개방적으로 되어야 하고, 때에 따라 자기의 감정을 다른 사람들과 나누고, 자기의 행동의 의미를 탐색함으로써 집단에서 서로 믿을 수 있다는 것을 말뿐만 아니라 직접 시범을 보일 필요

③ 작업 단계

- 작업 단계는 상담집단의 가장 핵심적인 부분
- 대부분의 집단원이 자기의 구체적인 문제를 집단에 개방하고 활발히 논의하여 바람직한 관점과 행동 방안을 모색
- 집단원들이 자기 자신을 위해 어떻게 집단을 이용하며, 다른 사람들을 돕기 위해 어떻게 자기의 생각과 기술을 활용할 것인가에 대해 분명히 알게 되었을 때 작업 단계에 들어섰다고 볼 수 있음
- 상담자는 구성원들이 대인관계를 분석하고 문제를 다루어 나가는 데 자신감을 얻도록 도와주는 존재
- 작업 단계에서는 높은 사기와 분명한 소속감을 느끼는 것이 특징
- 각 구성원끼리 열심히 도우려 하는데, 상담자는 이 단계에서 서로 경쟁적으로 도우려 하거나, '명석한 통찰과 처방'만을 제공하는 분위기가 되지 않도록 주의할 필요

- 통찰과 더불어 행동의 실천이 필요

④ 종결 단계

- 집단관계의 종결이 가까워져 오는 데 대한 느낌을 토의할 필요
- 집단원들은 정기적인 상담이 끝난 후 모임을 지속하길 원할 수 있음.
- 이때에는 반드시 집단에 대한 각자의 책임을 미리 재교육하는 것이 필요
- 집단에서 경험하고 배운 것을 일상생활에서 적용할 수 있다는 것, 자신을 보다 깊이 알고, 자신과 타인을 수용하면서 살아갈 수 있도록 격려

집단상담Ⅱ / 11주차 2차시

1. 아동을 대상으로 한 집단상담

1) 아동을 위한 집단상담 지침

(1) 안전한 계획 설정

- 집단의 목적과 목표를 분명하게 기술
- 집단의 목표에 맞는 이론적 근거를 명확히 함
- 집단의 목표, 과정, 평가과정을 비롯하여 집단의 접근방법이 어떤 점에서 특별한 장점이 있는지 그 이유에 대한 자세한 설명
- 어떤 자료를 참고하였는지 제시

(2) 법적인 고려

- 윤리적인 원칙뿐만 아니라 법규에 관해 자세히 파악할 필요
- 아동에게 완벽한 비밀보장을 약속하는 것은 바람직하지 않음
- 상담자는 자신이 활동하는 학교 및 기관의 정책과 절차를 숙지할 필요
- 비밀 유지의 한계를 명확히 설명해야 함
- 보호자의 동의서를 받아두는 것이 도움이 될 수 있음

(3) 실제적 고려

- 집단의 크기와 시간은 집단 구성원의 연령에 따라 결정
- 아동이 어릴수록 집단 크기와 회기 시간 짧음
- 상담자가 다룰 수 있는 한계 범위 내에 있는 아동을 선별할 필요(예 : ADHD 아동)
- 집단원의 연령이 낮을수록 부모들에게 집단의 목적과 기대에 대해 분명하게 설명하여 이해시키는 것이 바람직함

2) 학교 장면에서의 집단상담

- 학교 내에서 집단상담을 시행하기 위해서는 일정한 주제와 형식을 골고루 진행할 필요
- 적응문제, 행동 문제, 학습장애 문제 등이 주요 주제
- 치료목적의 집단상담과 발달적, 예방적, 교육적 목적의 집단상담 간의 차이를 분명히 알 필요.
학교에서 아동을 대상으로 집단상담을 실시할 때에는 대부분 예방적이고 발달적인 주제를 다룸

3) 아동을 위한 집단상담의 예

프로그램명	초등학생을 위한 분노 조절 및 갈등 해결 집단
집단 목표	- 갈등 해결에 필요한 정보를 제공하고 취해야 할 태도에 관해

	설명하기 - 분노를 지각하고 다루는 기술을 향상시키기 - 다양한 문제에 대해 지각하기 - 갈등 해결을 위한 효과적인 방법을 소개하기
내용 구성	- 분노를 느끼는 것이 잘못된 것은 아님. 그러나 적절하게 분노를 표현하는 방법을 배우는 것이 중요함을 이해하기 - 분노를 느껴도 괜찮음. 하지만 타인, 자신에게 상처를 주거나 재산을 파손해서는 안 됨 - 사람들은 각기 다른 의견, 감정, 욕구, 그리고 신념을 갖고 있기 때문에 갈등 발생. 갈등은 자연스러운 부분 - 너도 이기고-나도 이기는 방식으로 갈등 해결 가능하다는 것을 이해하기
회기 수와 회기 별 내용	- 총 6회기 - 1회기 > 서로에 대해 알고, 집단의 규칙을 세우며, 집단상담에 대한 기대를 확인 > '갈등'이라는 말의 의미를 이해하고, 갈등을 다루는 방법에 대한 논의 > 집단의 목표와 앞으로 아동이 배우고 실습할 기술에 대한 소개 - 2~5회기 > 폭력과 공격을 사용하지 않고 갈등과 분노를 해결해 나가는 자신감과 기술을 가질 수 있도록 도움 > 갈등과 평화의 차이점과 관계에 관한 이야기 나누기 > '나를 화나게 하는 것'이라는 제목의 리스트 만들기. 분노 수준을 체온계를 사용해 체크하기 > 마음을 가라앉히는 법에 대해 논의하고, 목록 작성하기 > 경청 연습 > 도구상자 활동 : 한 사람씩 돌아가며 갈등 상황에서 사용할 수 있는 도구와 기술로 어떤 것들이 있는지 이야기 나누기 - 6회기 > 배운 것에 관해 이야기 나누고 되돌아보기

2. 청소년을 대상으로 한 집단상담

1) 청소년에 대한 발달적 이해

- 청소년들은 아동보다 우정에 더 관심. 또래집단 압력에 많은 영향을 받음
- 부모로부터의 분리와 자아정체성 문제로 투쟁
- 성공에 대한 압력을 받기도 함. 다른 사람의 기준에 맞추어 어떤 일을 해내도록 요구받음

2) 청소년 집단을 이끌며 만나게 되는 문제와 도전

(1) 신뢰 확립

- 초기 회기에서 다음과 같은 주제 다룰 필요
 - 비밀 유지, 집단규칙, 집단 내 상호작용을 촉진하는 방법을 명료화하는 경계 확립하기, 피드백 주고받기, 집단 외부에서의 적용 제안하기
- (2) 자기 노출에 대한 안전지대 알기
 - 청소년들은 집단장면에서 상담자를 시험(예 : 결혼하셨어요? 이혼해 보셨어요?)
 - 청소년 참여자의 시험에 상담자가 비판단적이고 비방적인 태도를 보일 경우, 신뢰 증가하며 집단상담에 대한 저항 감소
- (3) 비자발적이고 저항적인 청소년 집단 구성원과 작업하기
 - 참여자의 권리에 대해 논의하고, 집단에 대한 구체적인 정보 제공
 - 비방적인 방식으로 그들의 태도를 탐색하며, 집단에 강요로 참여하게 된 것에 대한 감정을 표현할 기회를 줄 필요
 - 비협조적인 청소년들과 대항하여 싸우기보다 그들의 권리를 존중하고, 집단에서 대안을 탐색하고 시도하는 것이 필요.
 - 예) 집단 시작 전 몇 회기 동안 개별적으로 만나거나, 지속적으로 거부적인 태도를 보일 경우, 집단을 떠나도록 허용하는 것을 고려. 또는 관찰자로 참여할 수 있도록 허용, 단 이런 경우 다른 집단원들의 동의가 있어야 함
 - 적절한 반응의 예
 - 이 집단이 어떤 것인지 알기 위해 두 번 참석해 보고 나서 계속할지를 결정하는 건 어떨까?
 - 집단에서 많은 친구가 너와 같이 느꼈단다. 아마 그들은 네게 집단에서 무엇이 좋았는지 말해줄 수 있을 거야
 - 어떤 것이든 상담에 관해 아는 것이 있니? 이전의 집단에 참가해 본 적이 있었니?
 - 왜 네가 여기 오게 되었다고 생각하니?
 - 네가 여기 있기를 원하지 않는다는 것을 이해해. 만약 네가 참석하지 않는 것을 선택한다면 어떤 결과들이 따를까?
 - 부정적인 태도를 가진 청소년들이 당신을 언어적으로 매도하는 것을 허용해서는 안 됨.
 - 직접적이고 비방적인 태도로 반응할 필요

3) 청소년을 위한 집단상담의 예

프로그램명	진로 탐색 집단상담 프로그램
집단 목표	- 진로 계획에 중요한 흥미, 적성, 가치관, 성격 등의 개인내적 요소에 대한 이해 증진 - 진로 의사결정 촉진 - 실제적인 직업 탐색 및 정보 찾기
내용 구성	- 흥미와 적성에 대한 탐색 - 진로 의사결정 방법을 이해하고 의사결정 연습하기 - 직업을 탐색하고 좋아하는 교과와 직업을 연결하기

	- 아는 직업과 모르는 직업 찾기 - 미래 사회의 직업에 대해 생각해보기
회기 수와 회기 별 내용	- 총 10회기 - 1회기 > 프로그램의 취지를 설명 > 활동 목표를 제시 > 서로에 대해 알기 - 2~9회기 > 자신이 잘하는 것을 작성해보고, 친구가 보는 나와 내가 보는 나를 비교해 > 나의 특성을 이해 > 목표 확인, 대안 탐색, 기준확인, 대안 평가 및 결정, 계획 수립 및 실행의 의사결정 5단계를 연습 > 직업 카드와 직장인을 통해 직업 탐색 > 좋아하는 교과와 직업을 연결 지어 교과와 관련된 직업 탐색 > 아는 직업과 숨은 직업, 모르는 직업 찾기 > 미래 사회의 직업 탐색 - 10회기 > 소감 나누기, 미래의 명함 만들기

3. 성인을 대상으로 한 집단상담

1) 성인에 대한 발달적 이해

- 성인은 대학생, 청년, 중년을 포함
- 연령대가 다양하고 소속되어 있는 조직의 환경, 삶의 과업이 다양
- 이러한 다양성을 모두 포함하는 집단상담은 불가능
- 주제, 집단원 등을 구체화하여 집단상담을 진행하는 것이 효과적일 수 있음

2) 주제-지향 집단

- 주제-지향 집단은 성인에게 많은 이점
- 다루는 주제들이 참가자들의 삶의 문제를 반영하고 있다면, 강력한 촉매제 역할
- 부부관계, 스트레스 대처, 대인관계, 성폭력 피해, 가정폭력 피해 등이 예가 될 수 있음

3) 성인을 위한 집단상담의 예

프로그램명	가정폭력 가해자 집단
집단 목표	- 신체적 폭력에 대한 대안 행동 발전시키기

	- 분노를 다루는 인지적 기술 익히기 - 관계의 역동과 기대, 신체적 학대의 발전과정을 개관하기 - 느낌과 감정처리의 인식을 발전시키기 - 분명한 의사소통 능력 증진 - 개인적 책임감 증진 - 공감과 중요한 타인에 대한 이해 증진
내용 구성	- 가해자들이 자신의 감정과 행동에 책임감을 느끼도록 해결 중심 치료적 접근으로 구성 - 느낌과 감정에 대한 인식을 증진하고, 이와 관련한 조절, 행동 선택의 책임을 질 수 있도록 함 - 신체, 언어적 폭력을 대안으로 하는 행동과 태도를 탐색하고 발전시키기 - 타인에 대한 공감과 이해를 증진하기
회기 수와 회기 별 내용	- 총 8회기 - 1회기 > 프로그램의 취지를 설명 > 활동 목표를 제시 > 서로에 대해 알기 - 2~7회기 > 대인관계 경험과 개인 내적인 경험 이해하기 > 감정처리를 위한 인지적 기술 탐색하고 연습하기 > 분노와 관련한 교육 시행하기 > 대사가 주어진 역할 놀이 > 의사소통 방식 파악하기, 효과적인 의사소통 연습하기 > 주장 훈련 - 8회기 > 소감 나누기, TO DO LIST 작성하기

4. 노인을 대상으로 한 집단상담

1) 노인에 대한 발달적 이해

- 65세 이상
- 일부 노인의 관심 범위는 신체적 또는 심리적 어려움 때문에 좁을 수 있음
- 집단에 지속적으로 참여하기 어려울 수 있음
- 노인들은 직면보다 지지와 격려가 더 효과적. 인격의 재구성을 하기보다 현재의 삶을 더 의미 있고 즐길 수 있게 만드는 쪽으로 방향을 맞추는 것이 필요.

- 대인관계의 상호작용 부족으로 인한 외로움과 고독감이 클 수 있음
- 상담에 회의적일 수 있어서 신뢰를 쌓기까지 더 많은 시간과 노력이 필요할 수 있음
- 상실, 외로움, 사회적 고립, 가난, 거절의 느낌, 삶의 의미를 발견하려는 투쟁, 의존성, 쓸모없다는 느낌, 절망, 죽음에 대한 두려움, 애도, 신체적 정신적 쇠약에 대한 슬픔, 후회 등과 같은 주제

2) 실제적, 전문적인 고려사항

(1) 실제적 문제

- 집단의 크기, 기간, 사용되는 기법에 관한 실제적 고려사항은 구체적인 집단의 기능 수준에 달림
- 구성원들의 정신적, 신체적 수용 능력을 잘 이해하는 것이 중요

(2) 가치 차이

- 구성원들에 대한 사회적 문화적 배경을 이해하는 것 필요
- 구성원과 상담자 간 나이 차이는 가치의 차이를 가져올 수 있음
- 자신보다 어린 치료자에게 고민을 이야기하는 것을 불편해할 수 있다는 점을 염두에 둘 필요

(3) 필요한 상담자의 태도, 지식, 기술

- 노인들에 대한 진정한 존경
- 노인들과의 긍정적인 경험
- 노인에 대한 깊은 애정
- 노인의 문화적 가치에 대한 존중
- 개인의 문화적 배경이 어떻게 계속해서 현재의 태도와 행동에 영향을 미치는지에 대한 이해
- 여러 번 되풀이되는 이야기를 들을 수 있는 인내
- 노인들로부터 배울 수 있는 능력과 노인으로부터 배우고자 하는 바람
- 노화의 병리에 대한 배경지식

(4) 지양해야 할 태도

- 연약한 것처럼 대하지 않기
- 집단원을 계속 바쁘게 하는 것을 피하기
- 어린아이들인 것처럼 이야기하지 않기

3) 노인을 위한 집단상담의 예

프로그램명	노인 사별 집단
집단 목표	- 상실로 인한 영향을 인식하기 - 상실과 관련한 감정을 공감받기 - 애도하기
내용 구성	- 사별자들을 위한 교육과 정서적 지지 - 상실한 사람의 의미 재확인 - 새로운 관계를 맺을 수 있는 능력 함양

회기 수와 회기 별 내용	- 총 6회기 - 1회기 > 프로그램의 취지를 설명 > 활동 목표를 제시 > 서로에 대해 알기 - 2~5회기 - 서로의 상실 나누기 > 애도 과정에 대해 배우기 > 사진을 가져와 죽은 이에 관해 이야기하며, 기억을 공유하고 죽은 이와 의 관계와 의미를 재확인 > 부차적인 상실 나누기 > 자신감과 기술 정립 - 6회기 > 소감 나누기

단기상담 I / 12주차 1차시

1. 단기 역동적 심리치료의 일반주제

1) 단기 심리치료의 실제

- 내담자 대부분이 짧은 시간 동안만 치료받기를 원함
- 치료 탈락률 곡선에 의하면 60~75%가 8회기 이전에 치료를 그만둠
- 임상적 개선이 가장 많이 일어나는 시기에 치료를 중단함
- 치료받으러 오는 내담자는 정서적 고통이 가능한 한 빨리 경감되기를 바람.
 - 이들은 즉각적인 경감을 바라는 자신들의 욕구가 치료자가 목표로 하는 '문제 해결'과 다르다는 것을 경험함
- 치료의 초점이 있는 시간 제한적인 치료를 할 때는 탈락률이 줄어듦
- 종결 일자를 정하는 것이 의존에 대한 공포 및 종결과 관련된 갈등이 일어날 가능성을 줄임
- 시간 제한적인 치료에서 명확한 초점을 유지하고, 치료자가 더 많은 활동을 하며, 긍정적인 치료 동맹을 강조한 것이 탈락률을 극적으로 낮춤

2) 단기심리치료의 특징들

(1) 치료 기간이 짧는데 기인한 특성

- 제한된 초점(그리고 제한된 목표)
- 제한된 시간
- 선별 준거
- 치료자 활동
- 치료 동맹
- 신속한 평가와 즉각적인 개입
- 계획된 종결

① 치료 초점의 제한

- 상담자들이 목표에 집중할 수 있게 해주는 중심 주제나 문제가 필요함
- 치료의 범위 제한

② 시간제한과 시간 관리

- 시간제한은 치료자 활동을 격려하고 내담자에게는 희망을 고취하여 치료작업을 촉진
- 시간 제한적인 태도가 강조되고 있으며, '시간-효율적인', '비용-효율적인' 용어가 '단기'보다 적절할 수 있음

③ 선별 준거

- 가장 논란이 되는 주제
- 초기 단기치료자들은 높은 수준의 자아 강도, 동기, 대상관계를 가진 환자들이 단기 치료에

적합한 것으로 판단

- 하지만 이러한 기준은 단기 치료 결과에 대한 미약한 예측을 보임
- 급성 발병, 발병 이전의 높은 적응 수준, 관계 맺는 능력, 문제의 범위, 변화하려는 동기, 높은 사회경제적 지위, 현재의 위기 등의 환자 변인을 단기 치료 결과를 예측하는 정도는, 종결 시기에 정해져 있지 않은 치료 결과를 예측하는 정도와 별 차이가 없음
- 따라서 내담자 요인을 단기 치료의 적합성을 알려 주는 절대 기준으로서가 아니라, 내담자에 대해 얼마나 지지적으로 혹은 탐색적으로 개입해야 하는가를 알려 주는 정보로써 활용
- 최근의 단기치료자들은 어떤 내담자에게 어떤 심리치료를 하든지 간에 치료자의 시간 제한적인 태도는 도움이 됨

④ 치료자 활동

- 치료자의 적극성 강조. 하지만 직면, 충고하기, 지시 등과 혼동해서는 안 됨
- 치료자는 치료적 초점을 유지하는데 필요한 만큼의 활동만은 해야 함

⑤ 치료의 기간과 성과

- 치료의 성과는 치료 회기가 많을수록 좋음. 그러나 치료가 길어짐에 따라 치료 효과 증가율이 감소
- Howard 등에 따르면 8회기에 이르면 환자의 53%가 측정할 수 있는 개선을 나타내며, 26회기에 이르면 이 수치가 74%로 증가
- 급성 장애 증상(예: 두통, 안절부절못함, 쉽게 움)이 심리치료에 잘 반응하였으며, 가장 높은 평균 회복률 나타냄
- 만성 장애 증상들(예: 무가치감, 쉽게 상처받음, 사람들과 함께 있을 때 외로움)은 가장 빠른 평균 반응을, 적개심, 편집증적 사고, 정신병과 관련된 문제는 심리치료에 가장 느리게 반응함

⑥ 치료자의 가치관

- 단기 치료의 효과를 증명하는 연구들이 있음에도 불구하고, 많은 치료자는 단기 치료를 배우려 하지 않음
- 장기치료자의 가치 체계와 단기치료자의 가치 체계는 서로 상이함
- 단기치료자와 장기치료자의 주요 가치 비교

장기치료자	단기치료자
근본적인 성격의 변화 추구	실용주의와 절약성을 선호하며, 근본적 '치유'라는 개념을 믿지 않음
중요한 심리적 변화가 일상생활에서는 잘 일어나지 않는다고 믿음	중요한 심리적 변화가 불가피하게 일어난다고 보는 성인 발달 관점
제기된 문제는 그 이면의 기본적인 병리를 반영	환자의 강점과 자원 강조
환자가 중요한 변화를 할 때 '그곳'에 있고 싶어 함	'치료 후'에도 많은 변화가 일어나며, 이 경우 치료자가 변화를 관찰할 수 없다는 것을 받아들임
심리치료가 거의 언제나 긍정적이며 유용하다고 봄	심리치료가 때로는 유용하고 때로는 해롭다고 봄
치료를 받는 것이 환자의 삶에서 가장 중요한 부분	세상에서 살아가는 것이 치료받는 것보다 더 중요하다고 봄

2. TLDP 모델

1) 왜 TLDP(Time-Limited Dynamic Psychotherapy: 단기 역동적 심리치료)인가?

- 어려운 환자의 치료에 적용 가능(폭넓은 환자 선별 준거)
- 경험적으로 검토 가능(연구 결과에 바탕을 둔 접근)
- 교수와 학습의 유용성(쉽게 사용 가능)

(1) 어려운 환자의 치료에 적용 가능(폭넓은 환자 선별 준거)

- 만성적인 대인 문제나 성격장애가 있는 사람들을 치료하기 위해 고안된 융통성 있는 단기 치료 접근
- TLDP는 환자의 유형을 제한하기보다 어려운 환자의 치료 효과를 높이기 위해 치료와 치료자 수련 방식을 개선

(2) 경험적으로 검토 가능(연구 결과에 바탕을 둔 접근)

- 14회기 치료 후에 내담자의 60%가 증상 개선과 대인관계 호전을 보고하고 종결 시에는 내담자의 71%가 호전 보고함
- 추수 연구에서는 치료가 종결되고 6개월에서 6년이 지난 후에 내담자를 다시 평가했는데 환자들의 증상과 대인관계 문제의 개선이 잘 유지되었음
- 내담자의 80%가 그들이 문제를 이전보다 더 효과적으로 다루는데, 치료가 도움이 되었다고 보고함

(3) 교수와 학습의 유용성

- 치료 지침서 개발로 인해 융통성 있는 틀을 제공

2) TLDP 전제

- 내담자들은 혼란스러운 대인관계에서 비롯된 문제들을 해결하기 위해 대인 관계적 치료 필요
- 역기능적 양식은 과거에 학습된 것
- 역기능적 양식은 현재 유지되고 있는 것
- 내담자는 치료자를 대상으로 대인관계의 어려움 재연
- 치료자는 참여관찰자
- 치료자는 내담자가 재연하는 문제에 휘말려 들어감
- 주된 대인관계 문제 패턴 존재

(1) 대인관계 치료

- TLDP는 치료의 대인관계 모델 채택
- 관계적 관점은 치료자가 참여관찰자로서 치료 관계에 들어가게 되는 상호교류의 패턴에 초점
- 이때 전이는 왜곡이 아니라, 치료자의 행동과 의도에 대해 환자가 그럴듯하게 지각한 것이며 역전이는 치료자의 실패가 아니라, 환자와의 상호작용의 밀고 당김에 대해 치료자가 보이는 역할 반응성 혹은 대인 관계적 공감
- 주호소가 불안, 우울인 경우에도 대인관계 문제가 근본적인 문제일 가능성이 높음

(2) 과거의 학습

- 성인기의 장애는 초기 양육자와의 문제 있는 관계에서 비롯됨
- 어떤 방식들이 모여서 체계화되고 부호화된 경험적, 인지적 자료가 되고, 이 대인관계 스키마는 관계 맺기의 본질에 대해, 또한 다른 사람과 정서적 연결을 유지하는 데 무엇이 필요한지에 대해 정보 제공
- 개개인의 기질에 영향을 미치는 유전적 요인 무시할 수 없음
- 기질은 출생 시부터 나타나며, 대인 경험으로 수정(악화 혹은 개선)
 - 예) 환경의 작은 변화에도 쉽게 반응하도록 타고난 유아는 엄마를 불안에 빠뜨리고 화를 잘 내도록 이끌 수 있으며, 이렇게 엄마가 쉽게 화를 내면 아이는 다시 타인에 대해 불안해하고 두려워하는 태도를 더욱 발전시킴

(3) 문제의 유지

- 역기능적 스타일이 과거에 시작되지만, 현재에 유지
- 현재에 대한 이러한 강조는 짧은 시간 안에 대인 관계적 어려움을 치료하는 데 시사하는 바가 매우 큼
- 만일 역기능적 상호작용이 현재 시점에 유지된다면, 이 역기능적 스타일을 변화시키기 위해 바로 지금 작업 시도 가능

(4) 치료에서의 재연

- 내담자는 중요한 타인과의 상호작용과 유사한 역기능적 방식으로 상담자와 상호작용
- 이를 통해 내담자가 다른 사람들과 상호작용할 때 무엇이 잘못되는지 더욱 확실히 이해 가능

3) TLDP의 목표

(1) 새로운 경험

- 내담자가 새로운 경험을 하게 하는 것
- 새롭다는 의미는 내담자에게 익숙한 부적응적 패턴과는 다르고 더 기능적이라는 의미
- 경험은 변화의 정서적-행동적 요소를 강조하는 말
- 새로운 상호작용을 장려
- 이 과정에서 내담자는 이전과는 다르게 자신에 지각해야 함
- 내담자가 과거의 중요한 사람들과 가졌던 것과 다른 경험을 치료자와 관계에서 할 필요
- 긍정적 대인관계 경험은 내담자에게 체험적 학습의 기회를 주며, 이에 따라 낡은 패턴이 사라지고 새로운 패턴이 나타남
- 추상적 사고력이 부족하거나 자신의 마음을 잘 들여다볼 줄 모르는 사람도 보통 새로운 경험을 했다는 사실, 즉 일상적인 준거 틀의 밖에 있는 어떤 일이 일어났다는 것을 알아차릴 수 있어 넓은 범위의 내담자를 받아들일 수 있음

(2) 새로운 이해

- 인지적 변화
- 새로운 이해는 자신의 역기능적 패턴을 알아내고 이해하는 것

단기상담Ⅱ / 12주차 2차시

1. 사례 개념화

- 치료 초점의 제한은 단기 심리치료와 장기 심리치료를 구별하는 주된 개념
- 단기 치료에서는 치료자가 목표를 유지할 수 있도록 안내해주는 중심 주제 또는 핵심 문제 필요
- 단기치료자는 모든 임상 자료에 주의를 기울일 수 없으며, 아무리 매력적인 자료도 때로는 무시할 필요
- 단기 모델을 가지고 작업하는 치료자들은 선택적 주의와 우호적인 무관심을 배울 필요
- 그렇다면 치료 작업을 하기 위한 초점의 발견방법
 - TLDP에서는 내담자의 부적응적인 상호작용 패턴에 초점.
 - 이에 순환적 부적응 패턴(cyclical maladaptive patter : CMP) 개발

1) CMP의 범주

(1) 자기의 행동

- 대인 관계적 속성을 가진 내담자의 생각, 감정, 소망, 행동을 포함
 - 예) '모임에서 스타고 되고 싶다' (소망), '부정적인 피드백을 들을 상황을 피한다.' (행동), '싸우는 게 두렵다' (느낌), '사람들은 나에게 관심이 없다.' (생각)

(2) 타인의 반응에 대한 예측

- 다른 사람들이 자신의 대인관계 행동에 대해 어떻게 반응할 것에 관한 모든 추측과 예상을 포함
 - 예) '내가 실수하면, 사람들이 비웃을 거야', '소개팅을 나가도 난 차일 거야'

(3) 자기를 대하는 타인의 행동

- 내담자가 관찰하고 해석한 다른 사람의 실제 행동
 - 예) '내가 실수했을 때, 아빠는 엄하게 혼낸다.', '소개팅에서 애프터를 받기는 했지만, 그건 상대가 너무 외로워서 누구든 만나고 싶어서 그런 것 같아'

(4) 자기를 대하는 자기의 행동-내사

- 자기도 대인관계 역동의 대상이 될 수 있으며, 자기 자신에 대한 행동과 태도를 의미함
- 내담자가 자기 자신을 어떻게 대하고 어떻게 취급하는가에 대한 이해

2) CMP의 활용

- 치료자는 CMP 정보를 사용해 이야기를 구성함
- 내담자가 이러하게 느끼고, 생각하고, 바라고 행동하며 -> 다른 사람들이 자신에게 이러이러하게 반응할 것이라고 짐작 -> 내담자가 관찰하기에는 다른 사람들이 이러이러하게 실제로 반응 -> 이 모든 것들이 내담자가 자신을 어떻게 대하는가와 관련
 - 예) 나는 다른 사람들을 불신하고(행동), 그들로부터 떨어져 지낸다(행동). 왜냐하면 나는

다른 사람들이 냉담하고 경솔할 것이라고 보기 때문이다(타이에 대한 예측). 다른 사람들이 나를 무시하니까(타인의 행동), 나는 자신을 보호하고 고립시킬 수밖에 없다(자기를 대하는 자기의 행동). 나는 아무도 믿을 수 없기 때문이다(타인에 대한 예측).

3) TLDP 사례 개념화 및 개입의 단계

- 내담자가 자기 말로 자신의 이야기를 할 수 있게 함
- 증상이나 문제와 관련된 대인관계 맥락 탐색을 탐색함
- 정보의 수집, 분류, 조사를 위해 CMP 범주 사용
- 내담자의 말을 경청하며 내담자(과거와 현재의 관계에 대해)가 말한 내용과 치료 회기 중에 상호작용하는 방식에서 내담자의 고유한 주제 찾기
- 내담자에 대한 반응(역전이적 밀고 당김)을 인식함
- 치료관계에 나타나는 역기능적 상호작용의 재연에 주의를 기울임
- 치료자와의 관계의 발전에 대해 환자가 어떻게 반응하는지 탐색함
- 내담자의 주요한 역기능적 상호작용 패턴을 기술하는 CMP 이야기 만들기
- CMP로부터 치료 목표의 윤곽을 그림
- 내담자의 CMP에 맞게, 치료자와 더 적응적인 관계를 맺는 새로운 경험을 하도록 도움
- 내담자가 다른 사람이나 치료자와의 사이에서 발생하는 자신의 역기능적 패턴을 알아내고 이해하도록 도움
- 내담자가 자신의 상호작용 방식이 한때는 적응적이었음을 인식하도록 도움
- 전체 치료 기간에 걸쳐 CMP를 수정하고 보완

2. 환자 선별 준거와 순환적 부적응 패턴의 재연

1) 환자(내담자) 선별 준거

(1) 정서적 불편

- 내담자는 치료적 도움을 찾을 정도로 정서적인 고통을 느껴야 함

(2) 기본적 신뢰

- 내담자는 고통에서 벗어나리라는 희망과 신뢰를 가지고 정기적으로 찾아와 자기 삶에 관해 이야기할 수 있어야 함

(3) 자신의 갈등을 대인 관계적 관점에서 생각해 보려는 태도

- 내담자는 자신의 문제가 인간관계의 어려움과 관계가 있을 가능성에 대해 생각해 볼 수 있어야 함

(4) 자신의 감정을 검토해 보려는 태도

- 내담자는 자신의 감정이 대인관계의 어려움에 어떤 중요한 역할을 할 가능성에 대해 생각해 볼 수 있어야 함.
- 또한 내담자는 강렬한 감정에 정서적인 거리를 두는 능력이 있어서 이런 감정을 검토할 수

있어야 함

(5) 치료자와 '의미 있는 방식'으로 관계 맺는 능력

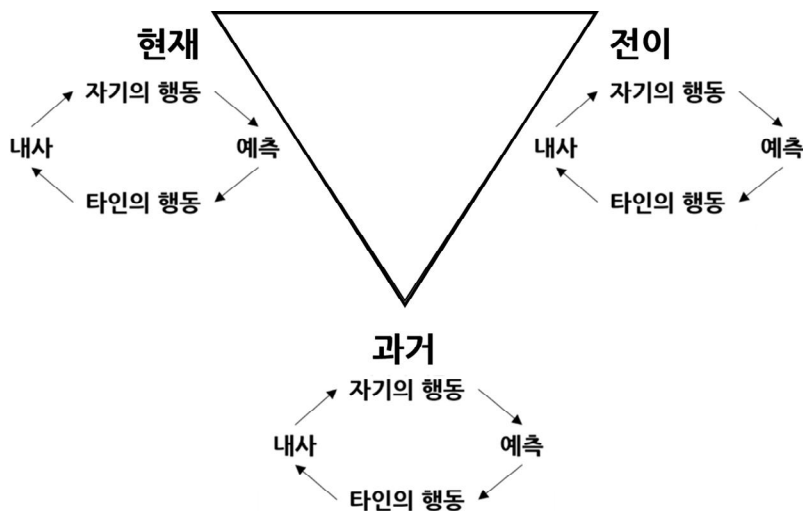
- 내담자는 다른 사람들을 자신과 분리된 온전한 사람으로 경험하고 그와 관계 맺을 수 있어야 함.
- 새로운 대인관계 경험을 하고 있다는 사실을 지각하고, 치료 상황에서 부적응적 대인관계의 재연을 검토할 수 있어야 함.
- 내담자가 부적응적 상호작용을 매우 완고하게 지속하면 치료자가 제 역할을 못 할 수 있음

2) 배제 준거

- 내담자가 치료자와의 언어적인 교류 과정에 참여할 수 없음
 - 예) 섬망, 치매, 또는 정신병 상태이거나, 지적 능력의 현저한 감소)
- 내담자의 문제가 다른 방법을 사용하면 더 효과적으로 치료될 수 있음
 - 예) 특정 공포증이나 조울증)
- 내담자가 불안을 증가시킬 수 있는 적극적, 해석적, 상호작용적인 치료 과정을 견뎌낼 수 없는 경우
 - 예) 충동 조절 문제, 알코올 및 약물 남용 문제, 반복적 자살 시도)

3) 순환적 부적응 패턴의 재연

- 치료자에 대한 경험과 느낌은 내담자가 다른 사람과의 교류를 언급하는 것에 반영
- 때로는 이러한 유사성이 명백하게 드러나고, 때로는 상당히 미묘하게 표현됨
- 과거, 현재, 치료 상황 사이가 연결
- 통합 모델 : CMP와 통찰의 삼각형



3. 치료자의 자세

1) 처음 5분

- 내담자에 대한 존중
- 절제된 자기 개방에 관한 임상적 정직성
- 적절한 거리 유지
- 내담자의 성별, 나이, 인종 등의 요인을 반드시 고려

2) 중간 10분

- 치료적 관계에서 환자가 과거의 관계 패턴이 미묘하게 반복되는 것을 내담자가 인식하도록 도움
- 내담자에 대한 상담자의 역전이와 내담자와의 상호작용 특징에 초점
- 공감적 경청
- 온화한 직면
- 존중하는 태도
- 정서적인 유대에 관한 관심, 정직하지만 과도하지 않은 자기 개방
- 끈질기지만 강압적이지 않은 역동적 초점 고수
- 내담자의 두려움과 소망에 대한 민감성
- 내담자와 기꺼이 일련의 새로운 경험을 하려는 자세

3) 마지막 5분

- 상담 과정 정리
- 새로운 경험을 기꺼이 할 수 있도록 독려

4. 단기상담의 기법

1) 내담자-치료자 상호작용

- 내담자와 협력적 관계를 맺으려면, 내담자의 상호작용 패턴과 일치하는 방향으로 움직임
- 모든 치료자는 치료 초기에 내담자의 순환적 부적응 패턴에 빠져들
- 내담자들은 어떤 생각이나 감정을 치료자에게 표현하는 것을 두려워할 때가 많음.
 - 불안을 일으킬 만한 개입을 한 뒤에 내담자가 주제를 바꾼다면, 치료자는 이를 자세히 탐색할 필요
- 치료자가 내담자-치료자 관계와 관련된 부정적 상호작용과 방어적 책략을 적극적으로 다루면 치료 동맹이 개선됨

2) 새로운 경험 제공하기

- 치료 맥락에서 내담자가 자신과 타인을 새롭게 경험하도록 돕기는 쉬운 일이 아님
- 치료자가 새로운 경험을 지지할 경우 내담자가 반응적이지 않거나 거부적일 수 있음.
 - 이는 내담자가 변화를 위해 치료 장면에 왔음에도 불구하고 역기능적인 방식이 과잉 학습되어 있고 매우 친숙하다는 것을 기억할 필요가 있음
- 치료자는 친숙하지만 해를 주는 것과, 낯설지만 잠재적으로 더 도움이 되는 것 사이에 다리를 놓을 필요가 있음

3) 치료자의 개입

- 단기 치료의 치료자는 적극적이어야 하며 때로는 직선적일 필요
- 그렇지만 치료자의 활동이 증가하면 위험도 증가
- 치료자는 내담자의 저항을 깨뜨리려고 해서는 안 됨.
 - 저항은 내담자 자신의 견해에서 세상을 해석하고 이해하려는 최선의 노력일 수 있음

4) 치료 회기의 미시적 분석

- 치료 회기의 미시적 분석은 연구자들이 치료 과정에서 일어나는 일을 알아내기 위해 치료자와 내담자가 나눈 대화를 문장 단위와 구절 단위로 미세하게 나누어 살펴볼 때 주로 사용.
 - 이 방법은 임상 기술을 연마하는 데도 아주 큰 도움
- 내담자의 반응, 행동을 예측해보는 훈련은 내담자의 패턴에 대한 이해 수준을 평가할 수 있으며, 치료자 반응의 적절성도 확인해 볼 수 있다는 점에서 유용

가족상담 I / 13주차 1차시

1. 가족상담의 필요성

1) 가정적 위기

- 가정에는 '위기'가 닥치는 것이 자연스러움
- 가족구성원의 상실, 사기의 하락 또는 가정 내 평화가 깨질 때 발생
 - 예) 자녀의 사망, 배우자의 외도, 자녀의 비행 등

2) 문제가족의 발생

- 문제가 있는 가족구성원임
- 정신병리와는 다름
- 적응의 문제, 가족구성원과의 반복적인 갈등 등이 해당
 - 예) 부부갈등, 지속적인 불안을 호소하는 자녀

3) 가족관계 및 의사소통의 문제

- 가족 중 어느 두 사람의 관계 때문에 다른 사람이 계속 긴장과 소외감을 가질 경우
- 가족 구성원 모두 소통이 되지 않고 잦은 오해 반복되는 경우
- 밖에 있을 때보다 가정 내에서 긴장과 불편감을 더 많이 느끼는 경우
- 가족 구성원 중 한 사람이 '문제'라고 생각되어 다른 식구들과의 관계가 계속 불안정한 경우
- 가족 구성원 중 한두 사람의 존재(위치)가 갑작스럽게 변화함으로써 가족 전체에 불안을 가져올 경우
- 가정에 중대한 영향을 미치는 외부 사건의 발생으로 가족 구성원 전체가 긴장 속에 빠져 있을 경우

2. 가족상담의 원리

1) 가족체제의 문제성

- 가족의 '문제'는 한 사람에 대한 정신병리학적 관점보다 다른 가족구성원들과의 관계에서 이해되고 다루어짐
 - 즉, 가족 중 한 사람의 문제는 가족 전체의 문제성을 반영하는 것으로 간주
 - 예) 아이가 문제행동을 일으켰다 잠잠해지면 부부갈등이 발생

2) 문제 원인으로서의 가족관계

- 가족관계는 가족구성원들의 내면적인 심리의 산물이기보다는 내면적 심리과정이 가족관계의 산물
 - 예) 남편이 아내로부터 심리적으로 학대받고 있다면, 이는 아내를 구원하고 변화시킬 수 있는 사람은 자신뿐이라는 남편의 소망을 파악하는 것이 내면적인 심리의 산물을 살펴보는 것. 그러나 가족상담에서는 부부관계 또는 가족관계가 공격, 수용 등의 행동을 만들어내고 있다는 것에 집중

3) 현재 상황에 초점

- 현재의 상황을 이해하기 어렵거나 과거의 맥락이 파악이 되기에 상담이 진행될 수 있다고 판단될 경우에만 과거의 사건이나 경험을 구체화
- 현재 발생하는 양상은 과거에서부터 지금까지 반복되어 있다는 전제 아래 현재의 향상에 상담의 초점을 맞추는 것

4) 진단에 앞서 관심사의 처리

- 가족상담에 대한 구성원들의 기대를 알아보고 현재의 가장 큰 관심사를 이해, 수용하는 것이 필요함
- 가족문제에 대한 자세한 진단과 평가보다는 현재 해소하고자 하는 문제가 무엇인지 파악하는 것이 중요함

5) 감정노출보다 생산적 이해

- 가족관계에서의 부정적인 감정을 여과없이 노출시키거나 내면적 욕구를 분석하기보다, 비효과적인 행동과 심리를 이해하는 방향이 필요
- 가족상담에서 가족 구성원들이 서로를 얼마나 싫어하고 불만스러워하는지를 사실화하고 표현하는 것이 중요하지 않음
- 가족상담은 문제가 발생하는 상호작용과 관계적 어려움을 해소한다는 명제에서 출발하는 것이 중요
- 효과적인 행동이 무엇이었는지 이해하고 이러한 행동이 발생한 맥락을 이해함

6) 가족생태 및 행동양식의 발달

- 가족생태의 변화와 구체적인 행동변화가 중요함
- 생태적 변화나 행동의 구체적 변화는 가족관계가 변하지 않는다면 다른 접근법을 시도하기 위한 상담자의 노력을 의미함

7) 의사소통체계의 변화

- 비효과적인 의사소통을 변화시키는 것에 집중함
- 의사소통은 표면적 의미와 상대방에 대한 정서적 의미를 포함함
- 5가지 의사소통양식
 - 표면적 의미가 동의적인 것과 정서적 의미가 기쁘게 하거나 회유적인 것
 - 표면적 의미가 이의적인 것과 정서적 의미가 공격적인 것
 - 표면적 의미가 화제를 바꾸는 것과 정서적 의미가 무관심하거나 후회적인 것
 - 표면적 의미가 합리적인 것과 정서적 의미가 관용적인 것
 - 표면적 의미가 자기에 관한 보고인 것과 정서적 의미가 다른 사람을 위해 자리를 만들어 주는 것
- 5가지 의사소통 양식 중 (5) 표면적 의미가 자기에 관한 보고인 것과 정서적 의미가 다른 사람을 위해 자리를 만들어 주는 것이 가장 바람직함
- (1)~(4) 유형의 의사소통방식을 (5) 유형으로 변화시키는 것이 목적

3. 가족상담의 도입 및 진행

1) 가족사정: 가족의 발달단계와 가족기능에 대한 측면 고려할 필요가 있음

(1) 가족의 발달단계

- 가족이 경험하는 대부분의 임상적 문제는 어떤 발달단계에서 다음 단계로 이행할 때 생기는 어려움과 관련됨
- 가족이 보이는 문제행동을 발달단계와 관련된 과도기의 문제라고 생각한다면, 치료자는 어떻게 하면 이행이라는 발달과정을 촉진 또는 원조할 수 있는지 파악하는 것이 중요함
 - 예) 가족형성 단계, 어린 자녀를 가진 단계, 청년기 자녀의 단계, 자녀의 자립단계, 조부모의 세대

가족생활주기의 단계	특징	변화
가족 형성 단계	새로운 가족체계의 출발	- 부부체계의 형성 - 친확대가족이나 친구들이 배우자를 수용
어린 자녀를 둔 가족	가족체계 내의 새로운 구성원 수용	- 자녀를 포함한 부부체계의 재구성 - 부모로서의 역할수행 - 부모 또는 조부모의 역할을 포함하는 확대가족 관계회복
사춘기의 자녀를 둔 가족	자녀의 자립을 인정해 주는 가족경계의 확대	- 사춘기 자녀가 가족체계 안과 밖을 자유롭게 드나다는 것을 허용하는 형태로 부모자녀관계 이행 - 중년의 부부문제나 직업 등의 발달 과제에

		대한 재인식 - 노년세대에 대해 배려하는 방향으로 관심의 이행
자립하는 자녀를 둔 가족	가족체계 밖에서 생활하거나 가족체계에 새롭게 참가하는 가족의 다양화 현상	- 둘만의 부부체계의 새로운 협력 - 성장한 자녀와 부모 사이의 관계가 성인과 성인이 맺는 관계로 이행 - 자녀의 배우자와 손자를 포함한 형태의 가족관계 회복 - 부모 또는 조부모의 신체적, 정신적 장애나 죽음에 대한 대처
노년기를 보내는 가족	세대에 따른 역할변화의 수용	- 자신 또는 부부의 기능 유지와 육체적 쇠약에 대한 관심 - 새로운 가족관계 또는 사회적인 역할 탐색 - 중년세대가 보다 중심적인 역할을 하도록 지지 - 연장자의 지혜와 경험을 가족체계 속에서 살리는 기회 형성 - 배우자, 형제, 동료의 상실에 대응, 자신의 죽음을 준비, 인생의 통합

(2) 가족의 기능

① 의사소통

- 가족 내에서 정보가 어떻게 교환되는가 하는 것.
- 의사소통에는 보고수준과 요구수준
- 예) 피곤하다는 두 가지 수준 모두 포함
- 요구수준의 의사소통에 지나치게 집착하면 명확한 의사소통에 어려움. 명료한 의사소통이 바람직

② 가족의 역할

- 개인이 가족기능을 충족시키기 위해 반복적으로 일어나는 행동유형.
- 적절한 역할 배분 필요.
- 역할분담의 형태는 적절, 부적절, 공공연, 암암리에 이루어질 수 있음. 건강한 가족일수록 가족기능이 대부분의 가족을 충족시킬 수 있으며 역할의 분담과 책임도 명백.
- 가족의 역할은 가족구성원이 건강하게 기능하기 위한 필수적 기능과 그 밖의 가족기능이 있음
 - 필수적 기능: 물질적인 자원 마련, 양육, 성적만족, 생활을 위한 기본적인 기술획득
 - 그 밖의 가족기능: 특정의 가족에게 특별히 기능하는 것.(예: 가족성원 중 한 명을 우상화시키거나 반대로 희생양으로 만드는 것)

③ 정서적 반응성

- 가족이 주어진 자극에 따라 적절한 내용과 적절한 양의 감정으로 반응할 수 있는 능력

- 가족성원이 경험하는 정서를 의미함
- 효과적인 정서생활은 질적 또는 양적인 면에서 모두 적절한 정서적 경험을 할 수 있는 가능성이 있음
 - 안정감: 애정, 편안함, 즐거움과 같은 반응
 - 위기감: 두려움, 비애, 분노, 우울과 같은 정서

④ 상호작용

- 가족 서로에 대한 관심이나 배려의 양과 질의 문제.
- 각 개인의 관심사, 활동, 가치관에 얼마나 관심을 보이는가를 의미.
- 5가지 유형

유형
1. 서로 전혀 상호작용하지 않는 수준으로 서로에게 소원하고 무관심하여 정서적 욕구 충족되지 못함
2. 감정이 배제된 상호작용으로 가족성원 간의 상호작용은 의무감이나 다른 가족의 통제가 필요하거나 단순한 호기심이 있을 때만 이루어짐
3. 자기 도취적 상호작용으로 다른 사람에 대한 관심이 주로 자기 중심적일 때 발생. 즉, 어떤 가족성원이 다른 사람의 일을 진심으로 걱정하거나 보살피는 마음에서보다는 자신의 존재가치를 유지하기 위해 다른 성원과 상호작용
4. 공감적 상호작용. 이는 어떤 문제에 상호작용할 때 상대방이 무엇을 필요로 하는가를 진정으로 이해하고 그 사람과 관계하는 바람직한 상호작용의 상태
5. 공생적 상호작용으로 지나치게 관심을 가져 가족성원의 발달장애를 초래

⑤ 행동통제

- 가족성원은 지금의 상태를 유지하거나 어떤 새로운 상황에 적응하기 위해 다른 가족성원에게 영향을 줌.
 - 이러한 과정 속에서 가족성원의 행동을 통제하는 방법 필요.
- 맥매스터모델에서는 행동통제를 4가지 유형으로 구분

유형
1. 경직된 통제는 어떤 일을 수행하기 전에 어떤 통제가 이루어질 것인가를 예측하기 쉽지만, 가족은 건설적이지 못하고 적응력이 낮음. 일상생활이나 역할을 현재의 상태로 유지하는 데는 도움이 되지만, 어떤 가족성원이 새로운 발달과제에 직면하여 변화를 필요로 하는 상황에 적응해야 하는 경우에는 바람직하지 않음
2. 유연한 통제는 예측가능하며 건설적이고 환경변화에 적절하게 적응. 다소 지지적이며 교육적인 성격을 가지고 있어 가족성원이 그들의 이상이나 규칙을 함께 공유하는 것을 촉진하기 쉬움. 과제달성이 용이
3. 방임적 통제는 어느 정도 예측이 가능하지만 건설적이지 않음. 어떤 일을 준비하거나 실행할 때 힘은 약하고 우유부단하여 의사소통과 역할부담에 문제 발생

4. 혼돈된 통제는 예측할 수 없으며 건설적이지 못함. 때로는 엄격하게 통제하고 또는 자유방임적이 되기 때문에 예측의 어려움. 사건의 변화는 가족을 둘러싼 상황이나 필요에 의한 것이라기보다는 어떤 가족성원의 기분이나 감정에 의해 발생

2) 치료과정의 구조화: 치료과정을 어떻게 운영할 것인가에 대한 지침

(1) 치료자 자신에 대한 이해

- 다른 심리치료에 비해 치료자는 보다 적극적인 역할임
- 치료자는 다양한 가족성원과 만나기 때문에 가족에 대한 역전이가 발생할 수 있음
 - 예) 자신의 권위적인 아버지와의 문제가 해결되지 못한 치료자라면 치료에 참가하고 있는 아버지의 권위적인 태도에 저항

(2) 가족체계의 명료화

- 가족 중에는 어떤 형태의 치료를 받을지 자신들의 확고한 생각을 가지고 오는 경우가 많음
 - 예) 우리 아이에게 필요한 건 자신감이라고 생각해요. 그러니까, 선생님이 이 아이가 자신감을 가질 수 있도록 해주세요
- 이런 경우, 치료자가 수동적이 되어서 가족의 이러한 요구를 받아들인다면 치료 성공 가능성 낮아짐
- 치료 초기에는 치료자가 현재 무엇이 일어나는지 상실하지 않는 범위 내에서 다소는 가족의 관점을 따라가는 것이 필요

(3) 치료에 참가하는 가족범위

- 치료에 참석하는 것에 소극적이거나 거부하는 현상은 치료 초기에 자주 발생함
- 참가를 거부하는 가족성원이 한 사람, 또는 그 이상일 수 있음
- 치료자는 참석을 싫어하는 가족성원의 거부가 가족문제와 연결되어 있을 것이라는 점을 유의할 필요가 있음

(4) 치료계약

- 면담의 횟수와 간격, 시간, 누가 참석할 것인가, 치료 목표, 치료비 등 명료화

3) 면담

(1) 문제의 명료화

- 여기에 왜 왔는가를 질문
- 가족치료에 대한 설명

(2) 가족과 관계형성

- 라포확립 필요
- 2~3회의 면담의 중요한 목적은 라포형성

(3) 치료목표 설정

- 목표를 명확히 할 필요가 있음
- 치료목표는 치료가 진행되면서 수정할 수 있음
- 목표는 어떤 치료에서나 중요하지만, 가족치료처럼 많은 사람이 관여되었을 경우 더욱 중요
- 가족간 합의를 이루는 것이 중요함

(4) 행동변용에 도움이 되는 기법

- 문제의 재정의: 가족이 호소문제에 집착할 경우, 생활의 다른 측면으로 방향 전환
- 보상: 치료자의 칭찬은 가족을 변화시키는데 도움됨
- 직면: 치료자와 내담자의 관계가 적절한 충격과 완충상태를 제공해 주 수 있는 것으로 발전한 후에 직면 사용하는 것이 가치있음
- 과제: 과제 수행 요구가 효과적일 수 있음

4) 종결

(1) 종결 지표

- 치료 목표 달성
- 치료 목표는 충분히 달성되지 않았지만, 치료가 더 이상 필요하지 않다고 판단될 정도로 가족기능에 변화
- 더 이상 외부로부터의 자원이 필요하지 않다고 판단되는 경우
- 치료자가 공정한 시도를 해 왔음에도 치료의 효과가 없을 경우
- 가족이 치료에 대한 동기를 상실했거나 결여되었을 경우

(2) 종결 방법

- 도입단계: 왜 종결의 문제를 꺼냈는지 치료자가 설명, 또는 가족성원이 설명
- 요약단계: 면담 정리, 성취된 변화와 가족현상 되돌아보기
- 장기적 목표 나누기단계: 가족이 목표에 도달했는지를 어떻게 아는지 이야기. 가족이 앞으로 직면할 수 있는 어려움 예상해보고, 가족의 능력과 심리적 자원으로 그와 같은 곤란을 극복할 수 있는지 나눔
- 추후면담: 치료효과의 지속성을 확인

가족상담Ⅱ / 13주차 2차시

1. 보웬 가족치료

- 정신분석적 원리 및 실제에 직접적인 영향을 받은 치료적 임상 모델
- 보웬은 모든 이론에 관심을 가지면서 치료를 위한 더욱 포괄적인 이론의 기초를 구축하려고 노력
- 의미 있는 변화가 반드시 전체 가족에게서 나타나는 것이 아니라, 나머지 가족성원에 영향을 미칠 수 있는 한 사람의 변화로 전체의 변화가 시작될 수도 있다고 보았음

1) 치료목표

- 행동장애를 증가한 불안의 산물로 봄
- 고립되고 분화되지 못한 가장 상처받기 쉬운 개인이 증상을 발달시키거나 혹은 갈등의 중심이 됨
- 다세대에 걸친 삼각관계화를 이루고 있는 사람을 해방시켜 탈 삼각관계를 꾀하는 것
- 불안을 감소시키고 자아 분화를 증가시키는 것
- 증상은 덜 강조하며, 문제는 개인이 아니라 체계에 내재하고 있다고 간주
- 이상적인 발달은 원가족과 자율적인 분화가 잘 이루어져 있고, 불안이 낮고, 부모가 그들의 원가족과 좋은 정서적 접촉을 할 때 발생

2) 주요개념

(1) 자아 분화

- 정신 내적 측면과 대인관계에 관련된 개념
- 정신 내적 측면에서 자아 분화를 보면 사고와 감정을 분리하는 능력. 분화된 사람은 사고와 감정 사이에 균형을 이룰 수 있으며 자제력이 있고 객관적임
- 대인관계 측면에서 분화를 보면, 자아 분화가 잘 이루어지지 못한 사람은 확고한 자아를 발달시키지 못하고 거짓 자아가 발달하게 되므로, 자신의 일관된 신념을 가지고 자주적이며 독립적인 행동을 하지 못함

(2) 삼각관계

- 이자 관계의 불안을 피하고자 다른 사물이나 인물을 끌어들임
- 삼각관계는 어떤 두 사람이 자신들의 정서적 문제에 또 다른 한 사람을 끌어들이는 형태를 기술하는 개념
 - 예) 부부 갈등, 자녀를 끌어들여 그에게 초점을 맞추면서 긴장 완화
- 긴장이 더해지면 제삼의 인물은 떠나고 네 번째 사람을 끌어들이 수도 있음
- 가족 치료자는 정서적 삼각관계에 연루되지 않으면서 두 사람과 접촉할 필요

(3) 가족 투사 과정

- 부모가 자신의 미분화를 자녀에게 전달함으로써 미분화는 세대를 걸쳐 진행
- 투사 대상이 된 자녀는 부모와 밀착 관계
- 투사는 어느 가정에서나 일어나지만, 분화 수준이 낮은 가정일수록 투사 경향이 심함
- 가족 투사과정은 다음 세대를 희생시키면서까지 이전 세대의 미분화에서 발생한 불안을 경감시키려고 함

(4) 다세대 전수 과정

- 핵가족 안에서 개인뿐 아니라, 여러 세대에 걸친 핵가족을 포함한 정서적 장애
- 다세대 전수 과정은 개인의 자아 분화 수준이 대대로 전달

(5) 출생순위

- 자녀의 출생순위가 가족역할에 미치는 역할
- 동일한 출생순위의 사람들은 비슷한 성격이라는 관점

(6) 정서적 단절

- 한 개인과 자신의 원가족 간의 미분화와 그것과 관련된 정서적 긴장을 설명
- 극심한 정서적 분리의 양상을 의미
- 세대 간의 정서적 융해가 심할수록 정서적 단절의 가능성 높음
- 융해가 심한 사람은 가족과의 정서적 접촉을 회피함으로써 문제를 해결하려고 함
- 고립된 소외에서 오는 불안으로 다른 사람과 관계를 맺으면 또 다른 융해를 초래
- 예) 원가족에서 벗어나고 싶어 충동적으로 결혼한 사람

3) 치료기법

- 가족 중 한 사람을 선정하여 일정 기간 그 사람을 치료함으로써 그 사람이 전체 가족 체계를 변화시킬 수 있다고 가정함
- 질문하기의 기법 자주 사용함
- 질문을 통해 가족성원이 자신의 딜레마를 인식하고, 잘못된 관계에서 자신의 역할을 수정하기 위한 방법을 유도함
- 독특한 치료기법을 가지진 않음
- 치료자의 객관성과 정서적 중립성 강조하면서, 치료자는 '코치'나 '의논 상대'라고 보았음

(1) 탈 삼각관계 가정

- 증상을 제거하거나 변화를 위해 역사적 또는 심리적 요소 발견 필요함
- 자기 부모, 즉 조부모와 같은 확대가족과의 관계를 이해하고 받아들이는 것 중요함
- 치료목표는 자기분화, 즉 중립적인 정서적 관계를 갖도록 함
- 가계도를 자주 사용함
- 가족 체계 내에서 다양한 집단의 지리적 위치 파악
- 자신과 관련된 삼각관계를 인식할 필요
- 치료 기간에 간격을 두는 것이 바람직하다고 보았으며, 치료자와 한 달에 한 번 정도

만남으로써 치료자에 대한 지나친 의존성 해소

(2) 가계도

- 3세대 이상에 걸친 가족성원에 관한 정보와 그들 간의 관계를 도표로 기록하는 작성 방법
- 가족에 관한 정보가 도식화되어 있으므로 복잡한 가족 유형의 형태를 한눈에 볼 수 있음

2. 구조적 가족치료

- 역동적이며, 짧은 면접 과정에서 가족의 문제점, 가족 특유의 양식을 한눈에 파악하여, 가족의 구조를 변화시킴
- 개인을 사회적 존재로 파악하여 개인을 둘러싼 구조에 관심
- 미뉴친을 주축으로 개발된 치료기법

1) 치료목표

- 문제가 역기능적 가족구조에 의해 유지된다고 봄
- 가족구조를 변화시켜 가족의 문제를 해결할 수 있도록 함
- 치료목표는 구조의 변화이며, 문제해결은 체계적 목표의 부산물
- 문제행동의 변화와 향상된 가족기능은 서로 연관된 목표
- 문제행동을 변화시키는 가장 효율적인 방법은 그와 같은 문제행동을 유지하는 가족 유형을 변화시키는 것
- 가족이 서로 지지하면서 개인이 문제행동을 해결하고 성장하도록 촉진
- 가족 체계의 상호교류 규칙을 재구조화
- 세부적인 치료목표는 하위체계 간의 명확한 경계선 설정, 가족 위계질서의 강화, 가족의 실상에 맞는 규칙의 대체

2) 주요개념

(1) 경계선

- 하위체계 간에 사용되는 말.
 - 배우자 하위체계, 부모 하위체계, 형제 하위체계 등이 존재
- 가족의 상호작용과정에 구성원의 누군가가 어떤 방법으로 참가할 수 있는가에 대한 규약
- 애매한 경계선, 명료한 경계선, 경직된 경계선 세 가지로 구분
 - 애매한 경계선: 애매한 경계선을 주로 하는 가족은 가족 체계에 참가하는 것에 대한 규칙이 애매하므로 그 구성원은 모든 문제에 관해 서로 지나치게 얽혀서 필요 이상으로 관여. 밀착된 가족
 - 경직된 경계선: 경계선이 경직되었을 때 가족 구성원은 뿔뿔이 흩어져 버리는데, 이러한 가족을 분리된 가족이라고 부름
 - 명료한 경계선: 정상적인 가족

(2) 제휴

- 가족의 상호작용과정으로 가족 체계의 한 개인이 다른 협력관계 또는 상반된 관계를 하는 것
- 연합과 동맹이 존재
- 연합은 두 사람이 제삼자에 대항하기 위해 제휴
- 동맹은 두 사람이 제삼자와는 다른 공동의 목적을 위해 제휴하는 것으로 반드시 제삼자와 적대관계에 있지 않음

(3) 권력

- 개개인의 가족 구성원이 상호작용과정을 통하여 다른 사람에게 미치는 영향력
- 권력은 가족 성원이 서로 적극적으로 교류하는가 소극적인 교류를 하는가에 따라 달라짐

3) 치료기법

- 구조적 가족 치료자는 가족이 현재 가지고 있는 가족 기능양상의 양적인 문제를 고려함
- 가족은 여러 가지 사태에 대해 동일한 대처 방법만을 고수할 수 없고 여러 가지 대처 방법을 가짐
- 가족의 유연성 또는 경직성을 점검함
- 비밀관성과 일관성을 파악함

(1) 치료과정

- 문제정의 -> 문제에 관한 정보의 수집 -> 가설설정 -> 치료목표의 설정 -> 치료적 개입
- 구조적 가족치료는 한 회의 면담 중에도 위의 과정을 여러 번 반복하면서 가족구조의 변화 시도

(2) 가족과의 교류기법

- 가족이 더 바람직한 교류유형을 발달시킬 수 있는 맥락을 만들어 내는 것이 중요하다는 이론에 근거
- 교류의 창조, 교류와의 합류, 교류의 재구성한 세 가지 범주
 - 교류의 창조: 치료적 효과와 연결될 수 있는 가족 성원 간의 교류를 치료자가 의도적으로 만들어 내는 기법
 - 교류와의 합류: 치료의 목표에 도달하려는 치료자가 창출하는 가족과의 인간적 교류에 관한 기법
 - 교류의 재구성: 더욱 기능적인 가족구조를 향하여 가족 성원 간의 교류유형을 변화시키기 위한 기법

3. 해결 중심적 가족치료

- 1989년대에 등장한 새롭게 등장한 가족치료의 접근법
- 가족이 가진 예외적인 해결에 중점
- 문제보다 가족이 적용해 왔든 또는 적용이 가능한 해결책 등에 초점을 맞추어 질문
- 문제가 무엇인가를 파악하기보다 가족이 원하는 해결이 무엇인가에 초점을 둠

- 세이저와 김인수 부부에 의해 발전

1) 치료목표

- 치료자는 모든 사람은 이미 자신의 문제를 해결할 능력을 갖추고 있다고 믿음
- 가족은 스스로가 설정한 목표에 도달하기 위해 자신이 가진 자원을 활용할 수 있음
- 단지, 가족이 때로는 자신들이 가지고 있는 능력에 대해 상실감을 느낄 때도 있는데 이는 문제가 너무 크게 확대되었기 때문
- 치료자는 내담자가 아직 잘 사용하지 못하는 능력을 찾아 주어야 하며, 나아가 그들의 문제를 다루어 나갈 보다 나은 기술을 이끌어 내 줄 수 있어야 함
- 성공하지 못한 해결방안보다 과거에 이미 성공했던 해결방안에 관해 이야기함으로써, 효과가 없는 것에 몰두해 있는 가족의 생각을 바꿀 수 있게 해야 함
- 가족과 치료자라는 전문적 관계에도 목적이 존재하며 이러한 목적을 파악하는 것이 필요

2) 주요개념

- 인간에 대한 긍정적인 철학
- 어떠한 가족에게도 일상생활에서 성공했던 여러 가지 경험이 있음
- 문제의 목표, 자원, 기대에 초점을 둠
- 한 부분의 변화는 전체 체계의 변화를 가져온다는 체계론적 입장을 지지함
- 가족은 진정 변화하고 협조하기를 원한다고 보았기 때문에, 가족이 변화과정에서 저항을 보인다는 개념을 부정함
 - 만약 가족이 저항을 보인다면, 그것은 치료자의 개입 방법이 자신들에게 적합하지 않다고 느끼기 때문이라고 보았음

3) 치료기법

(1) 가족과 치료자의 관계유형

- 첫 면담에서 가족을 만나면 각 가족 구성원의 유형을 구분
- 고객형, 불평형, 방문형의 세 가지로 구분
 - 고객형: 고객형의 가족은 문제를 해결하기 위해 어떤 것이든 시도하려는 동기가 있는 상태. 고객형의 가족은 자신이 바로 해결책의 한 부분이라고 느끼며 문제해결을 위해 무엇인가 하려는 의지를 보임. 이러한 관계의 가족은 수용적이며 치료 동기가 높으므로 치료자 대부분은 고객형의 관계유형을 원하지만, 실제로 고객형 가족의 비율은 높지 않음
 - 불평형: 가족은 자신을 위해서가 아니고 다른 사람을 위한 목표를 가지고 있을 때 발생. 일반적으로 불평형의 가족은 그들의 불평이나 치료목표를 상당히 구체적으로 기술하지만, 자신이 바로 해결의 실마리를 쥐고 있다고 생각하지 않음. 불평형 가족은 증상을 보이는 가족 성원 때문에 자신이 희생되었다고 생각하여 자신의 힘든 입장과 역할에 관해 이해받기를 원함. 그들은 자신의 위치나 역할을 변화시켜야 한다고는 생각하지 않음. 이러한

관계에서 치료자는 불평형의 가족을 치료받아야 할 대상으로 생각하기보다 치료에 활용할 수 있는 자원으로 생각할 필요. 따라서 치료자는 불평이나 목표에 대해 불평형의 가족과 함께 탐구하기로 합의하며, 그러려고 일부러 해결책을 가져올 수 있는 새로운 관점을 찾아보도록 유도

- 방문형: 치료받아야 한다는 필요성이나 문제해결의 동기가 약한 사람. 치료에 대해 무관심하거나 이끌려 왔다는 사실에 불평. 이들은 일반적으로 배우자나 부모, 또는 교사에게 의해서 의회. 치료자가 방문형의 가족이 다른 사람의 요구와 결정을 따르는 것이 얼마나 힘들었는지 이해해 줄 때, 그들은 자신이 이해받고 있다고 느끼게 됨

(2) 가족과 함께 목표 설정하기

- 가족에게 중요한 것을 목표로 삼기.
 - 가족 성원 각자의 견해를 자유롭게 표현하는 과정을 통해 서로 알도록 하고 가족 간에 동의할 수 있는 영역을 찾아낼 수 있도록 돕는 것도 치료자의 역할임
- 가족이 설정하는 치료목표는 작고 성취할 수 있어야 함
- 구체적이며 명확하고 행동적인 것을 목표. 가족과 치료자는 진행되고 있는 것을 쉽게 평가할 수 있어야 할 필요가 있음
- 목표를 설정할 때는 없는 것보다 있는 것에 관심을 둬
 - 가족에게 지금 하는 어떤 것을 하지 말라고 하기보다는 새로운 어떤 것을 시작하라고 돕는 것이 실현할 수 있는 가능성이 보다 높음
 - 부정적인 단어를 사용하지 않는 목표가 효과적임
- 목표는 끝이 아니라 무언가를 시작하라는 첫 단계라는 인식을 가족에게 줄 필요가 있음
- 가족의 생활에서 현실적이고 성취가 가능한 것을 목표로 함
- 목표를 수행하는 것은 힘든 일이라는 것을 인식시킴

(3) 성공적인 질문기법

- 면담 이전의 변화를 질문함
- 가족 스스로가 인식하지 못한 해결방안을 찾아내는 데 이용함
- 스스로 노력했다는 것과 해결 능력을 인정하고 그러한 사실을 강화하고 확대할 수 있도록 격려함
 - 예외 질문: 가족은 자신들이 많은 성공의 경험하고 있거나 현재도 잘하고 있는 것이 있으면서도, 그것에 대한 인식이 부족. 어려움에만 집착하여 현재 상황을 부정적인 방향으로만 보기 때문. 치료자는 예외적인 상황을 찾아내고 가족의 자원을 이용하여 가족의 자존감을 강화하려고 노력
 - 기적 질문: 문제가 해결된 상황을 상상해 봄으로써 해결하기를 원하는 것을 구체화하고 명료화하는 데 도움이 되는 것. 가족이 긍정적으로 대답하도록 질문하는 것이 중요. 이 질문을 통해 가족 스스로가 기적을 현실화하기 위해 새롭게 행동해야 한다는 것을 암시할 수 있음
 - 척도질문: 문제의 심각성 정도, 치료목표, 성취 정도의 측정 등을 수치로 표현하도록 질문

- 대처 질문: 만성적인 어려움과 위기에 관련된 질문. (예: 제가 봐도 지금은 무척 힘든 상태라고 생각합니다. 그런데 어떻게 더 나빠지지 않고 현재의 상태를 유지하고 있지요?)

위기상담 I / 14주차 1차시

1. 위기상담 특징

- 예기치 않았던 환경적인 자극이나 그 밖의 이유로 위기감을 느끼는 내담자에게 위기상담이 필요함
- 위기 상황은 혼자서 처리하거나 해결해 주기는 힘든 경우가 대부분임

1) 위기상담의 목표

- 급성으로 심화된 내담자의 긴장을 포함한 다양한 심리적 증상 및 고통을 해소
- 내담자가 더 이상 혼란되지 않도록 과거의 정상적인 상태를 회복할 수 있는 적응 수행력의 회복
- 내담자에게 위기의식을 촉발한 환경적인 요인에 대해 이해하도록 돕는 것

2) 위기상담의 요건

- 내담자의 위기 및 긴장감에 대해 공감적인 이해나 경청을 할 수 있는 능력
- 내담자의 환경적인 여건이나 심리적인 반응에 대해 정확히 평가할 수 있는 능력
- 내담자의 문제를 더욱 효과적으로 이해할 수 있는 주변 환경에 대한 충분한 지식의 준비

3) 위기의 단계적 특징 및 유발조건

(1) 위기의 단계적 특징

- ① 처음에는 약간의 긴장을 경험하여 평소의 습관적인 반응으로 대처하는 단계
- ② 전 단계보다 긴장이 증가하여 해소하려고 하는 노력을 해도 실패하는 단계로서, 좌절감과 비능률적인 반응
- ③ 응급수단까지 동원해서 긴장을 해소하려고 하나 긴장이 계속 고조된 단계로서 타인에게 도움을 청하게 되는 상황
- ④ 위급 단계로 행동의 혼란이 증가하고 정서의 통제가 불가능한 단계

(2) 위기 상황의 특징

- 대체로 위기를 촉발하는 사건이나 생활여건의 변동
- 갑자기 위기의식이나 긴장감을 느끼게 되는 특징
- 당사자는 심리적 불편감과 고통을 느낌
- 행동 혼란의 증거들이 나타남

4) 위기감에 대한 접근방법

- 환경 조작
- 일반적인 지원

- 경청, 비판단적인 태도
- 포괄적 해결 노력
- 다양한 방안 모색

2. 자살위기 내담자

1) 자살위기의 정의

- 자살은 의도적으로 자신의 생명을 끊는 행위를 하여 죽음에 이르게 되는 것
- 자살위기가 높다는 것은 자살을 행동으로 옮겨서 죽음에 이르게 될 가능성이 높다는 것

(1) DSM-5 자살 행동 장애

A. 최근 24개월 내에 자살 시도를 하였음.

※ 주의: 자살 시도는 스스로 시작한 일련의 행위로서, 그 당시에는 해당 행동들의 결과로 죽음을 기대하였으며, "그 당시에는"이라는 표현은 어떤 방법을 활용하여 행동을 시작한 때를 의미한다.

B. 그 행동은 비자살적 자해의 기준을 충족시키지 않는다. 즉, 부정적 감정·인지적 상태의 경감을 유도하기 위해서나 긍정적인 감정을 느끼기 위하여 몸의 표면에 자해를 하는 경우는 포함되지 않는다.

C. 자살 사고나 자살 준비 행위에는 해당 진단을 내리지 않는다.

D. 섬망이나 혼란의 상태 동안 시작된 행동은 포함하지 않는다.

E. 정치적 혹은 종교적 목적만을 위해 시작된 행동은 포함하지 않는다.

※ 다음의 경우 명시할 것

- 현재: 최근 시도 이후 12개월이 지나지 않은 경우
- 초기 관해(in early remission): 최근 시도 이후 12-24개월 이내인 경우

2) 자살위기를 높이는 변인들

- 이전 자살 행동
- 현재 자살 관련 요인
 - 자살 생각, 자살 사고와 욕구, 자살 계획과 자살 준비, 자살하고자 하는 의도
- 비자살적 자해
- 정신과적 자해
 - 우울, 불안, 공황 장애, PTSD, 경계선 성격장애, 조현병, 물질 사용 장애, 섭식장애 등
- 친밀감의 좌절과 사회적 고립
- 촉발 사건

3) 자살위기를 낮추는 변인들

- 삶의 이유와 높은 삶의 만족도
- 긍정적인 자아상, 좌절과 혼란에 대한 관용
- 관계와 소속감
- 낙관주의
- 효과적인 대인관계 기술과 문제해결 능력, 적응 능력, 현실검증력

4) 자살위기 내담자를 만나기 전 준비

(1) 상담자의 통념 돌아보기

- 상담자는 자살에 대한 스스로에 대한 통념을 돌아볼 필요가 있음
- 자살에 대한 오해
 - 자살에 관한 이야기하는 사람들은 실제로 행동으로 옮기지 않을 가능성이 높음
 - 자살은 항상 충동적인 행동
 - 지능이 높거나 사회적으로 성공한 사람들은 자살 시도하지 않음
 - 자살 가능성을 가진 사람에게 해줄 수 있는 것은 아무것도 없음

(2) 상담자의 불안 다루기

- 상담자의 불안은 내담자의 자살 가능성을 부정하고 최소화해 자살위기에 대한 적절한 평가 방해
- 불안 수준을 알아차리고 적극적으로 대처하는 것이 필요함

5) 자살 위험 평가

(1) 자살 사고

- 죽음 소망, 수동적 자살 사고
 - 자살하겠다는 생각은 아니지만, '사라지고 싶다'라거나 '내일 아침에 눈 뜨지 않았으면 좋겠다.', '사고로 죽게 되면 좋겠다'와 같은 막연하고 수동적인 방식의 죽음을 바라는 상태.
 - 이 경우 자살하고 싶다는 생각이 확인되지 않으니 자살 사고가 없는 것으로 판단할 수 있겠지만, 결과적으로 죽음과 유사한 상태나 죽음에 이르게 되는 상황을 바란다는 점에서 위험성이 시작
- 적극적 자살 사고
 - 자살하고 싶다는 생각으로, 앞에서 설명한 막연한 죽음에 대한 소망과 대조적으로 스스로 목숨을 끊고 싶다는 내용이 분명하게 드러남
- 자살 방법이나 수단에 관한 생각
 - 더 구체화한 상태. 내용이 구체화할수록 자살 위험도가 높아지기 때문에 자살 방법에 관한 생각 여부를 확인하는 것이 중요
- 자살 계획
 - 자살을 실행할 시간, 장소, 방법에 대해 구체화한 내용

- 자살을 실행하고자 하는 의도
 - 자살 의도는 계획과 실행 사이에 존재하는 중요한 변인.
 - 0~20 혹은 퍼센트와 같은 기준을 활용하여 내담자의 의도가 어느 정도인지 구체적으로 확인

(2) 자살 사고의 강도

- 빈도
- 지속 시간
 - 빈도와는 별개로 매번 자살 사고의 영향을 얼마나 오랫동안 받는지 확인
- 통제 가능성
 - 자살 생각이 떠오를 때 생각을 알아차리고 그만두거나 주의를 다른 데로 돌려서 자살 사고의 영향에서 벗어날 수 있는 능력
- 자살을 행동으로 옮기지 않는 이유

(3) 자살 행동

- 자살 시도
- 중단된 시도

6) 자살 위험에 대한 개입

(1) 안전 계획

- 자살 사고의 촉발 요인을 밝히고 자살 사고의 영향에서 벗어나기 위한 대처 방법 포함
- 내담자가 자살 사고를 촉발하는 요인을 알고, 그러한 요인이 발생했을 때 자살 사고로 이어지는 자동적인 과정을 중단할 수 있는 효과적인 각본을 정함
 - 촉발 요인 및 경고 신호 찾기: 자살 사고를 촉발하는 생각, 감정, 행동, 상황에 대해 탐색하고 명료화
 - 혼자서 대처하는 방법: 자살에 관한 생각이 떠올랐을 때나 자살 사고를 촉발하는 요인이 발생했을 때, 자신을 안정시키거나 긍정적인 자극, 혹은 부정적인 반응을 활성화하지 않는 자극에 주의를 돌리는 방법 찾기
 - 관계나 외부 상황을 활용하는 방법
 - 가까운 사람들에게 도움 요청
 - 24시간 위기 전화할 수 있는 곳 정보제공

(2) 심리교육

- 보호 요인과 위험 요인들, 자살 사고나 충동에 대한 대처 기제와 그 효과에 관해 설명
- 내담자가 스스로 자살위기 수준에 대해 점검해보도록 함

(3) 매 회기 자살 위험 수준과 내담자 대처에 대한 모니터링

- 자살 위험 수준은 내담자의 상황과 대처에 따라 변함
- 매 회기 모니터링을 통해 변화 여부와 내담자 대처 능력을 확인

3. 비자살적 자해 내담자

1) 비자살적 자해의 정의

- 비자살적 자해는 자살 의도가 없는 자해로 자살을 동반하는 자살적 자해와 구분
- 직접적이고 즉각적으로 신체조직에 손상을 가함
- 자살 행동과 자해 행동의 차이점

	자살 행동	자해 행동
유병률	비자살적 자해에 비해 낮음	자살적 자해보다 높음
빈도	제한적 시도	수십, 수백 번 시도
방법	음독, 일산화탄소중독, 목을 맴 등	칼로 긋기, 지지기 등
심각도	치명적인 신체적 손상	의학적으로 치명적이지 않은 신체적 손상

(1) DSM-5 비자살적 자해

- A. 지난 1년간, 5일 또는 그 이상, 신체 표면에 고의적으로 출혈, 상처, 고통을 유발하는 행동(예: 칼로 긋기, 불로 지지기, 찌르기, 과도하게 문지르기)을 자신에게 스스로 가하며, 이는 단지 경도 또는 중등도의 신체적 손상을 유발할 수 있는 자해 행동을 하려는 의도에 의한 것이다(즉, 자살 의도가 없음).
- ※ 주의점: 자살 의도가 없다는 것이 개인에 의해 보고된 적이 있거나, 반복적인 자해 행동이 죽음에 이르게 하지는 않을 것이라는 점을 개인이 이미 알고 있었거나 도중에 알게 된다고 추정된다.
- B. 개인은 다음 중 하나 또는 그 이상의 기대 하에 자해 행동을 시도한다.
1. 부정적 느낌 또는 인지 상태에서부터 안도감을 얻기 위하여
 2. 대인관계 어려움을 해결하기 위하여
 3. 긍정적인 기분 상태를 유도하기 위하여
- ※ 주의점: 개인은 원했던 반응이나 안도감을 자해 행동 도중 또는 직후에 경험하게 되고, 반복적인 자해 행동에 대한 의존성을 시사하는 행동 양상을 보일 수 있다.
- C. 다음 중 최소한 한 가지와 연관된 고의적인 자해 행동을 시도한다.
1. 우울, 불안, 긴장, 분노, 일반화된 고통, 자기비하와 같은 대인관계 어려움이나 부정적 느낌 또는 생각이 자해 행위 바로 직전에 일어남
 2. 자해 행위에 앞서, 의도한 행동에 몰두하는 기간이 있고 이를 통제하기 어려움
 3. 자해 행위를 하지 않을 때도 자해에 관한 생각이 빈번하게 일어남
- D. 행동은 사회적으로 용인되는 것(예: 신체 피어싱, 문신, 종교적 또는 문화적

의례의 일부)이 아니며, 딱지를 뜯거나 물어뜯는 것에 제한되지 않는다.

E. 행동 또는 그 결과는 대인관계, 학업 또는 다른 중요한 기능 영역에서 임상적으로 현저한 고통이나 방해를 초래한다.

F. 행동은 정신병적 삽화, 섬망, 물질 중독 또는 물질 금단 기간에만 일어나는 것이 아니다. 신경발달장애가 있는 개인에게서는 반복적인 상동증의 일부로 나타나는 것이 아니다. 또한 자해 행동이 다른 정신질환이나 의학적 상태로 더 잘 설명되지 않는다(예, 정신병적 장애, 자폐스펙트럼장애, 지적장애, 레쉬-니한 증후군, 자해를 동반하는 상동증적 운동장애, 발모광(털뽑기장애, 피부뜯기장애).

2) 자해 방법

(1) 자해 방법의 심각도

심각도	자해 행동
하	머리카락 당기기, 물기, 상처 딱지 떼기, 할퀴기, 깨물기, 상처 치료하지 않고 방치하기, 때리기 등
중	날카로운 물건을 피부나 손톱에 삽입하기, 부딪히기, 때리기(멍이 들 정도로) 등
상	지지기, 스스로 문신하기, 칼로 긁기, 날카롭거나 거친 물건(사포, 유리조각 등)으로 피부 문지르기, 골절, 피부에 산 떨어뜨리기 등

3) 비자살적 자해의 위험 요인

- 아동기 학대
- 애착 유형
 - 불안정 애착은 안정 애착에 비해 신뢰하는 관계 형성을 어렵게 하며, 대처 능력 저해
- 고통 감내력
 - 고통을 참고 버티는 힘.
 - 고통을 이겨낼 힘이 자신에게 없다는 자기 불신, 평가 절하는 비자살적 자해의 위험 요인

4) 자해의 기능

(1) 정서 조절

- 고통스러운 정서나 인지 상태를 조절하기 위해 자해 선택
- 비자살적 자해를 하는 90% 이상의 사람들이 강렬한 부정 정서를 줄이기 위해 자해를 시작한다는 보고

(2) 자기 처벌

- 주요한 관계에서 학대와 비난을 반복적으로 겪는 경우, 자기 학대 방법을 학습

- 자기 경험을 타당화하기보다 비난
- 문제의 원인을 자신에게 돌려 자신을 벌하기 위해 자해 시도

(3) 자기 보호

- 자살을 예방하거나 자신을 보호하기 위해 자해 시도
- 몸에 상처를 내어 타인에게 불쾌감을 줌으로써 자신을 보호

(4) 의사소통 및 도움 호소

- 감정 표현을 억압당하거나 부정당한 환경에서 성장한 경우, 감정과 생각을 적절하게 주장하는데 어려움
- 자기 생각과 감정을 적절한 방식으로 표현할 수 없을 때, 소통과 도움을 요청하기 위해 자해 행동 추구

(5) 감각 추구

- 외상, 우울, 자기정체감 부족으로 인해 무감각해지거나 감정에 둔감해질 때 자해를 통해 감각 회복하려는 시도
- 통증을 느끼고 피를 봄으로써 해리 상태에서 벗어나 깨어있음과 살아있음을 느낌

5) 상담자 개입

(1) 위험 수준 평가

- 초발 연령(낮을수록 위험)
- 방법 및 도구
- 지속 기간
- 빈도
- 에피소드당 손상 수준
- 장소

(2) 자해 기능 이해

- 선행 사건 파악
 - 환경, 생물학적, 심리적(인지, 행동, 정서)
- 사회적 맥락
 - 자해가 혼자 또는 다른 사람들과 함께 이루어지는지 확인
- 보호 요인 파악
 - 상처에 대한 인식, 사회적 지지, 자기 수용, 삶의 목표
- 자해 대처 행동 제안
- 자해 대처 행동 확인 및 평가

위기상담Ⅱ / 14주차 2차시

1. 폭력 피해 내담자

1) 폭력 피해 내담자의 개념

- 대인관계 외상은 관계에서 경험하는 신체적, 성적 정서적 학대뿐만 아니라, 가족 내에서 발생하는 폭력이나 소중히 생각하는 반려동물에 대한 학대 등을 목격하는 것까지 포함
- 외상 사건의 횟수, 시작 시기, 사회적 맥락 등을 고려할 필요
- 성차별, 인종차별, 성소수자에 대한 차별 등 정체성과 관련하여 일상생활에서 경험하는 차별과 억압은 은밀한 외상에 포함

2) 폭력으로 인한 영향

(1) 정서적 어려움

- 불안, 두려움, 강박, 우울, 죄책감, 수치심, 낮은 자존감, 무력감, 자기혐오

(2) 행동적 어려움

- 자살 사고와 시도, 수면장애, 섭식장애, 자해 행동, 약물 남용, 성기능 장애

(3) 급성 스트레스 장애

- 실제적이거나 위협적인 죽음, 심각한 부상, 성폭력에 직·간접 노출 등
- 침습 증상
 - 침습적 기억, 반복되는 외상성 사건과 관련되는 꿈, 플래시백 등
- 부정적 기분
 - 긍정적 감정을 경험할 수 없음
- 해리 증상
- 회피 증상
 - 사건이나 사건과 관련된 기억, 생각, 감정을 불러일으키는 외부적 암시 회피
- 각성 증상
 - 수면 교란, 분노 폭발, 과각성, 집중력 저하, 과장된 놀라 반응
- 진단기준 만족을 위해 최소 3일에서 1개월까지 증상 지속

(4) 외상 후 스트레스 장애

- 실제적이거나 위협적인 죽음, 심각한 부상, 성폭력에 직·간접 노출 등
- 침습 증상
 - 침습적 기억, 반복되는 외상성 사건과 관련되는 꿈, 플래시백 등
- 회피 증상
 - 사건이나 사건과 관련된 기억, 생각, 감정을 불러일으키는 외부적 암시 회피
- 외상 사건과 관련된 인지와 감정의 부정적 변화

- 오상 사건 중 일부가 기억나지 않음
- 자신과 타인, 세계에 대한 부정적 믿음, 외상 사건에 대하여 왜곡된 인지를 통해 자신이나 다른 사람을 비난, 지속적으로 부정적인 감정 상태, 주요 활동에 대해 현저하게 저하된 흥미와 참여, 타인과 사이가 멀어짐
- 각성 증상
 - 분노 폭발, 무모하거나 자기 파괴적 행동, 과각성, 집중력 저하, 과장된 놀람 반응
- 진단기준 충족을 위해 1개월 이상 증상이 지속되며, 사건 이후 최소 6개월이 지난 후 모든 진단기준이 충족될 수 있음

(5) 복합외상

- 외상 후 스트레스 장애의 증상에 더하여 정서 조절 어려움, 의식 변화, 자기 지각의 변화, 가해자에 대한 지각 변화, 타인과의 관계 변화, 의미 체계의 변화와 같은 지속적인 부정적 결과로 이어질 수 있음
- 정서적 어려움
 - 정서 조절 어려움, 감정적 반응 과다, 폭력적인 분노 표출, 스트레스를 받을 때 해리 상태로 들어가는 경향
- 자기 기능
 - 자신이 버려졌다고 지속적으로 믿음
 - 패배감이나 무가치함, 광범위한 영역에서 수치심과 죄책감을 느낌
- 관계 어려움
 - 관계를 유지하거나 타인과 가깝게 느끼는 것이 어려움

3) 2차 피해

- 성폭력의 경우, 성폭력 사건이 일어난 이후에 관련한 사법기관, 가족, 친구, 언론, 여론 등을 통해 피해자에 대한 소문이나 부정적인 반응이 양산되어 피해자가 정신적, 사회적 피해를 보는 것을 의미
- 피해자 비난, 피해자 의심, 합의 중용의 세 가지 방식으로 구체화

4) 상담 개입

(1) 상담자의 고정관념 점검

- 상담자가 사회적 통념을 내면화한 상태에서 이와 일치하지 않는 다수의 내담자가 경험한 피해와 그에 따른 심리적 어려움에 공감하기 어려움
 - 예) 여성의 야한 옷차림과 행동이 성폭력을 유발한다. 가정폭력의 피해자가 일단 가해자를 떠나면 안전해질 것이다. 피해자가 신고하기만 하면 경찰과 사법제도는 이후 학대로부터 피해자를 보호할 것이다

(2) 안전 향상

- 안전한 장소: 내담자에게 편안하고 안전한 느낌이 드는 장소를 떠올리도록 함. 안전한 장소에

머무는 상상을 하면서 신체적 감각과 감정에 집중하도록 함

- 정서적 고통을 분리(그라운딩)

예) “지금 이 방에 집중해 봅시다. 방을 둘러보세요. 어떤 색깔이 눈에 보이나요? 색깔의 이름을 최대한 많이 말해보세요. (내담자가 답을 마치면) 계속해서 방을 둘러봅시다. 시선이 가는 물건이나 형체를 찾아서 묘사해 봅시다.”

- 상담자가 그라운딩 안내 대본을 익숙하고 편안한 목소리로 읽을 수 있도록 연습하기
- 내담자가 상담 중에 짧게 경험해보도록 하여, 내담자가 느낄 수 있는 혼란이나 두려움을 최소화하기
- 상담실 밖에서 그라운딩을 사용할 수 있는 구체적인 상황을 탐색하고 예행연습 해보기
- 연습하는 동안 더 불안해질 수 있다는 것을 알려주고, 불안이 높아지는 경우 중단하고 불안을 먼저 다루기

(3) 안전 계획 세우기

- 안전을 확보하기 위한 대처 방안 논의
- 폭력 상황임을 인식할 수 있는 단서, 위험 상황에서 빠르게 벗어나는 방법, 보호 요청 방법, 지지 요청 방법 등을 내담자와 구체적으로 의논

2. 상실을 겪은 내담자

1) 상실을 겪은 내담자의 개념

- 상실은 가치가 있다고 생각하는 어떤 대상에 가까이할 수 없게 되거나 혹은 더 이상 가치 있는 질이나 목적을 달성할 가능성이 없게 변경되는 실제적 혹은 잠재적 상황임
- 애도는 애정 대상을 상실한 후에 일어나는 마음의 평정을 회복하는 정신 과정을 의미하며, 주로 사랑하던 사람의 죽음(사별)과 관련된 것으로 알려졌지만 모든 의미 있는 상실에 대한 반응으로 광범위하게 쓰임
- 상실은 1차 상실과 2차 상실로 구분함
 - 1차 상실은 초기의 상실, 즉 애도자가 상담에 도움을 청하게 된 주호소 문제와 밀접한 관련이 있으며, 2차 상실은 1차 상실의 결과로 발생하는 상실

2) 상실로 인한 영향

(1) 정서적 차원

- 슬픔, 비통함
- 분노

- 죄책감
- 불안
- 긍정적 경험
 - 고인과의 관계에서 부정적인 경험이 많았거나, 장기적인 간병이나 보호자 역할로 심신이 지친 경우에는 사별 이후 안도감이나 홀가분함 느낌.
 - 하지만 이러한 긍정적 감정들은 고인의 죽음 앞에서 부적절하다고 여겨지기 쉬우며, 애도자에게 죄책감 유발

(2) 인지적 차원

- 고인에 대한 집착
 - 고인을 보거나 고인의 목소리를 듣는 듯한 혼란스러운 경험
- 비현실적인 느낌, 무감각, 멍해짐
- 주의집중의 어려움
- 자책
- 인생의 무상함. 삶의 의미 되짚기

(3) 행동적 차원

- 피로감, 식욕부진, 두근거림, 오한과 떨림, 현기증, 불면 등의 신체적 반응
- 고립과 사회적 철수
- 상실 이전과 다른 행동
- 고인의 죽음이나 부재를 떠올리게 하는 장소 회피
- 몰두와 집착

3) 애도의 단계 및 과제

① 1단계: 무감각과 부인

- 비통과 절망을 피하고자 자기 보호의 기제

② 2단계: 갈망과 찾기

- 상실을 직면하게 되면서 사랑했던 사람이 존재한다는 증거를 찾아내고자 시도

③ 3단계: 혼란과 절망

- 고인과의 애착의 유대가 끊겼다는 사실과 앞선 1, 2단계의 노력이 실패했다는 것을 자각
- 철수와 고립, 피로감과 우울 증상 보고

④ 4단계: 재조직화를 위한 점진적인 움직임

- 영속적인 분리와 고인의 부재에도 불구하고, 삶을 재건해야 할 필요성을 점진적으로 인정

4) 시간에 따른 애도 반응의 변화

- ① 고인이 사망한 후 48시간: 사망으로 인한 충격이 극심하고 죽음을 강하게 부인
- ② 첫 일주일: 장례식을 치르고 정리해야 할 일들을 처리하느라 기계적으로 움직이게 되며, 이후에는 허탈감과 정신적, 신체적 소진을 겪음

- ③ 2~5주: 가족이나 친구들이 자기 삶으로 돌아가게 되면서 애도자는 버려진 느낌을 받기도 함.
일상으로 돌아간 애도자는 이전과 같은 업무를 수행하기를 기대받는 상황에 처함
- ④ 6~12주: 정서의 폭이 넓어지고 통제감을 상실한 듯한 느낌이 들기도 함
- ⑤ 3~4개월: 기분이 좋은 날과 그렇지 않은 날의 주기가 반복
- ⑥ 6개월: 우울, 기념일, 생일, 명절 등이 특히 힘들 수 있음
- ⑦ 사망 1주기: 정신적 외상이 되거나 해결의 시작이 될 수 있음

5) 애도 평가

- 고인과의 관계의 질
- 죽음을 둘러싼 상황 : 자연사, 사고사, 자살, 피살 등의 죽음의 방식
- 지지체계
- 성격 특성
- 스트레스 대처 양식
- 이차적 상실

6) 상담 개입

(1) 애도에 대한 점검

- 고인과의 관계의 질, 죽음의 상황, 스트레스 대처 양식, 종교적·영적 배경, 공존하는 스트레스, 2차 상실 등
- 상실의 현실 수용 정도, 상실의 고통 견어내기, 고인을 잃은 환경에 적응 수준 파악

(2) 애도에 대한 교육

- 애도 과정에 대한 설명
- 정서적, 인지적 어려움이 극심한 애도자는 자신이 미쳐가는 것은 아닌가 불안해하기도 하는데, 이러한 경험에 대한 타당화 중요

(3) 상실 직면

- 고인의 죽음을 받아들일 수 있도록 도움

(4) 죄책감 다루기

- 죄책감은 애도자를 매우 고통스럽게 하며 자기 비난으로 이어져 우울감을 심화시킬 수 있으므로, 애도자의 죄책감을 경청하되 현실검증을 돕는 것이 필요

(5) 지지자원의 확인 및 연결

- 상의하거나 이야기 나눌 수 있는 자원 확인
- 자원이 없다고 생각할 경우, 믿을만한 대상을 함께 탐색하거나 상담자가 공적인 지지체계 내에서 애도자에게 도움을 줄 방법이 있는지 찾아보고 안내

3. 성소수자 내담자 – 아웃팅, 혐오폭력

1) 성소수자의 개념

- 사회에서 다수를 차지하는 사람들과는 구별되는 성적지향 또는 성별정체성을 가진 사람 또는 집단
 - 성적지향: 레즈비언, 게이, 양성애자, 범성애자, 무성애자 등
 - 성별정체성: 트랜스젠더, 바이젠더 등

2) 성소수자 관련 진단의 변화

※ DSM-5와 ICD-11에는 개인의 성적지향이나 성정체성은 질병이 아님을 명시하고 있음

DSM- I (1952) ~ DSM- II(1968)	(가) 동성애(Homosexuality)가 사회 병리적 인격장애(Sociopathic Personality Disorder)의 성도착증으로 분류
DSM- II (1973)	(나) 동성애를 질병 목록에서 삭제 (다) 성적지향장애(Sexual Orientation Disturbance: for people "in conflict with" their sexual orientation)라는 분류가 생김
DSM- III (1980)	(라) 자아이질적 동성애(Ego-dystonic homosexuality)라는 분류가 생김
DSM- III-R (1987)	(마) 동성애를 심리적 문제로 보는 관점이 완전히 삭제됨 (바) 자아이질적 동성애(Ego-dystonic homosexuality)가 질병분류에서 삭제되고, 명시되지 않은 성적 장애(sexual disorder not otherwise specified)가 생김. 여기에는 '성적지향에 대한 지속적이고 현저한 고통'의 개념이 포함됨
DSM-5 (2013)	(사) 성별 위화감(Gender Dysphoria) 분류가 생김. 성별 위화감은 지정 성별(출생 시의 법적 성별)과 본인이 정체화한 성별이 불일치함에 따라 생기는 불쾌감을 뜻함. 이는 트랜스젠더의 정체성 자체는 장애가 아니지만, 성별 위화감으로 인해 트랜스젠더가 느낄 수 있는 고통에 대해서는 치료가 필요하다는 것을 의미함
ICD-9 (1977)	(아) 동성애를 정신의학적 질환으로 분류
ICD-10 (1992)	(자) 동성애를 분류에서 삭제 (차) 자아이질적 동성애(Ego-dystonic homosexuality)라는 진단 분류가 있지만, 이는 자신의 성적지향이 무엇인지 확실히 알고 있음에도 그것을 수용할 수 없어서 겪게 되는 고통을 의미하여 이에 대한 치료의 필요성과 관련됨. 자아이질적 성적지향의 상위 항목인 F66 '성적 발달 및 지향과 관련된 심리, 행동적 질환'에서 '성적지향 자체는 질병이 아님'을 명시함

ICD-11 (2018)	(카) 자아이질적 동성애(Ego-dystonic homosexuality) 삭제 (타) 성전환증, 성정체성장애 등의 정신 및 행동장애로 분류된 진단들이 성별 불일치(Gender Incongruence)로 수정. 또한 정신 및 행동장애 질병 분류가 아닌 성적 건강 관련 항목으로 분류됨. 이는 지정성별 과 정체화한 성별의 차이로 인한 괴로움에 대한 치료가 필요하 는 것을 의미
------------------	--

3) 성소수자 정신건강

- 성소수자의 정신건강에 주요하게 영향을 미치는 요인 중 하나로 소수자로서의 사회적 지위
- 차별, 편견, 낙인은 스트레스를 유발
- 소수자 스트레스: 소수자이기 때문에 받는 사회적 편견과 관련된 것으로 독특하고 장기적이며 사회적

4) 아웃팅

- 성소수자의 성적지향, 성별정체성 등을 당사자의 의지와 무관하게 타인에게 공개하는 행위
- 커밍아웃을 한 성소수자라 할지라도 제한적인 대상에게만 커밍아웃하는 경우가 많음
- 아웃팅은 성소수자들이 커밍아웃하기 어려운 사람이나 집단을 대상으로 이루어진다는 점, 준비가 되지 않은 상태에서 성정체성이 밝혀진다는 점에서 폭력적
- 정체성이 밝혀졌을 때 사회와 가족으로부터의 거부, 부모의 금전적 지원 상실, 배척, 괴롭힘, 따돌림, 폭력 등의 불이익과 억압을 당할 가능성이 높다는 점에서 유해
- 아웃팅은 동료, 가족, 친구에서부터 더 큰 범위인 대중을 대상으로까지 모든 사회적 수준에서 발생할 수 있음

5) 혐오폭력

- 성소수자를 향한 혐오폭력은 광범위한 형태로 존재
- 개인이 지닌 편견에서부터 이를 겉으로 드러내는 혐오 표현, 행동으로 나타내는 차별, 성소수자의 신체와 정신에 심각한 손해를 입히는 혐오 범죄

6) 아웃팅, 혐오폭력의 영향

- 신체적 변화: 자율신경계의 각성
- 인지적 변화: 집중의 어려움, 경직된 사고, 세상에 대한 불신
- 정서적 변화: 둔감화, 분노, 억울함, 죄책감, 불안감, 무기력감, 초조함, 상실감
- 행동적 변화: 성마름이나 분노, 불신의 태도, 외부로부터 철수

7) 상담 개입

- (1) 사건이 내담자에게 미친 영향 이해

- 아웃팅 또는 혐오폭력에 대한 내담자의 감정과 생각 표현하도록 도움

(2) 위험 수준 확인

- 자해, 자살, 타해 등과 같은 위험성이 있는지를 평가하는 것 필요
- 주변의 사회적지지 체계 확인
- 믿을만한 사람들에게 지지와 도움을 받을 수 있도록 격려

(3) 심리적 안정화

- 호흡법, 근육 이완법, 안전한 장소 떠올리기 등의 심리적 안정화 기법으로 내담자가 정서적 안정감을 느끼도록 도움
- 내담자가 격렬한 심리적 반응을 보이며 진정되지 않는 경우, '지금-여기'에 주의를 돌리도록 함

(4) 대처 방안 모색

- 문제를 감당할 수 있는 작은 부분으로 나누고, 한 번에 한 개씩 다룸
- 대책을 찾기 위해 다양한 방법을 탐색해보고 시도할 수 있도록 격려
- 법률 자문, 연계할 수 있는 사회적 자원 모색